

## *Buku Ajar*

# **KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI** *METODE, KONSELING, DAN EFEK SAMPING*

Nur Aliyah Rangkuti • Ristina Rosauli Harianja • Nevia Zulfatunnisa • Widya Rahayu  
Ana Lestari • Agustina Mar'atus Sholichah

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



# **BUKU AJAR: KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI: METODE, KONSELING, DAN EFEK SAMPING**

## **Penulis:**

Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb., M.KM.

Ristina Rosauli Harianja, S.Tr.Keb., Bdn., M.K.M

Nevia Zulfatunnisa, SSiT., M.Kes., M.Keb

Widya Rahayu. S.Tr.Keb., M.Keb.

Ana Lestari, S.ST., M.Kes.

Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.

## **Editor:**

Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

# **Buku Ajar: Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping**

## **Penulis:**

Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb., M.KM.  
Ristina Rosauli Harianja, S.Tr.Keb., Bdn., M.K.M  
Nevia Zulfatunnisa, SSiT., M.Kes., M.Keb  
Widya Rahayu. S.Tr.Keb., M.Keb.  
Ana Lestari, S.ST., M.Kes.  
Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.

## **Editor:**

Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

**Desain Sampul:** Ivan Zumarano

**Penata Letak:** Helmi Syaukani, S.Pd.

**ISBN:** 978-634-7927-16-3

**Cetakan Pertama:** September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2026**

**by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

## **PENERBIT:**

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

**Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025**

# PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar “Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping” dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran yang diharapkan mampu memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memahami pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, aman, bermutu, dan berpusat pada klien.

Keluarga berencana merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan reproduksi yang berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan KB tidak hanya berkaitan dengan pemilihan metode kontrasepsi, tetapi juga mencakup proses konseling, seleksi kelayakan klien, pemantauan efek samping, pencegahan komplikasi, edukasi kesehatan reproduksi, serta sistem manajemen pelayanan yang efektif. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki pemahaman yang benar dan keterampilan yang memadai agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, hak, dan keselamatan klien.

Buku ajar ini membahas berbagai topik penting, antara lain kontrasepsi dalam rahim atau AKDR/IUD yang meliputi seleksi klien, prosedur pemasangan, serta pencegahan komplikasi; kontrasepsi pascapersalinan dan pasca keguguran yang mencakup waktu pemberian, hubungan dengan laktasi, dan tindak lanjut; serta penanganan efek samping dan komplikasi KB seperti perdarahan tidak teratur, nyeri, dan tanda bahaya yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, buku ini juga menguraikan kontrasepsi pada kondisi khusus, seperti remaja, perempuan perimenopause, klien dengan penyakit kronis, serta kelompok risiko tinggi.

Pembahasan dalam buku ini juga dilengkapi dengan materi pencegahan infeksi menular seksual dan HIV dalam pelayanan KB melalui skrining risiko, edukasi, dan rujukan yang tepat. Tidak kalah penting, buku ini memuat manajemen pelayanan KB yang mencakup logistik, pencatatan dan pelaporan, mutu pelayanan, serta keselamatan klien. Dengan cakupan tersebut, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menunjang praktik pelayanan kesehatan reproduksi di berbagai tatanan pelayanan.

Penyusunan buku ajar ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi. Materi disajikan secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat digunakan dalam proses perkuliahan, diskusi, praktik laboratorium, maupun praktik lapangan. Diharapkan buku ini mampu

mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, komunikatif, etis, dan responsif terhadap berbagai permasalahan dalam pelayanan keluarga berencana.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ajar ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pendidik, tenaga kesehatan, dan pihak-pihak yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Indonesia.

**Juli 2026**

Penulis

# DAFTAR ISI

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>PRAKATA .....</b>    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b> | <b>v</b>   |

## **BAB 1 KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR/IUD): SELEKSI KLIEN, PROSEDUR, DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI .....**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| A. Definisi AKDR/IUD .....                                         | 4  |
| B. Jenis AKDR/IUD dan Mekanisme Kerja.....                         | 4  |
| C. Efektivitas, Kelebihan, dan Keterbatasan AKDR/IUD .....         | 5  |
| D. Waktu Pemasangan AKDR/IUD .....                                 | 5  |
| E. Indikasi, Kontraindikasi, dan Seleksi Klien .....               | 7  |
| F. Konseling Pra-Tindakan dan Informed Choice .....                | 7  |
| G. Alat dan Bahan, Persiapan Klien, Provider, dan Lingkungan ..... | 10 |
| H. Nyeri Saat Pemasangan dan Manajemen Kenyamanan Klien.....       | 12 |
| I. Langkah Prosedur Pemasangan AKDR/IUD.....                       | 12 |
| J. Keselamatan Pasien dan Pencegahan Infeksi .....                 | 14 |
| K. Efek Samping Umum, Komplikasi, dan Tatalaksana Awal .....       | 15 |
| L. Tindak Lanjut Pascatindakan dan Dokumentasi .....               | 15 |
| M. Aktivitas 1 — Knows How .....                                   | 17 |
| N. Ringkasan Materi.....                                           | 35 |
| O. Tabel. Red Flags dan Eskalasi pada Pelayanan AKDR/IUD .....     | 35 |
| P. Daftar Pustaka .....                                            | 36 |

## **BAB 2 KONTRASEPSI PASCAPERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN: WAKTU PEMBERIAN, LAKTASI, DAN TINDAK LANJUT .....**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| A. Kontrasepsi Pascapersalinan .....                 | 42 |
| B. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang .....           | 42 |
| C. Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) ..... | 48 |
| D. Kontrasepsi Pasca Keguguran.....                  | 52 |
| E. Mini Case .....                                   | 53 |
| F. Referensi .....                                   | 54 |

## **BAB 3 PENANGANAN EFEK SAMPING DAN KOMPLIKASI KB: PERDARAHAN TIDAK TERATUR, NYERI, DAN TANDA BAHAYA .....**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A. Pendahuluan .....              | 56 |
| B. Pengertian.....                | 57 |
| C. Perdarahan Tidak Teratur ..... | 58 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| D. Nyeri.....                                                                  | 60 |
| E. Tanda Bahaya.....                                                           | 62 |
| F. Cara Membedakan Efek Samping Umum Dengan Tanda Bahaya/Komplikasi....        | 64 |
| G. Algoritme penanganan awal, edukasi, dan rujukan pada keluhan prioritas..... | 65 |
| H. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i> .....                                        | 69 |
| I. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i> .....                                        | 80 |
| J. Ringkasan Materi.....                                                       | 83 |
| K. Referensi .....                                                             | 84 |

## **BAB 4 KONTRASEPSI PADA KONDISI KHUSUS: REMAJA, PERIMENOPAUSE, PENYAKIT KRONIS, DAN RISIKO TINGGI.....87**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| A. Mini Kasus.....                 | 91  |
| B. Ringkasan Materi.....           | 104 |
| C. Alur Asuhan Singkat.....        | 104 |
| D. Tabel Red Flags & Eskalasi..... | 105 |
| E. Referensi .....                 | 106 |

## **BAB 5 PENCEGAHAN IMS/HIV DALAM PELAYANAN KB: SKRINING RISIKO, EDUKASI, DAN RUJUKAN ..... 107**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| A. Konsep Dasar IMS dan HIV.....                               | 110 |
| B. Konsep Pelayanan KB Terintegrasi dengan IMS/HIV .....       | 110 |
| C. Skrining Risiko IMS/HIV dalam Pelayanan KB.....             | 111 |
| D. Edukasi Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB .....         | 112 |
| E. Rujukan dalam Pelayanan KB terkait IMS/HIV.....             | 112 |
| F. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan IMS/HIV .....       | 112 |
| G. Integrasi Pelayanan KB dengan Program HIV/IMS Nasional..... | 113 |
| H. Evidence Based Midwifery (EBM).....                         | 113 |
| I. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i> .....                        | 113 |
| J. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i> .....                        | 114 |
| K. Ringkasan Materi.....                                       | 131 |
| L. Alur asuhan singkat .....                                   | 132 |
| M. Tabel Red Flags & Eskalasi.....                             | 132 |
| N. Referensi .....                                             | 134 |

]

## **BAB 6 MANAJEMEN PELAYANAN KB: LOGISTIK, PENCATATAN-PELAPORAN, MUTU DAN KESELAMATAN. .... 135**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pendahuluan .....                                           | 136 |
| B. Manajemen Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) ..... | 136 |
| C. Manajemen Pencatatan dan Pelaporan .....                    | 141 |
| D. Manajemen Mutu Pelayanan .....                              | 144 |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| E. Keselamatan Klien dan Audit Medik.....                           | 146        |
| F. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i> (Orientasi & Analisis Kasus)..... | 147        |
| G. Aktivitas 2 — <i>Does</i> (Proyek Manajemen Layanan).....        | 149        |
| H. Ringkasan Materi.....                                            | 151        |
| I. Referensi .....                                                  | 152        |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                         | <b>154</b> |

# BAB 1

## KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR/IUD): SELEKSI KLIEN, PROSEDUR, DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI

### CPL

---

CPL berikut disusun berdasarkan ruang lingkup materi AKDR/IUD yang meliputi penguasaan konsep, seleksi klien, konseling, prosedur pemasangan, keselamatan pasien, pencegahan komplikasi, tindak lanjut, dan dokumentasi.

| Kode         | Aspek CPL                     | Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPL 1</b> | Sikap dan profesionalisme     | Mampu menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, serta menghormati hak reproduksi, otonomi, privasi, martabat, dan keputusan klien dalam pemberian pelayanan kontrasepsi yang aman dan berpusat pada klien.                                               |
| <b>CPL 2</b> | Penguasaan pengetahuan        | Mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip klinis pelayanan kontrasepsi yang meliputi mekanisme kerja, efektivitas, indikasi, kontraindikasi, seleksi klien, konseling, prosedur pelayanan, pencegahan infeksi, komplikasi, dan tindak lanjut penggunaan kontrasepsi. |
| <b>CPL 3</b> | Keterampilan klinis kebidanan | Mampu menerapkan keterampilan klinis kebidanan dalam pelayanan kontrasepsi secara sistematis, aman, sesuai standar prosedur, prinsip keselamatan pasien, pencegahan infeksi, dan kewenangan profesi.                                                                   |
| <b>CPL 4</b> | Pengambilan keputusan klinis  | Mampu melakukan pengkajian, analisis data, identifikasi masalah, dan pengambilan keputusan klinis yang tepat dalam pelayanan kontrasepsi berdasarkan kondisi, kebutuhan, preferensi, dan keselamatan klien.                                                            |
| <b>CPL 5</b> | Komunikasi dan dokumentasi    | Mampu melakukan komunikasi terapeutik, konseling, <i>informed choice</i> , edukasi kesehatan, kolaborasi, rujukan, serta dokumentasi pelayanan kebidanan secara efektif, akurat, sistematis, dan bertanggung jawab.                                                    |

## CPMK

| Kode          | Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPMK 1</b> | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar AKDR/IUD yang meliputi definisi, jenis, mekanisme kerja, efektivitas, kelebihan, keterbatasan, dan waktu pemasangan secara tepat.                                                                                                                                 |
| <b>CPMK 2</b> | Mahasiswa mampu menganalisis indikasi, kontraindikasi, kondisi medis, riwayat reproduksi, status postpartum atau pascaaborsi, serta faktor individual untuk menentukan kelayakan klien dalam penggunaan AKDR/IUD.                                                                                          |
| <b>CPMK 3</b> | Mahasiswa mampu melakukan konseling pra-tindakan dan <i>informed choice</i> mengenai jenis AKDR/IUD, manfaat, risiko, kemungkinan perubahan pola menstruasi, nyeri, komplikasi, alternatif metode, serta tindak lanjut dengan menghormati otonomi dan hak reproduksi klien.                                |
| <b>CPMK 4</b> | Mahasiswa mampu menyiapkan klien, provider, lingkungan, alat, dan bahan yang diperlukan dalam pemasangan AKDR/IUD sesuai prinsip keselamatan pasien, aseptis, pencegahan infeksi, privasi, dan kenyamanan klien.                                                                                           |
| <b>CPMK 5</b> | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemasangan AKDR/IUD secara sistematis, aseptik, atraumatik, aman, dan sesuai standar prosedur pelayanan kebidanan.                                                                                                                                              |
| <b>CPMK 6</b> | Mahasiswa mampu menganalisis efek samping, tanda bahaya, dan komplikasi AKDR/IUD, seperti ekspulsi, perforasi uterus, <i>missing strings</i> , perdarahan berlebihan, infeksi, nyeri hebat, dan kehamilan dengan IUD <i>in situ</i> , untuk menentukan tindakan awal, kolaborasi, atau rujukan yang tepat. |
| <b>CPMK 7</b> | Mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dan tindak lanjut pascapemasangan AKDR/IUD yang mencakup perubahan normal setelah pemasangan, tanda bahaya, kebutuhan kontrol, serta keberlanjutan penggunaan metode.                                                                                                 |
| <b>CPMK 8</b> | Mahasiswa mampu mendokumentasikan seluruh proses pelayanan AKDR/IUD, mulai dari hasil pengkajian dan seleksi klien, <i>informed consent</i> , jenis alat, prosedur pemasangan, respons klien, edukasi, hingga rencana tindak lanjut secara lengkap dan akuntabel.                                          |

## Keterkaitan CPL dan CPMK

| Kode CPL     | Rumusan Ringkas CPL           | CPMK yang Mendukung                        |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CPL 1</b> | Sikap dan profesionalisme     | CPMK 3, CPMK 4, CPMK 5, CPMK 7, dan CPMK 8 |
| <b>CPL 2</b> | Penguasaan pengetahuan        | CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 6         |
| <b>CPL 3</b> | Keterampilan klinis kebidanan | CPMK 4, CPMK 5, CPMK 6, dan CPMK 7         |
| <b>CPL 4</b> | Pengambilan keputusan klinis  | CPMK 2, CPMK 3, CPMK 6, dan CPMK 7         |
| <b>CPL 5</b> | Komunikasi dan dokumentasi    | CPMK 3, CPMK 7, dan CPMK 8                 |

## CPMK Utama

| Komponen   | Rumusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPMK Utama | Mahasiswa mampu memberikan pelayanan AKDR/IUD secara komprehensif melalui seleksi klien, konseling dan <i>informed choice</i> , persiapan serta demonstrasi prosedur pemasangan yang aman, pencegahan infeksi, identifikasi dan penatalaksanaan awal komplikasi, tindak lanjut, serta dokumentasi dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, etika profesi, dan pelayanan yang berpusat pada klien. |

## Aktivitas Belajar (Scaffolding)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD), melakukan seleksi klien secara tepat, menjelaskan indikasi dan kontraindikasi, menyiapkan tindakan pemasangan sesuai prinsip keselamatan pasien, mendemonstrasikan prosedur secara sistematis, serta mengidentifikasi komplikasi, pencegahan, dan tindak lanjut pascatindakan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menghubungkan keputusan klinis dengan konseling yang berpusat pada klien, penghormatan terhadap hak reproduksi, pencegahan infeksi, dan dokumentasi yang baik (Curtis et al., 2024; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

### A. Definisi AKDR/IUD

Alat kontrasepsi dalam rahim atau intrauterine device (IUD) adalah alat kecil, fleksibel, dan reversibel yang dipasang di dalam uterus untuk mencegah kehamilan. World Health Organization menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok utama IUD, yaitu copper-bearing IUD yang nonhormonal dan levonorgestrel-releasing IUD yang hormonal; keduanya termasuk metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif dengan kurang dari satu kehamilan per seratus perempuan pada tahun pertama penggunaan (World Health Organization [WHO], 2026). Definisi ini menempatkan AKDR/IUD bukan hanya sebagai alat, melainkan sebagai intervensi klinis yang menuntut penapisan, teknik pemasangan, tindak lanjut, serta komunikasi risiko-manfaat yang adekuat (Curtis et al., 2024).

Dalam pelayanan kebidanan, AKDR/IUD harus dipahami sebagai metode kontrasepsi jangka panjang yang memerlukan konseling komprehensif, informed choice, kemampuan prosedural yang benar, dan pencegahan komplikasi. Provider tidak hanya bertanggung jawab pada keberhasilan insersi, tetapi juga pada seleksi klien yang tepat, kenyamanan klien selama tindakan, deteksi dini komplikasi, dan kesinambungan pelayanan setelah alat dipasang (Nguyen et al., 2024; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

### B. Jenis AKDR/IUD dan Mekanisme Kerja

Secara umum, AKDR/IUD dibedakan menjadi IUD tembaga dan IUD levonorgestrel. IUD tembaga bekerja terutama dengan menimbulkan lingkungan intrauterin yang tidak kondusif bagi fertilisasi, sedangkan IUD levonorgestrel melepaskan hormon progestin lokal yang menyebabkan penebalan mukus serviks, perubahan endometrium, dan perubahan lingkungan intrauterin sehingga kehamilan dapat dicegah (WHO, 2026). Menurut WHO, copper IUD dapat bertahan hingga sekitar 10–12 tahun tergantung produk, sedangkan levonorgestrel-releasing IUD dapat efektif sekitar 3–8 tahun tergantung jenisnya; fertilitas umumnya kembali dengan cepat setelah alat dilepas (WHO, 2026).

Perbedaan karakteristik kedua jenis alat ini penting dalam konseling. Meta-analisis terhadap uji acak terkontrol menunjukkan bahwa levonorgestrel-releasing IUD memiliki kemungkinan lebih rendah untuk dihentikan karena perdarahan banyak dan dismenore dibanding copper IUD, tetapi lebih mungkin dihentikan oleh sebagian pengguna karena amenore atau perubahan perdarahan yang dianggap mengganggu (Liu et al., 2024). Oleh karena itu, pemilihan jenis IUD sebaiknya didasarkan pada preferensi klien, riwayat haid, toleransi terhadap perubahan pola

perdarahan, dan tujuan kontrasepsi jangka panjang (Liu et al., 2024; Curtis et al., 2024).

### **C. Efektivitas, Kelebihan, dan Keterbatasan AKDR/IUD**

AKDR/IUD termasuk metode kontrasepsi reversibel yang paling efektif. Kedua jenis IUD memiliki efektivitas sangat tinggi dengan kegagalan kurang dari satu kehamilan per seratus perempuan pada tahun pertama penggunaan, sehingga secara klinis sebanding dengan metode kontrasepsi jangka panjang lainnya seperti implan (WHO, 2026). Keunggulan utamanya adalah durasi kerja panjang, tidak bergantung pada kepatuhan harian, tidak mengganggu aktivitas seksual, dan cepat reversibel setelah pelepasan (WHO, 2026).

Namun, AKDR/IUD juga memiliki keterbatasan. Tindakan pemasangan dan pelepasan memerlukan tenaga kesehatan terlatih, ruang tindakan yang memadai, serta keterampilan aseptik dan atraumatik. Sebagian klien merasakan nyeri saat insersi, mengalami spotting, kram, atau perubahan pola haid pada periode awal penggunaan. Meskipun komplikasi serius seperti perforasi dan infeksi berat jarang, keduanya harus diantisipasi melalui skrining, teknik insersi yang benar, dan edukasi pascatindakan yang jelas (Curtis et al., 2024; Myo et al., 2023).

### **D. Waktu Pemasangan AKDR/IUD**

Mahasiswa perlu memahami bahwa waktu pemasangan memengaruhi kenyamanan klien, peluang kesinambungan penggunaan, dan profil risiko komplikasi. Pemasangan IUD dapat dilakukan pada periode interval, postaborsi, immediate postpartum, maupun early postpartum, sepanjang klien memenuhi kelayakan medis dan tidak terdapat kondisi yang mengharuskan penundaan. Pemasangan AKDR/IUD postpartum pada prinsipnya aman, tetapi risiko ekspulsi lebih tinggi dibanding pemasangan interval; karena itu, konseling sebelum tindakan harus menjelaskan keuntungan dan keterbatasan tiap waktu pemasangan secara seimbang (Curtis et al., 2024).

#### **1. Pemasangan pada saat menstruasi**

Pemasangan AKDR/IUD dapat dilakukan pada saat menstruasi, terutama pada hari-hari awal hingga pertengahan haid, karena pada sebagian klien serviks cenderung lebih lunak dan terbuka, sehingga tindakan dapat terasa lebih mudah. Selain itu, pemasangan pada saat haid juga membantu meningkatkan keyakinan bahwa klien tidak sedang hamil. Meskipun demikian, menstruasi bukan satu-satunya waktu pemasangan, karena pedoman mutakhir menegaskan bahwa IUD dapat dipasang kapan saja selama kehamilan dapat disingkirkan secara meyakinkan.

## 2. Pemasangan di luar masa menstruasi

AKDR/IUD juga dapat dipasang di luar masa menstruasi apabila tenaga kesehatan cukup yakin bahwa klien tidak hamil. Dengan demikian, pemasangan tidak perlu ditunda hanya karena klien sedang tidak haid. Pendekatan ini penting untuk mencegah keterlambatan pelayanan dan mengurangi hambatan yang tidak perlu dalam akses kontrasepsi. Pada Cu-IUD, pemasangan dapat dilakukan kapan saja bila klien dipastikan tidak hamil. Pada LNG-IUD, kebutuhan kontrasepsi tambahan setelah pemasangan bergantung pada waktu pemasangan dalam siklus menstruasi.

## 3. Pemasangan segera setelah persalinan

AKDR/IUD dapat dipasang segera setelah persalinan, termasuk pada periode *immediate postpartum*, apabila kondisi ibu memungkinkan dan tidak terdapat kontraindikasi. Pemasangan postpartum aman, tetapi klien harus diberi penjelasan bahwa risiko ekspulsi lebih tinggi dibandingkan pemasangan interval. Pada masa ini, keuntungan utama adalah kebutuhan kontrasepsi dapat dipenuhi sebelum klien pulang dari fasilitas kesehatan, tetapi keputusan tetap harus disertai informed choice yang memadai.

## 4. Pemasangan pada masa nifas

AKDR/IUD juga dapat dipasang pada masa nifas. Dalam pedoman CDC, pemasangan postpartum dibagi menjadi periode <10 menit setelah plasenta lahir, 10 menit sampai <4 minggu postpartum, dan  $\geq 4$  minggu postpartum. Semua periode ini pada dasarnya dapat dipertimbangkan, tetapi pemasangan setelah 4 minggu postpartum umumnya memiliki risiko ekspulsi yang lebih rendah dibanding pemasangan lebih dini. Klien tetap harus diberi penjelasan tentang keuntungan, keterbatasan, dan kebutuhan tindak lanjut.

## 5. Pemasangan pasca abortus

AKDR/IUD dapat dipasang segera setelah abortus selesai, baik abortus spontan maupun induksi, selama tidak ada tanda infeksi dan kondisi klien stabil. Pemasangan segera setelah abortus dapat menjadi pilihan yang baik karena pada saat itu dapat dipastikan kebutuhan kontrasepsi klien dan pelayanan dapat diberikan tanpa menunda. Namun, pada septic abortion, pemasangan IUD harus ditunda sampai kondisi infeksi teratasi.

## 6. Pemasangan saat beralih dari metode kontrasepsi lain

AKDR/IUD dapat dipasang segera ketika klien beralih dari metode kontrasepsi lain, asalkan cukup yakin bahwa klien tidak hamil. Dalam situasi ini, klien tidak perlu menunggu haid berikutnya. Pendekatan ini bermanfaat untuk mencegah jeda perlindungan kontrasepsi dan mendukung kesinambungan penggunaan metode.

## E. Indikasi, Kontraindikasi, dan Seleksi Klien

AKDR/IUD dapat dipertimbangkan bagi perempuan yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang, efektif, reversibel, dan tidak memerlukan kepatuhan harian. Penentuan kelayakan harus memperhatikan kondisi medis individual, tujuan reproduksi, status postpartum atau pascaaborsi, riwayat menstruasi, riwayat infeksi genital, riwayat perdarahan abnormal, serta preferensi klien terhadap perubahan pola haid. Perlu diperhatikan bahwa rekomendasi pemilihan kontrasepsi harus membantu provider menghilangkan hambatan medis yang tidak perlu dan mendukung konseling yang berpusat pada klien serta tidak koersif (Nguyen et al., 2024).

Kondisi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut atau penundaan pemasangan meliputi kehamilan yang belum disingkirkan, infeksi genital aktif, demam yang mengarah pada infeksi, perdarahan uterus yang belum jelas penyebabnya, kecurigaan keganasan traktus genital, dan kelainan anatomi uterus yang dapat mengganggu penempatan alat. Pada situasi demikian, insersi tidak boleh dipaksakan hanya demi memenuhi target penggunaan metode. Seleksi klien yang baik harus berujung pada informed choice, yaitu keputusan klien setelah menerima penjelasan yang memadai tentang manfaat, keterbatasan, risiko, alternatif metode, dan jadwal tindak lanjut (Nguyen et al., 2024; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

## F. Konseling Pra-Tindakan dan Informed Choice

Konseling pra-tindakan merupakan inti dari pelayanan AKDR/IUD karena menentukan kualitas keputusan klien sebelum tindakan dilakukan. Konseling yang baik bukan hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga membantu klien memahami kesesuaian metode dengan kebutuhan, kondisi, dan preferensinya. Pelayanan kontrasepsi harus diberikan secara *person-centered* dan *noncoercive*, sehingga konseling perlu mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai, tujuan reproduksi, dan preferensi pribadi klien (Curtis et al., 2024; Nguyen et al., 2024).

### 1. Menjelaskan cara kerja AKDR/IUD

Provider perlu menjelaskan bagaimana AKDR/IUD bekerja dalam mencegah kehamilan, baik pada IUD tembaga maupun IUD hormonal. Penjelasan ini penting agar klien memahami bahwa efektivitas metode tidak bergantung pada kepatuhan harian seperti pil, melainkan pada keberadaan alat di dalam uterus sesuai indikasi penggunaannya (Curtis et al., 2024).

## 2. Menjelaskan lama efektivitas metode

Klien perlu mengetahui bahwa AKDR/IUD termasuk kontrasepsi jangka panjang yang reversibel dengan masa kerja yang berbeda menurut jenis produk. Informasi ini membantu klien menilai apakah AKDR/IUD sesuai dengan rencana reproduksi jangka menengah atau jangka panjang yang dimilikinya (Nguyen et al., 2024).

## 3. Menggali tujuan ber-KB klien

Konseling harus menanyakan alasan klien memilih kontrasepsi, misalnya ingin menunda kehamilan, menjarangkan kelahiran, atau belum ingin menambah anak dalam waktu lama. Penggalian tujuan ini penting karena pemilihan metode seharusnya didasarkan pada kebutuhan reproduksi klien, bukan hanya ketersediaan alat di fasilitas pelayanan (Curtis et al., 2024).

## 4. Menggali pengalaman kontrasepsi sebelumnya

Provider perlu menanyakan apakah klien pernah menggunakan metode kontrasepsi lain, bagaimana pengalaman sebelumnya, dan alasan berhenti atau berganti metode. Informasi ini membantu menilai preferensi klien, toleransi terhadap efek samping tertentu, serta kemungkinan hambatan penggunaan metode jangka panjang (Ismawati et al., 2024).

## 5. Mengidentifikasi kekhawatiran terhadap nyeri saat pemasangan

Kekhawatiran terhadap nyeri merupakan salah satu alasan umum klien ragu menggunakan AKDR/IUD. Oleh karena itu, provider perlu menggali persepsi klien terhadap nyeri, menjelaskan kemungkinan rasa tidak nyaman saat tindakan, dan memberi penjelasan yang jujur namun menenangkan agar klien merasa siap secara psikologis (Curtis et al., 2024).

## 6. Mengidentifikasi persepsi klien mengenai perubahan haid

Klien perlu ditanya apakah ia memiliki kekhawatiran terhadap perdarahan yang lebih banyak, spotting, atau perubahan pola haid lainnya. Hal ini penting karena pola perdarahan dapat berubah sesuai jenis IUD yang digunakan, dan penerimaan klien terhadap perubahan tersebut sangat memengaruhi keberlanjutan penggunaan metode (Nguyen et al., 2024).

## 7. Menilai dukungan pasangan

Dukungan pasangan dapat memengaruhi keputusan penggunaan kontrasepsi dan keberlanjutan metode. Meskipun keputusan tetap berada pada klien, informasi mengenai sikap pasangan penting digali karena dapat membantu provider menyesuaikan strategi komunikasi dan edukasi tanpa menghilangkan otonomi klien (Ismawati et al., 2024).

8. Menilai kondisi sosial yang dapat memengaruhi keberlanjutan penggunaan

Provider juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial klien, seperti akses ke fasilitas kesehatan, kemampuan datang untuk kontrol, tingkat pemahaman, serta adanya tekanan keluarga atau lingkungan. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi keberhasilan penggunaan AKDR/IUD dalam jangka panjang (Curtis et al., 2024).

9. Menjelaskan jenis IUD yang tersedia

Pada tahap informed choice, provider harus menjelaskan jenis IUD yang tersedia, yaitu IUD tembaga dan IUD hormonal, beserta perbedaan umum keduanya. Penjelasan ini membantu klien membandingkan pilihan metode sesuai kebutuhan dan preferensinya (Nguyen et al., 2024).

10. Menjelaskan efektivitas dan durasi penggunaan

Klien perlu memperoleh penjelasan bahwa AKDR/IUD termasuk metode kontrasepsi yang sangat efektif dengan masa kerja panjang. Informasi mengenai efektivitas dan durasi penggunaan penting agar klien memahami keunggulan metode ini dibandingkan metode lain yang memerlukan kepatuhan rutin (Curtis et al., 2024).

11. Menjelaskan kemungkinan perubahan haid setelah pemasangan

Provider harus menjelaskan perubahan haid yang mungkin terjadi setelah pemasangan, seperti haid lebih banyak pada IUD tembaga atau haid yang makin sedikit pada IUD hormonal. Penjelasan ini penting agar klien tidak menganggap perubahan tersebut sebagai komplikasi bila masih dalam batas yang wajar (Nguyen et al., 2024).

12. Menjelaskan kemungkinan rasa nyeri saat dan setelah pemasangan

Klien perlu mengetahui bahwa rasa nyeri atau kram ringan dapat terjadi saat atau setelah tindakan. Penjelasan ini penting agar klien memiliki ekspektasi yang realistis, tidak panik, dan mampu membedakan antara ketidaknyamanan yang wajar dengan gejala yang memerlukan evaluasi lebih lanjut (Curtis et al., 2024).

13. Menjelaskan risiko ekspulsi

Risiko ekspulsi perlu dijelaskan sebagai salah satu kemungkinan komplikasi, terutama pada kondisi tertentu. Klien harus memahami bahwa alat dapat keluar sebagian atau seluruhnya, sehingga perlu dilakukan evaluasi bila ia merasakan perubahan tertentu atau tidak lagi meraba benang sesuai edukasi yang diberikan (Nguyen et al., 2024).

14. Menjelaskan risiko perforasi yang jarang tetapi penting dikenali

Provider juga perlu menjelaskan bahwa perforasi merupakan komplikasi yang jarang, tetapi tetap harus diinformasikan sebagai bagian dari informed choice. Penjelasan ini penting untuk menjaga transparansi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda bahaya pascatindakan (Curtis et al., 2024).

15. Menjelaskan kapan klien harus segera kembali ke fasilitas kesehatan

Klien harus diberi informasi yang jelas mengenai tanda dan gejala yang mengharuskan kontrol segera, seperti nyeri hebat, perdarahan banyak, demam, keputihan berbau, atau kecurigaan alat keluar. Edukasi ini penting untuk mendukung keselamatan pasien dan deteksi dini komplikasi (Nguyen et al., 2024).

16. Mendukung klien membuat keputusan secara sadar

Tujuan akhir konseling bukan hanya agar klien menerima metode, tetapi agar klien dapat membuat keputusan yang sadar, terinformasi, dan sesuai dengan nilai serta preferensinya. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa konseling berbasis informasi dapat meningkatkan sikap positif dan minat akseptor terhadap penggunaan IUD sebagai kontrasepsi jangka panjang, sehingga kualitas konseling menjadi faktor penting dalam penerimaan metode (Ismawati et al., 2024).

## **G. Alat dan Bahan, Persiapan Klien, Provider, dan Lingkungan**

Persiapan sebelum pemasangan AKDR/IUD merupakan tahap yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien, kelancaran prosedur, dan kualitas pelayanan. Persiapan yang baik akan membantu tenaga kesehatan bekerja secara sistematis, mengurangi interupsi selama tindakan, menjaga prinsip asepsis, serta meningkatkan kenyamanan klien selama prosedur berlangsung (Curtis et al., 2024).

1. Persiapan alat dan bahan

Ketersediaan alat dan bahan harus dipastikan sebelum tindakan dimulai. Pada prinsipnya, pemasangan AKDR/IUD memerlukan alat pemeriksaan panggul, instrumen pemasangan sesuai jenis IUD yang digunakan, sarung tangan, antiseptik, bahan dokumentasi, serta perlengkapan tambahan untuk mengatasi reaksi vasovagal atau keluhan akut yang mungkin timbul selama prosedur. Selain itu, ruang tindakan harus memiliki pencahayaan yang memadai agar pemeriksaan dan pemasangan dapat dilakukan dengan aman dan akurat (Curtis et al., 2024).

Kesiapan alat sebelum tindakan sangat penting untuk menghindari keterlambatan, mengurangi gangguan selama prosedur, serta menjaga efisiensi

pelayanan. Bila alat tidak lengkap atau tidak siap digunakan, tindakan dapat terganggu dan berpotensi menurunkan mutu pelayanan maupun keselamatan pasien (Curtis et al., 2024).

## 2. Persiapan klien

Persiapan klien meliputi penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan, kemungkinan rasa tidak nyaman selama tindakan, manfaat dan risiko pemasangan AKDR/IUD, serta kesempatan bagi klien untuk mengajukan pertanyaan. Setelah memperoleh penjelasan yang memadai, klien perlu memberikan persetujuan tindakan secara sadar. Pada tahap ini, tenaga kesehatan juga harus memastikan bahwa klien benar-benar memahami informasi yang diberikan, bukan sekadar menyatakan setuju (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Persiapan klien yang baik tidak hanya bertujuan memenuhi aspek administratif, tetapi juga membangun rasa aman, mengurangi kecemasan, dan mendukung kerja sama klien selama prosedur berlangsung. Dengan demikian, tindakan dapat dilakukan dengan lebih nyaman dan terarah.

## 3. Persiapan provider

Provider harus melakukan hand hygiene, memastikan identitas pasien, meninjau kembali hasil skrining kelayakan, serta memeriksa kelengkapan alat dan bahan sebelum tindakan dimulai. Selain itu, provider juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan nyeri, reaksi vasovagal, atau keluhan lain yang dapat muncul selama pemasangan AKDR/IUD (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Kesiapan provider mencerminkan profesionalisme dalam pelayanan. Seorang provider yang siap secara teknis dan mental akan lebih mampu melakukan prosedur dengan tenang, sistematis, dan aman, serta dapat segera mengambil keputusan yang tepat bila muncul kendala selama tindakan.

## 4. Persiapan Lingkungan dan tindakan

Lingkungan tindakan harus bersih, aman, dan mampu menjaga privasi klien. Ruangan juga harus memungkinkan komunikasi dua arah antara klien dan provider selama prosedur berlangsung. Privasi yang terjaga penting untuk memberikan rasa nyaman kepada klien, sedangkan lingkungan yang tertata baik akan memudahkan pelaksanaan tindakan secara efisien dan aman (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Dengan demikian, keberhasilan pemasangan AKDR/IUD tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh kesiapan alat, kesiapan klien, kesiapan provider, dan kelayakan lingkungan tindakan. Seluruh komponen tersebut

harus dipenuhi secara bersamaan agar pelayanan yang diberikan benar-benar aman, bermutu, dan berpusat pada klien.

#### H. Nyeri Saat Pemasangan dan Manajemen Kenyamanan Klien

Nyeri saat pemasangan IUD merupakan salah satu alasan yang sering membuat klien menolak atau menunda penggunaan metode ini. Tinjauan cakupan tahun 2024 pada perempuan nulipara menunjukkan bahwa pengalaman nyeri selama insersi tetap menjadi perhatian penting, dan kualitas komunikasi provider mengenai ekspektasi nyeri serta pilihan manajemennya sangat memengaruhi pengalaman klien terhadap prosedur (Mukenschnabl et al., 2024). Oleh sebab itu, pembahasan mengenai nyeri harus dilakukan sebelum tindakan, bukan setelah klien berada di meja pemeriksaan.

ACOG pada tahun 2025 menegaskan bahwa pilihan manajemen nyeri untuk prosedur serviks dan uterus di ruang praktik, termasuk pemasangan IUD, perlu dibicarakan secara proaktif. Beberapa anestetik lokal dapat mengurangi nyeri saat insersi, dan pengambilan keputusan bersama penting dilakukan karena respons pasien terhadap intervensi nyeri berbeda-beda. Dalam konteks kebidanan, hal ini berarti provider harus menggunakan teknik atraumatik, komunikasi yang menenangkan, dan strategi kenyamanan yang sesuai kebijakan fasilitas untuk menjaga martabat dan pengalaman klien selama prosedur (ACOG, 2025).

#### I. Langkah Prosedur Pemasangan AKDR/IUD

Pemasangan AKDR/IUD merupakan tindakan klinis yang harus dilakukan secara sistematis, aseptik, dan berpusat pada klien. Keberhasilan tindakan tidak hanya ditentukan oleh berhasil atau tidaknya alat masuk ke dalam kavum uteri, tetapi juga oleh ketepatan seleksi klien, kualitas komunikasi, pencegahan infeksi, teknik pemasangan yang aman, serta edukasi dan dokumentasi setelah tindakan. Oleh karena itu, prosedur pemasangan AKDR/IUD perlu dipahami sebagai rangkaian langkah yang utuh, dimulai dari tahap pra-tindakan, Proses pemasangan, hingga penatalaksanaan pascatindakan.

| No. | Tahap          | Langkah-Langkah                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pra-Pemasangan | Melakukan konseling dan memperoleh informed consent setelah klien menerima penjelasan mengenai tujuan tindakan, manfaat, risiko, kemungkinan efek samping, dan prosedur pemasangan AKDR/IUD. |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  |                   | Melakukan anamnesis dan penilaian kelayakan klien, meliputi tujuan ber-KB, kemungkinan kehamilan, riwayat menstruasi, riwayat obstetri, riwayat infeksi saluran reproduksi, serta kondisi medis yang dapat memengaruhi keamanan tindakan. |
| 3  |                   | Melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul, termasuk pemeriksaan bimanual untuk menilai posisi, arah, ukuran, dan mobilitas uterus.                                                                                              |
| 4  |                   | Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti spekulum, tenakulum, sonde uterus, gunting, sarung tangan, antiseptik, dan kit AKDR/IUD steril.                                                                                        |
| 5  |                   | Menempatkan klien pada posisi litotomi dan memastikan privasi serta kenyamanan klien tetap terjaga selama tindakan.                                                                                                                       |
| 6  | Proses Pemasangan | Melakukan hand hygiene dan menggunakan sarung tangan sesuai prosedur pencegahan infeksi.                                                                                                                                                  |
| 7  |                   | Memasang spekulum secara hati-hati untuk memvisualisasi serviks dengan jelas.                                                                                                                                                             |
| 8  |                   | Membersihkan vagina dan serviks menggunakan larutan antiseptik sesuai protokol fasilitas pelayanan.                                                                                                                                       |
| 9  |                   | Menjepit serviks dengan tenakulum bila diperlukan untuk menstabilkan uterus dan mempermudah insersi.                                                                                                                                      |
| 10 |                   | Melakukan sondase uterus untuk menentukan arah dan kedalaman kavum uteri sebelum alat dimasukkan.                                                                                                                                         |
| 11 |                   | Menyiapkan AKDR/IUD ke dalam inserter dengan teknik steril sesuai petunjuk produk yang digunakan.                                                                                                                                         |
| 12 |                   | Memasukkan inserter ke dalam uterus secara perlahan sesuai arah dan kedalaman yang telah ditentukan pada saat sondase.                                                                                                                    |

|    |                  |                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |                  | Melepaskan AKDR/IUD di dalam kavum uteri sesuai mekanisme alat hingga berada pada posisi yang tepat.                                                              |
| 14 |                  | Mengeluarkan inserter secara perlahan dan hati-hati setelah alat terpasang.                                                                                       |
| 15 | Pasca-Pemasangan | Memotong benang AKDR/IUD sesuai panjang standar, yaitu sekitar 2–3 cm dari serviks.                                                                               |
| 16 |                  | Melepaskan tenakulum dan spekulum secara hati-hati, kemudian menilai ada tidaknya perdarahan atau keluhan akut.                                                   |
| 17 |                  | Melakukan observasi singkat terhadap kondisi klien untuk menilai nyeri, perdarahan, sinkop, atau reaksi vasovagal setelah tindakan.                               |
| 18 |                  | Memberikan edukasi pascatindakan mengenai keluhan yang mungkin timbul, perubahan pola haid, tanda bahaya, dan jadwal kontrol ulang.                               |
| 19 |                  | Melakukan dokumentasi secara lengkap, meliputi hasil penapisan, jenis AKDR/IUD yang dipasang, jalannya prosedur, respons klien, dan edukasi yang telah diberikan. |

Secara keseluruhan, pemasangan AKDR/IUD harus dilakukan secara hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan tidak boleh dipaksakan. Apabila selama tindakan muncul nyeri berat, resistensi yang tidak biasa, perdarahan yang mengkhawatirkan, atau kecurigaan perforasi, maka prosedur harus dihentikan dan klien dievaluasi lebih lanjut. Dengan demikian, tindakan pemasangan AKDR/IUD perlu dipahami sebagai prosedur klinis yang memadukan pengetahuan, keterampilan teknis, komunikasi, dan tanggung jawab profesional.

#### **J. Keselamatan Pasien dan Pencegahan Infeksi**

Keselamatan pasien pada tindakan AKDR/IUD mencakup identifikasi pasien yang benar, penapisan kelayakan, pencegahan infeksi, teknik atraumatik, komunikasi selama prosedur, dan kesiapan menangani keluhan akut. Pencegahan infeksi menuntut hand hygiene, penggunaan alat sesuai standar sterilitas atau desinfeksi tingkat tinggi, minimisasi trauma serviks dan uterus, serta penundaan

tindakan pada kondisi yang mengarah pada infeksi genital aktif. Pelayanan pengaturan kehamilan dalam kebijakan nasional juga harus diselenggarakan secara aman, bermutu, dan terdokumentasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Keselamatan pasien juga berarti tidak memaksakan tindakan yang sulit, tidak mengabaikan keluhan nyeri hebat, dan tidak melanjutkan prosedur saat muncul tanda yang mengarah pada perforasi atau perdarahan signifikan. Provider perlu mengingat bahwa keselamatan tidak hanya menyangkut pencegahan cedera fisik, tetapi juga kenyamanan, privasi, dan perlindungan hak reproduksi klien selama prosedur berlangsung (Curtis et al., 2024; ACOG, 2025).

#### **K. Efek Samping Umum, Komplikasi, dan Tatalaksana Awal**

Efek samping dan keluhan pascapemasangan IUD perlu dibahas secara eksplisit karena sering menjadi alasan kunjungan ulang atau penghentian metode. Pada copper IUD, perdarahan haid dapat menjadi lebih banyak dan nyeri haid dapat meningkat, terutama pada bulan-bulan awal. Penjelasan tentang perubahan pola haid ini harus dipersonalisasi sesuai jenis alat agar klien memiliki ekspektasi yang realistis dan tidak merasa dirugikan oleh perubahan yang sebenarnya masih wajar (WHO, 2026; Liu et al., 2024).

Komplikasi penting yang perlu dikenali mencakup ekspulsi, perforasi uterus, missing strings, nyeri hebat, perdarahan banyak, dan kehamilan dengan IUD in situ. Meskipun komplikasi-komplikasi tersebut jarang, pengenalan dini sangat penting agar tidak terjadi keterlambatan penanganan (Myo et al., 2023). Tatalaksana awal bergantung pada keluhan yang muncul. Kram ringan dan spotting dapat dipantau, tetapi nyeri hebat, perdarahan banyak, demam, sinkop persisten, atau benang tidak teraba disertai gejala lain memerlukan evaluasi lebih lanjut, kolaborasi, dan rujukan sesuai fasilitas. Dalam pendidikan kebidanan, kemampuan mengenali komplikasi dini sama pentingnya dengan kemampuan melakukan insersi yang benar (Curtis et al., 2024; Myo et al., 2023).

#### **L. Tindak Lanjut Pascatindakan dan Dokumentasi**

Pelayanan AKDR/IUD tidak berakhir saat alat berhasil dipasang. Klien perlu diberi penjelasan tentang kemungkinan kram ringan, spotting, perubahan pola haid sesuai jenis IUD, cara mengenali tanda bahaya, dan kapan harus segera kembali. Tindak lanjut yang baik membantu memastikan klien memahami perbedaan antara keluhan yang masih normal dan gejala yang memerlukan evaluasi cepat. (Curtis et al., 2024).

Dokumentasi pelayanan harus memuat hasil seleksi klien, informed consent, jenis alat yang dipasang, waktu tindakan, temuan pemeriksaan yang relevan, jalannya prosedur, respons klien, edukasi pascatindakan, dan rencana kontrol. Dokumentasi bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari keselamatan pasien, kesinambungan pelayanan, serta akuntabilitas profesional provider. Di Indonesia, dokumentasi juga menjadi bagian dari tata kelola pelayanan kesehatan reproduksi yang sah dan dapat ditelusuri.

## M. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Seorang perempuan usia 30 tahun, P2A0, datang ke puskesmas 10 minggu pascapersalinan dan ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Ia masih menyusui, tidak ingin hamil lagi dalam 3–4 tahun ke depan, dan tertarik pada AKDR/IUD karena tidak ingin minum pil setiap hari. Namun, ia takut tindakan pemasangan akan sangat nyeri karena mendengar pengalaman temannya, dan ia juga khawatir IUD dapat “berpindah ke organ lain”. Saat anamnesis, klien menyebutkan haid sebelum hamil cenderung banyak, tetapi saat ini belum kembali haid.

1. Apa masalah utama dan kebutuhan kontrasepsi pada kasus ini?
2. Data apa yang perlu digali lebih lanjut untuk menilai kelayakan AKDR/IUD?
3. Faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih copper IUD atau LNG-IUD?
4. Risiko komplikasi apa yang perlu dijelaskan dalam konseling?
5. Informasi apa saja yang termasuk informed choice pada kasus ini?
6. Apa red flags yang membuat pemasangan perlu ditunda atau klien perlu evaluasi lanjutan?
7. Bagaimana rencana tindak lanjut pascapemasangan bila klien akhirnya memilih IUD?

### Soal OSCE Kebidanan

| No. | Komponen                               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | No. Station                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Judul                                  | Pemasangan AKDR/IUD: seleksi klien, persiapan tindakan, dan edukasi pascatindakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Kasus                                  | Calon akseptor AKDR/IUD dengan kebutuhan kontrasepsi jangka panjang, kekhawatiran nyeri insersi, dan kebutuhan konseling risiko–manfaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | Tujuan                                 | Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kompetensi dalam anamnesis terarah, skrining kelayakan, persiapan tindakan, prosedur pemasangan simulasi, KIE, pencegahan komplikasi, dan perilaku profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Kompetensi                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anamnesis dan seleksi klien</li> <li>2. Skrining kelayakan metode</li> <li>3. Persiapan tindakan berbasis keselamatan</li> <li>4. Prosedur pemasangan AKDR/IUD pada model/simulasi</li> <li>5. KIE dan informed choice</li> <li>6. Pencegahan komplikasi dan tindak lanjut</li> <li>7. Perilaku profesional</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | Soal: skenario dan tugas peserta ujian | <p><b>SKENARIO KLINIK</b></p> <p>Seorang perempuan usia 30 tahun, P2A0, datang ke puskesmas untuk memilih kontrasepsi jangka panjang. Ia tertarik pada IUD, masih menyusui, dan takut nyeri saat pemasangan.</p> <p><b>TUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan anamnesis terarah dan skrining kelayakan.</li> <li>2. Jelaskan pilihan AKDR/IUD, manfaat, keterbatasan, dan kemungkinan efek samping/komplikasi.</li> <li>3. Siapkan tindakan sesuai prinsip keselamatan pasien.</li> <li>4. Demonstrasikan prosedur pemasangan IUD pada phantom/model sesuai urutan yang benar.</li> <li>5. Berikan edukasi pascatindakan dan tanda bahaya yang mengharuskan kontrol segera.</li> </ol> |
| 7   | Instruksi penguji                      | <p><b>INSTRUKSI UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai kartu ujian.</li> <li>2. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi selain yang ditentukan.</li> <li>4. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE.</li> </ol> <p>INSTRUKSI KHUSUS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika peserta menggali riwayat haid, status menyusui, riwayat infeksi, dan tujuan ber-KB dengan benar, PS menjawab sesuai dialog.</li> <li>2. Jika peserta menggali informed choice, penguji menilai apakah peserta mampu menjelaskan manfaat, keterbatasan, nyeri, dan tanda bahaya secara seimbang.</li> <li>3. Jika peserta melakukan langkah prosedural secara benar pada model, penguji menilai urutan, aseptis, dan keselamatan.</li> <li>4. Jika peserta menemukan red flags, penguji menilai apakah peserta menunda tindakan dan menyusun tindak lanjut yang logis.</li> </ol> |
| 8 | Kebutuhan instruksi PS dan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PS berperan sebagai ibu pascapersalinan yang tertarik menggunakan IUD namun khawatir nyeri dan komplikasi.</li> <li>2. PS tampak cemas tetapi kooperatif.</li> <li>3. Jika peserta memberikan penjelasan yang empatik, PS menjadi lebih tenang.</li> <li>4. Jika peserta terkesan memaksa atau meremehkan kekhawatiran, PS menjadi ragu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | Dialog PS                  | <p>Peserta: Selamat pagi, Bu.</p> <p>PS: Pagi, Bu.</p> <p>Peserta: Saya bidan yang akan membantu konseling dan pemeriksaan ibu. Apakah ibu bersedia?</p> <p>PS: Iya, Bu.</p> <p>Peserta: Apa yang membuat ibu datang hari ini?</p> <p>PS: Saya ingin pakai KB yang jangka panjang, Bu.</p> <p>Peserta: Metode apa yang ibu pikirkan?</p> <p>PS: Saya tertarik IUD, tapi takut sakit dan takut berpindah tempat.</p> <p>Peserta: Bagaimana riwayat haid ibu sebelum hamil?</p> <p>PS: Biasanya haid saya cukup banyak, Bu.</p> <p>Peserta: Apakah ibu masih menyusui?</p> <p>PS: Iya, Bu.</p> <p>Peserta: Saya akan jelaskan pilihan dan langkah tindakannya ya, Bu.</p> <p>PS: Iya, Bu.</p>                                                                                                                                                                    |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Kebutuhan manikin | Phantom uterus/serviks untuk pemasangan IUD, spekulum simulasi, tenakulum simulasi, sound uterus simulasi, dan training kit IUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Kebutuhan laboran | Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta phantom, menyiapkan lembar instruksi, dan memastikan station siap digunakan peserta berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | Kebutuhan alat    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja dan kursi konseling</li> <li>2. Tempat tidur/periksa</li> <li>3. Phantom uterus/serviks</li> <li>4. Set alat pemasangan IUD simulasi</li> <li>5. Sarung tangan</li> <li>6. Handrub</li> <li>7. Duk/sarung penutup simulasi</li> <li>8. Lembar instruksi peserta</li> <li>9. Lembar penilaian</li> <li>10. Pena</li> </ol>                                                                                                   |
| 13 | Penulis           | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Referensi         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Curtis et al. (2024). U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2024.</li> <li>2. Nguyen et al. (2024). U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024.</li> <li>3. World Health Organization. (2026). Intrauterine devices (IUDs).</li> <li>4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.</li> </ol> |

### Rubrik Penilaian dan Kelulusan

#### KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data dan Seleksi Klien

| Komponen yang dinilai              | Skoring | Skor |
|------------------------------------|---------|------|
| Tujuan ber-KB dan preferensi klien |         |      |
| Riwayat haid dan perdarahan        |         |      |
| Status kehamilan/pasca persalinan  |         |      |
| Status menyusui                    |         |      |
| Riwayat infeksi/keluhan genital    |         |      |

|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| Riwayat penyakit relevan                      |  |  |
| Riwayat penggunaan kontrasepsi                |  |  |
| Pemahaman dan kekhawatiran klien terhadap IUD |  |  |

Skoring Kompetensi 1:

- 3= jika peserta melakukan seluruh atau hampir seluruh langkah penting dengan benar dan sistematis;
- 2= jika peserta melakukan sebagian besar langkah dengan benar
- 1= jika peserta melakukan sebagian kecil langkah dengan benar
- 0= jika peserta tidak melakukan atau seluruh langkah tidak tepat.

## KOMPETENSI 2. Persiapan Tindakan dan Prosedur

| Komponen yang dinilai                               | Skoring | Skor |
|-----------------------------------------------------|---------|------|
| Menyapa dan menjelaskan tujuan tindakan             |         |      |
| Meminta persetujuan dan menjaga privasi             |         |      |
| Hand hygiene                                        |         |      |
| Menyiapkan alat                                     |         |      |
| Posisi klien benar                                  |         |      |
| Menjaga aseptis                                     |         |      |
| Melakukan langkah pemasangan model secara berurutan |         |      |
| Memotong benang/menutup tindakan dengan benar       |         |      |

### Skoring Kompetensi 2:

- 3= jika peserta melakukan 7–8 langkah dengan tepat dan sistematis
- 2= jika peserta melakukan 5–6 langkah dengan cukup tepat
- 1= jika peserta melakukan 1–4 langkah atau banyak langkah kurang tepat
- 0= jika tidak melakukan.

## KOMPETENSI 3. KIE, Pencegahan Komplikasi, dan Tindak Lanjut

| Komponen yang dinilai                                  | Skoring | Skor |
|--------------------------------------------------------|---------|------|
| Menjelaskan manfaat dan keterbatasan IUD               |         |      |
| Menjelaskan nyeri/ketidaknyamanan yang mungkin terjadi |         |      |
| Menjelaskan efek samping umum                          |         |      |
| Menjelaskan tanda bahaya                               |         |      |
| Menjelaskan kontrol/tindak lanjut                      |         |      |
| Menjawab pertanyaan klien dengan jelas                 |         |      |

### Skoring Kompetensi 3:

- 3= jika peserta melakukan seluruh langkah dengan benar

- 2= jika peserta melakukan 4–5 langkah dengan benar
- 1= jika peserta melakukan 1–3 langkah dengan benar
- 0= jika tidak melakukan.

#### KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

| Komponen yang dinilai           | Skoring | Skor |
|---------------------------------|---------|------|
| Sistematis                      |         |      |
| Empatik                         |         |      |
| Menjaga privasi dan keselamatan |         |      |
| Suara jelas dan tenang          |         |      |
| Percaya diri                    |         |      |

##### Skoring Kompetensi 4:

- 3= jika peserta melakukan seluruh langkah dengan benar
- 2= jika peserta melakukan 4 langkah dengan benar
- 1= jika peserta melakukan 1–3 langkah dengan benar
- 0= jika tidak melakukan.

##### Catatan Penilaian

Setiap komponen pada tabel merupakan indikator observasi. Penguji tidak menjumlahkan skor tiap butir secara terpisah, melainkan memberikan satu skor akhir untuk setiap kompetensi berdasarkan kelengkapan, ketepatan, sistematika, dan kualitas performa peserta.

##### Total Skor dan Kelulusan

Total skor diperoleh dari penjumlahan skor seluruh kompetensi yang dinilai, yaitu Kompetensi 1, Kompetensi 2, Kompetensi 3, dan Kompetensi 4. Rumus total skor adalah:  $K1 + K2 + K3 + K4$ .

(Skor maksimum adalah 12 karena terdapat empat kompetensi dengan skor tertinggi masing-masing tiga, sedangkan skor minimum adalah 0)

### Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

| Tidak Lulus | Borderline | Lulus | Superior |
|-------------|------------|-------|----------|
|             |            |       |          |

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{12} \times 100 =$$

Kategori Nilai

| Rentang Nilai | Kategori    |
|---------------|-------------|
| < 60          | Tidak Lulus |
| 60–69         | Borderline  |
| 70–84         | Lulus       |
| 85–100        | Superior    |

### Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

| Komponen                         | Deskripsi                                                                                        | Contoh pada Bab 8                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode penilaian                 | DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik.               | Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan konseling singkat, seleksi klien, persiapan tindakan, dan/atau asistensi pemasangan IUD sesuai kewenangan lahan.                 |
| Tujuan penilaian                 | Menilai performa nyata mahasiswa pada layanan AKDR/IUD.                                          | Mahasiswa dinilai dari kemampuan menapis kelayakan, menjaga aseptis, berkomunikasi empatik, dan melakukan langkah prosedur atau asistensi secara aman.                         |
| Kasus klinik                     | Kasus dipilih dari pelayanan KB nyata yang sesuai capaian pembelajaran.                          | Klien datang untuk pemasangan IUD interval atau kontrol pascapemasangan dengan keluhan ringan.                                                                                 |
| Aktivitas mahasiswa yang diamati | DOPS menilai tindakan klinik nyata, bukan sekadar diskusi.                                       | Mahasiswa melakukan anamnesis terarah, menyiapkan alat, menjaga privasi, membantu atau melakukan tindakan sesuai kompetensi dan supervisi, lalu memberi edukasi pascatindakan. |
| Aspek yang dinilai               | Persiapan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, keselamatan pasien, dan tindak lanjut. | Pembimbing menilai ketepatan seleksi klien, urutan tindakan, pencegahan infeksi, serta kejelasan edukasi tanda bahaya.                                                         |
| Fokus observasi pembimbing       | Mutu performa nyata mahasiswa saat memberikan pelayanan.                                         | Pembimbing memperhatikan ketepatan keputusan, prioritas keselamatan, kemampuan menjawab keluhan klien, dan                                                                     |

|                     |                                        |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                        | kemampuan menunda tindakan bila terdapat red flags.                              |
| Umpan balik         | Diberikan segera setelah observasi.    | Mahasiswa mendapat masukan tentang teknik, komunikasi, dan keputusan klinik.     |
| Keputusan penilaian | Kompeten / perlu supervisi / remedial. | Keputusan ditentukan dari keselamatan, urutan tindakan, dan ketepatan keputusan. |

**Tabel 1.1**  
**Refleksi Patient Safety pada Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD): Seleksi Klien, Prosedur, dan Pencegahan Komplikasi**

| Komponen                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                       | Contoh pada AKDR/IUD: Seleksi Klien, Prosedur, dan Pencegahan Komplikasi                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hakikat refleksi patient safety | Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan. | Pada kasus AKDR/IUD, mahasiswa merefleksikan bahwa pemasangan tanpa skrining yang baik, tanpa pencegahan infeksi, atau tanpa edukasi yang memadai dapat meningkatkan risiko komplikasi dan menurunkan keselamatan klien.                      |
| Tujuan                          | Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.                                                        | Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti tidak menilai kelayakan dengan cermat, tidak menjaga aseptis, atau tidak menjelaskan tanda bahaya, dapat berdampak besar pada keselamatan klien.                                            |
| Fokus refleksi                  | Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.                                          | Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pelayanan IUD meliputi pemasangan pada klien yang tidak layak, nyeri berat saat tindakan, infeksi, ekspulsi, perforasi, dan keterlambatan mengenali keluhan pascapemasangan.                     |
| Risiko yang diidentifikasi      | Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.                                                                                                    | Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain kegagalan menyingkirkan kemungkinan kehamilan, pemasangan pada kondisi infeksi aktif, teknik insersi yang traumatik, missing strings yang tidak dievaluasi, dan kurangnya edukasi pascatindakan. |
| Tindakan pencegahan             | Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan                                                                                                                                      | Mahasiswa menuliskan pentingnya seleksi klien berbasis kelayakan medis, informed choice, hand hygiene, penggunaan alat sesuai                                                                                                                 |

|                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.                                                                            | standar, teknik pemasangan atraumatik, observasi pascatindakan, dan edukasi tanda bahaya serta jadwal kontrol.                                                                                                                        |
| Pembelajaran mahasiswa                       | Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.    | Mahasiswa menyadari bahwa pada pelayanan AKDR/IUD, ketelitian dalam seleksi klien, komunikasi yang jujur, teknik yang benar, dan kesiapan mengenali komplikasi merupakan bagian penting dari praktik bidan yang aman dan profesional. |
| Makna dalam pembelajaran berbasis kompetensi | Refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kesadaran mutu layanan. | Pada topik AKDR/IUD, refleksi menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mengetahui prosedur pemasangan, tetapi juga memahami bagaimana menjaga keselamatan pasien sebelum, selama, dan setelah tindakan.                                |

**Tabel1.2**

**Case Report pada Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD): Seleksi Klien, Prosedur, dan Pencegahan Komplikasi**

| <b>Komponen</b>     | <b>Deskripsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Contoh pada AKDR/IUD: Seleksi Klien, Prosedur, dan Pencegahan Komplikasi</b>                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hakikat case report | Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam pendidikan kebidanan, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis. | Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang perempuan yang datang untuk pemasangan IUD interval dengan kebutuhan kontrasepsi jangka panjang dan kekhawatiran terhadap nyeri saat insersi. |
| Tujuan              | Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam                                                                                                                                                                                                                                            | Mahasiswa tidak hanya menuliskan data klien, tetapi juga                                                                                                                                         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.                                                                                                       | menjelaskan hasil seleksi kelayakan, alasan pemilihan metode, tindakan yang dilakukan, edukasi yang diberikan, dan perkembangan kondisi klien setelah tindakan.                                                                                                                            |
| Isi laporan                                  | Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus. | Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan bahwa klien usia 30 tahun datang untuk memilih kontrasepsi jangka panjang, masih menyusui, ingin menunda kehamilan, telah melalui skrining kelayakan, memilih IUD setelah informed choice, lalu mendapatkan edukasi pascatindakan dan jadwal kontrol. |
| Fokus penilaian                              | Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.                                                     | Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kebutuhan kontrasepsi klien, hasil seleksi medis, pilihan jenis IUD, risiko nyeri atau efek samping, dan perlunya tindak lanjut sebagai bagian dari pelayanan yang aman.                                                           |
| Nilai edukatif                               | Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.                                                                  | Dari kasus AKDR/IUD, mahasiswa belajar bahwa keberhasilan pelayanan tidak hanya bergantung pada teknik pemasangan, tetapi juga pada kualitas seleksi klien, komunikasi, informed choice, dan pemantauan pascatindakan.                                                                     |
| Makna dalam pembelajaran berbasis kompetensi | Case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.                                                                               | Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep AKDR/IUD, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan pelayanan                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------|
|  |  | kebidanan secara utuh, aman, dan berpusat pada klien. |
|--|--|-------------------------------------------------------|

**Tabel 1.3**  
**Portofolio pada Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD): Seleksi Klien, Prosedur, dan Pencegahan Komplikasi**

| <b>Komponen</b>    | <b>Deskripsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Contoh pada AKDR/IUD: Seleksi Klien, Prosedur, dan Pencegahan Komplikasi</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hakikat portofolio | Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian. | Pada topik AKDR/IUD, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan seleksi klien, menilai kelayakan penggunaan IUD, menjelaskan informed choice, menyiapkan tindakan secara aman, mengenali risiko komplikasi, dan melakukan tindak lanjut pascatindakan sesuai prinsip keselamatan pasien. |
| Tujuan portofolio  | Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.                                                                                                                                                             | Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah mengikuti tindakan pemasangan IUD, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah menerima umpan balik dari dosen atau Clinical Instructor (CI).                                                                              |
| OSCE dan DOPS      | OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.                                                                                                                                     | OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan seleksi klien, persiapan tindakan, dan prosedur pemasangan IUD pada model. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan konseling, skrining kelayakan, membantu pemasangan, atau memberikan edukasi pascatindakan di lahan praktik.       |

|                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catatan kasus singkat        | Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.                           | Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus seorang perempuan usia 30 tahun yang datang untuk pemasangan IUD, hasil seleksi klien, jenis IUD yang dipilih, tindakan yang dilakukan, edukasi pascatindakan, dan rencana kontrol.            |
| Refleksi patient safety      | Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam pelayanan kebidanan. | Mahasiswa merefleksikan pentingnya skrining kelayakan sebelum pemasangan, pencegahan infeksi, teknik atraumatik, edukasi tanda bahaya, dan kewaspadaan terhadap ekspulsi atau perforasi pada pelayanan AKDR/IUD.                    |
| Feedback CI/dosen            | Umpan balik dari CI atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.                                                           | CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan konseling, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam seleksi klien, kesiapan alat, atau ketegasan saat mengenali red flags yang memerlukan penundaan tindakan. |
| Karakteristik penilaian      | Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.          | Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus pemasangan IUD, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai kelayakan klien, menjelaskan prosedur, dan menjaga keselamatan pasien.      |
| Bukti konsistensi kompetensi | Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa                                                                                                           | Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan                                                                                                          |

|                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.                                                                                                                                 | konseling, seleksi klien, membantu prosedur, dan menjelaskan tindak lanjut AKDR/IUD secara aman dan profesional.                                                                                      |
| Makna dalam pembelajaran berbasis kompetensi | Portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi. | Pada topik AKDR/IUD, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori tentang alat kontrasepsi dalam rahim, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata. |

## N. Ringkasan Materi

AKDR/IUD adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang reversibel, terdiri atas copper IUD dan levonorgestrel-releasing IUD. Keduanya sangat efektif, cepat reversibel setelah pelepasan, dan sesuai untuk banyak klien apabila memenuhi kelayakan medis (WHO, 2026).

Keamanan dan keberhasilan penggunaan IUD sangat ditentukan oleh seleksi klien, informed choice, persiapan tindakan, teknik pemasangan yang benar, pencegahan infeksi, pengelolaan nyeri, pengenalan komplikasi dini, serta tindak lanjut pascapemasangan. Komplikasi seperti ekspulsi dan perforasi bersifat jarang, tetapi harus dikenali sejak dini, terutama pada konteks pemasangan pascapersalinan tertentu atau bila muncul keluhan akut (Fassett et al., 2023; Myo et al., 2023).

Dalam pembelajaran kebidanan, pelayanan AKDR/IUD harus dipahami sebagai satu rangkaian asuhan yang utuh, mulai dari konseling hingga dokumentasi. Dengan demikian, keterampilan prosedural tidak dapat dipisahkan dari komunikasi, etik, keselamatan pasien, dan akuntabilitas profesional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

## O. Tabel. Red Flags dan Eskalasi pada Pelayanan AKDR/IUD

| No. | Red Flags                                                                  | Makna Klinis/Etis                                               | Tindakan Eskalasi                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Klien belum disaring kelayakannya, tetapi tindakan akan langsung dilakukan | Risiko insersi pada kondisi yang tidak aman                     | Tunda tindakan, lakukan anamnesis dan penapisan kelayakan secara lengkap.         |
| 2   | Terdapat kecurigaan kehamilan                                              | IUD tidak boleh dipasang sebelum status kehamilan diklarifikasi | Tunda pemasangan, lakukan evaluasi kehamilan sesuai fasilitas.                    |
| 3   | Ada tanda infeksi genital aktif, demam, atau nyeri pelvis akut             | Risiko memburuknya infeksi bila insersi diteruskan              | Tunda pemasangan, evaluasi dan tata laksana infeksi, kolaborasi/rujuk bila perlu. |
| 4   | Klien tidak memahami manfaat, risiko, dan alternatif metode                | Informed choice belum tercapai                                  | Ulangi konseling, gunakan bahasa sederhana, tunda keputusan bila perlu.           |

|    |                                                                       |                                                              |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Klien dipaksa memilih IUD oleh pasangan, keluarga, atau provider      | Pelanggaran autonomi dan etika pelayanan                     | Hentikan tekanan, pulihkan proses pengambilan keputusan berbasis hak klien. |
| 6  | Nyeri hebat atau resistensi tidak biasa saat insersi                  | Dapat mengarah pada prosedur traumatik atau perforasi        | Hentikan prosedur, nilai ulang, pertimbangkan kolaborasi/rujukan.           |
| 7  | Perdarahan banyak saat atau setelah tindakan                          | Dapat menunjukkan trauma serviks/uterus atau komplikasi lain | Stabilisasi, observasi, evaluasi lebih lanjut, rujuk bila perlu.            |
| 8  | Sinkop atau reaksi vasovagal menetap                                  | Risiko ketidakstabilan klien                                 | Hentikan tindakan, posisikan aman, observasi, tata laksana sesuai kondisi.  |
| 9  | Benang tidak tampak disertai nyeri, perdarahan, atau keluhan bermakna | Curiga malposisi, ekspulsi, atau perforasi                   | Evaluasi lanjut, kolaborasi, atau rujuk.                                    |
| 10 | Klien pulang tanpa edukasi tanda bahaya dan kontrol                   | Risiko keterlambatan deteksi komplikasi                      | Berikan edukasi ulang dan rencana tindak lanjut tertulis.                   |

## P. Daftar Pustaka

- Abdullah, A. A., Kaban, L. A., Novianti, D., Hidayat, A., Ongko, N. X., Rosar, N., & Angkasa, C. (2025). Factors influencing family planning acceptors' use of IUD contraception in the working area of Medan Amplas District. *Buletin Kedokteran dan Kesehatan Prima*, 4(1), 199–203. <https://doi.org/10.34012/bkbp.v4i1.7437>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2025). Pain management for in-office uterine and cervical procedures. ACOG Clinical Consensus.
- Curtis, K. M., Tepper, N. K., Jatlaoui, T. C., et al. (2024). U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2024. *MMWR Recommendations and Reports*, 73(3), 1–80.
- Fassett, M. J., et al. (2023). Risks of uterine perforation and expulsion associated with intrauterine devices. *Obstetrics & Gynecology*, 142(3), 530–539.
- Hatta, M., Suarni, Ramadhani, Z. F., Wahyuni, A., & Aminullah. (2024). Faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi IUD pada wanita usia subur di Kabupaten Maros. *Jurnal Mitrasehat*, 14(1), 591–601. <https://doi.org/10.51171/jms.v14i1.448>

- Ismawati, I., Kasmawati, K., et al. (2024). The impact of information-based family planning counseling on IUD adoption as a long-term contraceptive. *Journal of Current Health Sciences*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.
- Liu, P., et al. (2024). Contraception with levonorgestrel-releasing intrauterine system versus copper intrauterine device: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in Medicine*, 11, 1456968.
- Mukenschnabl, K., et al. (2024). Pain management during intrauterine device insertion in nulliparous women: A scoping review. *Cureus*, 16(10), e72423.
- Myo, M. G., et al. (2023). Intrauterine device complications and their management. *Current Obstetrics and Gynecology Reports*, 12, 223–231.
- Nguyen, A. T., et al. (2024). U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024. *MMWR Recommendations and Reports*, 73(4), 1–126.
- World Health Organization. (2025). Family planning/contraception methods.
- World Health Organization. (2026). Intrauterine devices (IUDs).

# BAB 2

## KONTRASEPSI PASCAPERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN: WAKTU PEMBERIAN, LAKTASI, DAN TINDAK LANJUT

### **Tujuan Instruksional Umum (TIU)**

---

Setelah mempelajari Bab 9 ini, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan layanan KB dan tindak lanjut secara aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan klien (metode, edukasi, pemantauan).

### **Tujuan Instruksional Khusus (TIK)**

---

Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran
- Mengidentifikasi macam-macam alat kontrasepsi pasca persalinan
- Mengidentifikasi macam-macam alat kontrasepsi pasca abortus
- Menjelaskan indikasi, kontraindikasi, keuntungan, kerugian dan efek samping dari masing-masing alat kontrasepsi
- Melakukan pengkajian kebutuhan kontrasepsi pada klien pasca keguguran/pascapersalinan
- Menentukan metode kontrasepsi yang sesuai berdasarkan kondisi klien (laktasi, risiko, preferensi)
- Menyusun rencana tindak lanjut (follow-up) penggunaan kontrasepsi

### **Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)**

---

Capaian pembelajaran pada Bab 9 ini mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), khususnya kemampuan mahasiswa melaksanakan layanan KB dan tindak lanjut secara aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan klien

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

#### **Aspek Pengetahuan (Knowledge)**

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kontrasepsi pasca persalinan, pasca abortus meliputi macam-macam alat kontrasepsi, indikasi, kontraindikasi, keuntungan,

kerugian, efek samping serta menyusun rencana tindak lanjut penggunaan kontrasepsi.

### **Aspek Keterampilan (Skills)**

Mahasiswa mampu:

- Melakukan pengkajian kebutuhan kontrasepsi sesuai kondisi klien
- Memberikan alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi klien
- Menyusun rencana tindak lanjut penggunaan kontrasepsi
- Melakukan pencatatan dan pelaporan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan kontrasepsi

### **Aspek Sikap (Attitude)**

Mahasiswa menunjukkan sikap:

- Bertanggung jawab dalam pengelolaan program kesehatan
- Empati terhadap keluhan klien
- Menghargai prinsip kerahasiaan dan etika dalam pelayanan
- Mampu bekerja sama sesama tenaga kesehatan dan lintas sektor

### **Aspek Keterampilan Umum (General Skills – OBE)**

Mahasiswa mampu:

- Berpikir kritis dalam menganalisis masalah klien
- Berkomunikasi secara efektif dalam edukasi kesehatan
- Menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan
- Berkolaborasi dalam tim multidisiplin

## **Pendahuluan**

---

Periode pascapersalinan dan pasca keguguran merupakan fase krusial dalam siklus kesehatan reproduksi perempuan yang sering kali kurang mendapatkan perhatian optimal dalam pelayanan kesehatan. Pada periode ini terjadi perubahan fisiologis, hormonal, dan psikologis yang signifikan, serta peningkatan risiko terjadinya kehamilan ulang dalam waktu yang relatif singkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ovulasi dapat kembali terjadi sebelum menstruasi pertama, bahkan dalam waktu sekitar 25 hari pada wanita yang tidak menyusui, dan 2–3 minggu setelah keguguran. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan berada dalam risiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak direncanakan apabila tidak segera menggunakan metode kontrasepsi yang tepat.

Kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat atau *short interpregnancy interval* (<24 bulan) telah terbukti secara konsisten berhubungan dengan berbagai komplikasi kesehatan, baik bagi ibu maupun bayi. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa jarak

kehamilan yang pendek meningkatkan risiko anemia pada ibu, perdarahan postpartum, serta komplikasi obstetri lainnya. Sementara itu, pada bayi, kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya kejadian prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), hingga peningkatan angka kematian neonatal. Oleh karena itu, organisasi kesehatan global seperti World Health Organization merekomendasikan penundaan kehamilan berikutnya minimal selama 24 bulan setelah persalinan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan anak.

Meskipun demikian, cakupan penggunaan kontrasepsi pada periode pascapersalinan dan pasca keguguran di berbagai negara berkembang masih tergolong rendah. Data menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dan penggunaan kontrasepsi (*unmet need for family planning*), terutama pada wanita dalam masa nifas. Penelitian berbasis populasi di negara berpenghasilan rendah dan menengah menunjukkan bahwa lebih dari 60% wanita dalam 12 bulan pascapersalinan memiliki kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan, keterbatasan akses terhadap layanan, serta kurang optimalnya konseling dari tenaga kesehatan.

Intervensi kontrasepsi pascapersalinan (*postpartum family planning/PPFP*) telah terbukti sebagai salah satu strategi yang efektif dan cost-effective dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Hasil systematic review dan meta-analisis menunjukkan bahwa pemberian konseling dan akses terhadap kontrasepsi pada periode postpartum secara signifikan meningkatkan penggunaan kontrasepsi serta menurunkan angka kehamilan ulang dalam waktu dekat. Selain itu, metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan (Long Acting Reversible Contraception/LARC) terbukti memiliki efektivitas tinggi (>99%) serta mampu meningkatkan keberlanjutan penggunaan dibandingkan metode jangka pendek.

Dalam konteks pasca keguguran, urgensi pemberian kontrasepsi bahkan lebih tinggi karena kembalinya kesuburan yang relatif cepat. Penelitian menunjukkan bahwa ovulasi dapat terjadi dalam waktu 2–3 minggu setelah keguguran, sehingga risiko kehamilan ulang sangat tinggi apabila tidak dilakukan intervensi segera. World Health Organization merekomendasikan pemberian kontrasepsi segera setelah evakuasi uterus, selama tidak terdapat komplikasi seperti infeksi atau perdarahan berat. Pendekatan ini terbukti meningkatkan tingkat penerimaan kontrasepsi dan mengurangi kejadian kehamilan yang tidak direncanakan.

Aspek penting lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kontrasepsi adalah status laktasi. Pada ibu menyusui, pemilihan metode kontrasepsi harus memperhatikan pengaruh hormonal terhadap produksi ASI. Estrogen diketahui dapat menurunkan produksi ASI melalui penghambatan hormon prolaktin, sehingga penggunaannya tidak direkomendasikan pada awal masa postpartum. Sebaliknya,

metode berbasis progestin dan non-hormonal seperti IUD terbukti aman dan tidak memengaruhi kualitas maupun kuantitas ASI. Metode Amenore Laktasi (MAL) juga dapat digunakan sebagai metode kontrasepsi alami dengan efektivitas tinggi, namun hanya dalam kondisi tertentu, yaitu menyusui eksklusif, bayi berusia kurang dari 6 bulan, dan belum terjadi menstruasi.

Meskipun berbagai metode kontrasepsi telah tersedia dan terbukti efektif, keberhasilan program kontrasepsi pascapersalinan dan pasca keguguran sangat bergantung pada kualitas konseling dan tindak lanjut yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pendekatan konseling berbasis *client-centered care* dan *informed choice* terbukti meningkatkan kepuasan klien serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. Selain itu, integrasi layanan kontrasepsi dengan pelayanan antenatal, persalinan, dan nifas merupakan strategi penting untuk meningkatkan cakupan penggunaan kontrasepsi.

## Uraian Materi

---

### A. Kontrasepsi Pascapersalinan

#### 1. Pengertian KB Pasca persalinan

KB Pasca Persalinan adalah penggunaan metode kontrasepsi pada masa nifas, yaitu segera setelah melahirkan hingga 42 hari setelah melahirkan.<sup>8</sup> Pelaksanaan KB pasca persalinan diutamakan untuk diberikan langsung setelah ibu melahirkan atau sebelum ibu pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan agar lebih efektif dan efisien serta menghindari kehilangan kesempatan (missed opportunity). Metode yang disarankan adalah yang tidak mengganggu ASI, seperti IUD, implan, suntik 3 bulan, pil progestin, kondom, atau MAL.

#### 2. Tujuan KB Pasca persalinan

- Menurunkan kehilangan kesempatan (missed opportunity) ber-KB pada klien yang sudah berkontak dengan petugas kesehatan sejak ANC, bersalin dan masa nifas.
- Membantu menciptakan jarak ideal antar kehamilan dan menghindari kehamilan tidak direncanakan
- Meningkatkan kepesertaan baru KB.
- Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga

#### 3. Metode Kontrasepsi Pasca Persalinan

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 24 Tahun 2023 tentang macam-macam alat kontrasepsi

### B. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

#### 1. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau yang biasadisebut IUD (Intra Uterin Device) adalah suatu benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, mempunyai lilitan tembaga atau juga mengandung hormon dan dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina dan mempunyai benang. AKDR memiliki tingkat efektivitas tinggi berkisar 0,6-0,8 kehamilan/100 perempuan dalam 1 tahun pertama kegagalan dalam 125-170 kehamilan.

Adapun jenis-jenis kontrasepsi dalam rahim antara lain:

- AKDR Copper T terbentuk dari suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau kawat Copper (tembaga) di sekitarnya. Jangka waktu pemakaian berjangka panjang dapat hingga 10 tahun. AKDR Copper T merupakan jenis IUD yang disediakan oleh pemerintah untuk program KB nasional. Cara Kerja AKDR Copper T bekerja dengan cara menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran telur karena kandungan tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril yang toksik buat sperma.

- b. AKDR Nova T terbentuk dari suatu rangka plastik dan tembaga dengan ujung lengan berbentuk sedikit melengkung tanpa ada tembaga, tembaga hanya ada dibatangnya. Jangka waktu pemakaian berjangka panjang dapat hingga 10 tahun. AKDR Nova T tidak disediakan oleh pemerintah untuk program KB nasional, tetapi banyak digunakan sebagai KB mandiri. Cara Kerja AKDR Nova T bekerja dengan cara menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran telur karena kandungan tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril yang toksik buat sperma.
- c. AKDR Levonorgestrel (AKDR-LNG)  
AKDR Levonorgestrel adalah suatu alat berbahan plastik berbentuk T yang secara terus-menerus melepaskan sejumlah kecil hormon progestin (levonorgestrel) setiap hari. Jangka waktu pemakaian AKDR levonorgestrel efektif untuk pemakaian 5 tahun. AKDR Levonorgestrel tidak disediakan oleh pemerintah untuk program KB nasional. AKDR Levonorgestrel bekerja dengan cara melepaskan sejumlah kecil hormon progestin (levonorgestrel) setiap hari yang akan mengentalkan cairan di bagian leher rahim sehingga sperma jadi lebih sulit untuk bisa masuk ke dalam rahim dan menghambat sperma membuahi sel telur telur

#### Keuntungan penggunaan AKDR

- a. Efektif bekerja segera setelah pemasangan.
- b. Efektif mencegah kehamilan, kurang dari 1 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan.
- c. Merupakan alat kontrasepsi jangka panjang.
- d. Tidak mempengaruhi hubungan seksual.
- e. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI.
- f. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah keguguran.
- g. Dapat digunakan sampai menopause.
- h. Kesuburan segera kembali setelah AKDR dilepas.

#### Kekurangan penggunaan AKDR

- a. Tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual (PMS).
- b. Pemasangannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih.
- c. Tidak direkomendasikan dipasang pada perempuan yang mengalami infeksi menular seksual (IMS)
- d. AKDR mungkin dapat keluar sendiri dari uterus tanpa diketahui.
- e. Perlu melakukan pengecekan benang AKDR secara berkala.

- f. Pelepasan AKDR tidak dapat dilakukan sendiri dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih.

Efek Samping yang mungkin terjadi

- a. Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan).
- b. Haid lebih lama dan lebih banyak.
- c. Perdarahan (spotting) antar menstruasi.
- d. Kram atau rasa nyeri selama haid.

Waktu pemakaian pasca persalinan

- a. Dalam 48 jam setelah melahirkan maka AKDR dapat dipasang, termasuk segera setelah plasenta dilahirkan. Jika persalinan secara seksio sesaria, AKDR dapat dipasang setelah plasenta lahir, sebelum uterus dijahit.
- b. Dalam 48 jam hingga 4 minggu pascapersalinan: maka pemasangan AKDR-Cu tidak direkomendasikan kecuali tidak tersedia atau tidak ada metode kontrasepsi lain.
- c. Lebih dari 4 minggu pascapersalinan dan belum menstruasi pada ibu menyusui maka AKDR dapat dipasang bila wanita tersebut yakin tidak hamil (Tidak diperlukan kontrasepsi tambahan sebagai proteksi). Sedangkan pada ibu yang tidak menyusui maka AKDR dapat dipasang setelah dipastikan wanita tidak hamil (Tidak diperlukan kontrasepsi tambahan sebagai proteksi)
- d. Pasca persalinan 4 minggu atau lebih dan siklus menstruasi telah kembali maka AKDR dapat dianjurkan bagi wanita yang siklus menstruasi sudah kembali.

## 2. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)

Alat Kontrasepsi Bawah Kulit yang selanjutnya disingkat menjadi AKBK yang lebih dikenal dengan susuk KB atau implan KB adalah alat kontrasepsi berbentuk kapsul kecil yang mengandung hormon diletakkan tepat dibawah kulit lengan atas yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan. Cara Kerja Hormon progestin yang dilepaskan dari kapsul implant secara terus menerus akan mempengaruhi hipotalamus dan kelenjar hipofise anterior untuk menurunkan sekresi FSH (Folikel stimulating hormon) dan LH (leuteinizing hormon). Penurunan FSH dan LH akan menghambat atau mengurangi sentakan gelombang LH pada pertengahan siklus sehingga akan menekan ovulasi. Selain itu hormon progestin yang dilepaskan juga akan menimbulkan pengentalan pengentalan lendir serviks yang akan menghambat bertemunya sperma dan telur. Tingkat Efektifitas Mencegah kehamilan dengan sangat efektif kurang dari

1 kehamilan per 100 perempuan yang menggunakan implan pada tahun pertama per 1.000 perempuan).

#### Jenis-jenis Implan

- a. Implan Dua Batang: terdiri dari 2 batang implan mengandung hormon Levonorgestrel 75 mg/batang. Efektif hingga 4 tahun penggunaan (studi terkini menunjukkan bahwa jenis ini memiliki efektivitas tinggi hingga 5 tahun).
- b. Implan Satu Batang (Implanon) : terdiri dari 1 batang implan mengandung hormon Etonogestrel 68 mg, efektif hingga 3 tahun penggunaan (studi terkini menunjukkan bahwa jenis ini memiliki efektivitas tinggi hingga 5 tahun)

#### Keuntungan implan

- a. Klien tidak perlu melakukan apapun setelah implan terpasang.
- b. Sangat efektif dalam mencegah kehamilan
- c. Merupakan metode kontrasepsi jangka panjang untuk 3 hingga 5 tahun, tergantung jenis implan.
- d. Tidak mengganggu hubungan seksual.
- e. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI.
- f. Kesuburan dapat kembali dengan segera setelah implan dilepas.
- g. Mengurangi nyeri haid.
- h. Mengurangi jumlah darah haid sehingga dapat mencegah anemia defisiensi besi.

#### Kekurangan implan

- a. Tidak ada perlindungan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS).
- b. Membutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih secara khusus untuk memasang dan melepas.
- c. Klien tidak dapat memulai atau menghentikan pemakaian implan secara mandiri.

#### Efek samping yang mungkin terjadi

- a. Terjadi perubahan pola perdarahan haid.
- b. Lamanya perdarahan pada saat menstruasi berkurang.
- c. Tidak mengalami perdarahan atau bercak perdarahan sama sekali selama beberapa bulan (amenorea).

Waktu pemakaian pasca persalinan

- a. Kurang dari 6 minggu pascapersalinan Implan dapat dipasang. Dalam 6 minggu hingga 6 bulan pascapersalinan dan belum menstruasi maka Implan dapat dipasang. Jika perempuan sedang menyusui maka tidak memerlukan perlindungan kontrasepsi tambahan.
  - b. Lebih dari 6 minggu pascapersalinan, ibu masih menyusui dan siklus menstruasi telah kembali maka Implan dapat dipasang seperti yang disarankan untuk wanita lain yang memiliki siklus menstruasi (jika pemasangan implan dilakukan pada 7 hari awal siklus menstruasi maka tidak diperlukan perlindungan kontrasepsi tambahan, tetapi bila implan dipasang lebih dari 7 hari awal siklus menstruasi maka dalam 7 hari setelah pemasangan klien tidak boleh melakukan hubungan seksual atau harus menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan)
  - c. Kurang dari 21 hari pasca persalinan dan ibu sedang tidak menyusui maka implan dapat dipasang tanpa memerlukan perlindungan kontrasepsi tambahan karena selama 21 hari pertama pasca persalinan kecil kemungkinan bagi ibu pascapersalinan untuk mengalami ovulasi dan hamil.
  - d. Dalam 21 hari pasca persalinan atau lebih pada ibu yang tidak menyusui dan siklus menstruasi belum kembali maka Implan dapat dipasang jika cukup yakin bahwa ibu sedang tidak hamil. Ibu tidak boleh berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 7 hari ke depan. Pada ibu dengan siklus menstruasi yang sudah kembali maka Implan dapat dipasang seperti yang disarankan untuk wanita lain yang memiliki siklus menstruasi.
3. Tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW)

Kontrasepsi metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi. Tindakan bedah yang dilakukan dengan cara menutup kedua saluran telur sehingga sel telur tidak bertemu dengan sperma laki-laki. Tingkat Efektivitas Tubektomi merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif dengan tingkat efektivitas 0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan.

Keuntungan Tubektomi

- a. Sangat efektif mencegah kehamilan.
- b. Tidak mempengaruhi proses menyusui.
- c. Tidak memiliki efek samping dalam jangka panjang. Pengguna tidak perlu melakukan atau mengingat apapun setelah prosedur dilakukan.
- d. Tidak mempengaruhi perubahan dalam fungsi seksual.

#### Kekurangan Tubektomi

- a. Kesuburan tidak dapat dipulihkan kembali setelah prosedur pembedahan dilakukan, kecuali dengan operasi rekanalisasi.
- b. Rasa sakit dalam jangka pendek yang dirasakan setelah proses pembedahan dilakukan.
- c. Harus dilakukan oleh dokter yang terlatih (untuk laparoskopi dilakukan oleh dokter Spesialis Obstetri Ginekologi)

#### 4. Vasektomi/Metode Operasi Pria

Metode operasi pria atau yang biasa disebut vasektomi adalah tindakan memotong dan mengikat vas (ductus) deferens dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis sehingga sperma tidak bercampur dengan semen. Semen dikeluarkan, tetapi tidak dapat menyebabkan kehamilan. Tingkat Efektivitas Setelah masa pengosongan sperma dari vesikula seminalis 20 kali ejakulasi menggunakan kondom) maka kehamilan hanya terjadi 1 per 100 perempuan pada tahun pertama penggunaan. Akan tetapi jika tidak patuh menggunakan kondom hingga 20 kali ejakulasi maka resiko kehamilan yang mungkin terjadi 2-3 per 100 perempuan pada tahun pertama penggunaan.

#### Keuntungan vasektomi

- a. Aman dan nyaman.
- b. Metode vasektomi terbukti efektif dalam mencegah kehamilan.
- c. Bersifat permanen.
- d. Laki-laki mengambil tanggung jawab untuk kontrasepsi dan mengambil alih beban perempuan.
- e. Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual.

#### Kekurangan vasektomi

- a. Tidak segera efektif (WHO menyarankan kontrasepsi tambahan selama 3 bulan setelah prosedur, kurang lebih 20 kali ejakulasi).
- b. Komplikasi minor seperti infeksi, perdarahan, nyeri pasca operasi.
- c. Harus dilakukan oleh dokter umum yang terlatih untuk vasektomi atau Dokter Spesialis Bedah dan Dokter Spesialis Urologi.

Keefektifitas MOP

- a. Pria harus disarankan untuk menunggu tiga bulan sebelum mengandalkan vasektomi sebagai metode kontrasepsi.
- b. Selama periode ini, pengguna boleh kembali melakukan hubungan seksual dengan catatan jika istri menggunakan kontrasepsi maka teruskan penggunaan kontrasepsi istri selama 3 bulan ke depan (setelah itu kontrasepsi dapat dilepas), akan tetapi jika istri tidak menggunakan kontrasepsi apapun maka pengguna harus menggunakan kontrasepsi pelindung selama 3 bulan sejak luka sembuh
- c. Setelah 3 bulan, perlu dilakukan analisis cairan sperma untuk memastikan tercapainya azoospermia.

### **C. Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP)**

#### **1. Suntik KB 3 bulan**

Kontrasepsi suntik yang mengandung Progestin saja seperti hormon progesteron alami dalam tubuh perempuan. Jenis KB suntik progestin yang disediakan pemerintah melalui program BKKBN yaitu Depo Medroxyprogesterone Acetate (DMPA), 150 mg/vial (1 ml).

Cara Kerjanya mencegah pelepasan telur dari ovarium (menekan ovulasi), mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Tingkat Efektivitas KB suntik 3 bulanan efektif mencegah kehamilan dengan tingkat keefektifitasannya berkisar 0,2 – 4 kehamilan per 100 perempuan.

Keuntungan

- a. Suntikan dilakukan setiap 3 bulan sekali.
- b. Tidak perlu penggunaan setiap hari.
- c. Tidak mengganggu hubungan seksual.
- d. Dapat digunakan oleh perempuan menyusui dimulai 6 bulan setelah melahirkan.
- e. Dapat digunakan oleh perempuan usia >35 tahun sampai perimenopause.
- f. Membantu mencegah: kanker endometrium, mioma uteri.
- g. Mungkin membantu mencegah: Penyakit radang panggul simptomatis, anemia defisiensi zat besi
- h. Mengurangi krisis sel sabit pada perempuan dengan anemia sel sabit, gejala endometriosis (nyeri panggul, menstruasi yang tidak teratur).

#### Kekurangan

- a. Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan untuk suntikan ulang.
- b. Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu.
- c. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian.

#### Efek samping

- a. Terjadi perubahan pada siklus haid/menstruasi.
- b. Terjadi kenaikan berat badan.
- c. Sakit kepala ringan.
- d. Nyeri payudara.

#### Waktu pemakaian pasca persalinan

- a. Kurang dari 6 minggu pascapersalinan dan menyusui penuh penggunaan Kontrasepsi Suntik Progestin biasanya tidak dianjurkan kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat tidak tersedia atau tidak dapat diterima Pada 6 minggu hingga 6 bulan pascapersalinan injeksi kontrasepsi suntik progestin pertama dapat diberikan jika perempuan menyusui penuh pada saat ini tidak memerlukan perlindungan kontrasepsi tambahan
- b. Lebih dari 6 minggu pascapersalinan dan siklus menstruasi telah Kembali maka Injeksi pertama dapat diberikan seperti yang disarankan untuk wanita lain yang memiliki siklus menstruasi.
- c. Kurang dari 21 hari pasca persalinan dan ibu sedang tidak menyusui maka injeksi pertama dapat diberikan tanpa memerlukan perlindungan kontrasepsi tambahan karena selama 21 hari pertama pasca persalinan kecil kemungkinan bagi ibu pascapersalinan untuk mengalami ovulasi dan hamil.
- d. Dalam 21 hari pasca persalinan atau lebih pada ibu yang tidak menyusui dan siklus menstruasi belum kembali.<sup>29</sup>

#### 2. Pil KB Progestin

Pil yang mengandung progestin saja dengan dosis yang sangat rendah seperti hormon progesteron alami pada tubuh perempuan. Kemasan Pil KB Progestin terdiri dari 28 pil yang berisi Lynestrenol 0,5 mg. Sangat dianjurkan untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Tingkat Efektivitas Pil KB Progestin efektif mencegah kehamilan dengan tingkat

keefektifitasannya berkisar kehamilan 0,3 – 7 kehamilan per 100 perempuan.

### Cara Kerja

- a. Mencegah pelepasan telur dari ovarium (menekan ovulasi).
- b. Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma.
- c. Menjadikan endometrium tipis dan atrofi.

### Keuntungan

- a. Dapat diminum selama menyusui.
- b. Dapat mengontrol pemakaian.
- c. Penghentian dapat dilakukan kapan pun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan.
- d. Tidak mengganggu hubungan seksual.
- e. Kesuburan cepat kembali.
- f. Mengurangi nyeri haid.
- g. Mengurangi jumlah perdarahan haid.

### Kekurangan

- a. Harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama, bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar.
- b. Peningkatan/penurunan berat badan.

### Waktu pemakaian pasca persalinan

- a. Kurang dari 6 minggu pascapersalinan kontrasepsi pil progestin umumnya dapat dimulai. Pada ibu yang sedang menyusui maka tidak memerlukan kontrasepsi tambahan.
- b. Dalam 6 minggu hingga 6 bulan pascapersalinan dan belum menstruasi maka kontrasepsi pil progestin dapat dimulai. Pada ibu yang sedang menyusui maka tidak memerlukan kontrasepsi tambahan.
- c. Lebih dari 6 minggu pascapersalinan dan siklus menstruasi telah Kembali maka kontrasepsi pil progestin dapat dimulai seperti yang disarankan untuk wanita lain yang memiliki siklus menstruasi.
- d. Kurang dari 21 hari pasca persalinan pada ibu yang tidak menyusui bayinya maka kontrasepsi pil progestin dapat dimulai dengan tidak perlu menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan.
- e. Pada 21 hari atau lebih pascapersalinan dan siklus menstruasi belum Kembali maka kontrasepsi Pil Progestin dapat dimulai jika yakin bahwa wanita tidak hamil. Ibu tidak boleh berhubungan seksual atau menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan selama 2 hari ke depan.

- f. Pada ibu pasca persalinan yang siklus menstruasi telah Kembali maka waktu mulai penggunaan kontrasepsi pil progestin seperti yang disarankan untuk wanita lain yang memiliki siklus menstruasi.

### 3. Kondom

Merupakan selubung/sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), polyurethane, polyisoprene, kulit domba, dan nitrile.

#### Cara Kerja

- a. Menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tumpah ke dalam saluran reproduksi perempuan.
- b. Khusus untuk kondom yang terbuat dari lateks dan vinil dapat mencegah penularan mikroorganisme (IMS termasuk HBV dan HIV/AIDS) dari satu pasangan kepada pasangan yang lain

#### Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas penggunaan KB kondom dalam mencegah kehamilan yaitu 2-13 kehamilan per 100 perempuan.

#### Keuntungan

- a. Murah dan dapat dibeli bebas.
- b. Tidak perlu pemeriksaan kesehatan khusus.
- c. Proteksi ganda (selain mencegah kehamilan tetapi juga mencegah IMS termasuk HIV-AIDS).
- d. Membantu mencegah terjadinya kanker serviks (mengurangi iritasi bahan karsinogenik eksogen pada serviks)

#### Kekurangan

- a. Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi.
- b. Agak mengganggu hubungan seksual (mengurangi sentuhan langsung).
- c. Bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi.
- d. Perasaan malu saat harus membelinya di tempat umum

#### 4. Metode Amenorhea Laktasi

Metode Amenore Laktasi adalah metode kontrasepsi sementara yang efektif pada ibu pasca persalinan yang menyusui bayinya secara eksklusif, belum mengalami menstruasi (amenorea), bayi berusia kurang dari 6 bulan. Menyusui merangsang hormon prolaktin, yang berfungsi untuk menekan hormon GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone), menghambat pelepasan FSH dan LH, mencegah ovulasi (pelepasan sel telur) sehingga tidak mengalami menstruasi (amenorea) dan tidak subur sementara. Metode amenorhea laktasi sangat efektif apabila ibu belum haid sejak melahirkan, menyusui eksklusif (tanpa tambahan makanan/minuman lain, menyusui  $\geq 8$  kali/hari, tidak ada jeda panjang ( $>4$  jam siang /  $>6$  jam malam), usia bayi kurang dari 6 bulan. Efektivitas metode amenorhea alaktasi mencapai 98% apabila memenuhi syarat tersebut. Efektivitas:  $\pm 98\%$  (jika syarat terpenuhi)

Keuntungan dari Metode Amenorhea Laktasi antara lain :

- a. Alami, tanpa hormon tambahan
- b. Tidak mengganggu produksi ASI
- c. Tidak memerlukan biaya
- d. Meningkatkan ikatan ibu dan bayi
- e. Memberikan perlindungan kontrasepsi segera setelah persalinan

Kekurangan metode amenorhea alaktasi anatara lain :

- a. Hanya efektif sampai bayi usia 6 bulan
- b. Bergantung pada kepatuhan menyusui eksklusif
- c. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual (IMS)
- d. Risiko kehamilan meningkat jika salah satu syarat tidak terpenuhi

#### **D. Kontrasepsi Pasca Keguguran**

Kontrasepsi pasca keguguran (post-abortion) merupakan komponen krusial dalam pelayanan kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dan memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih. Berdasarkan hasil penelitian dan pedoman klinis, kontrasepsi dapat dan sebaiknya segera dimulai setelah keguguran.

Berikut adalah panduan kontrasepsi pasca keguguran berdasarkan hasil penelitian:

##### 1. Waktu Memulai Kontrasepsi

- a. Segera/Langsung: Kontrasepsi dapat dimulai segera (dalam hitungan jam hingga hari) setelah keguguran, baik aborsi medis maupun bedah.

- b. Fertilitas Kembali Cepat: Kesuburan dapat kembali dalam kurun waktu 10-14 hari pasca keguguran, sehingga penundaan penggunaan KB berisiko menyebabkan kehamilan segera.
  - c. Jeda Kehamilan: WHO merekomendasikan untuk menunggu setidaknya 6 bulan sebelum mencoba hamil kembali setelah aborsi untuk hasil kesehatan yang lebih baik.
2. Beberapa alat kontrasepsi yang tepat digunakan pasca keguguruan antara lain :
- a. IUD/AKDR (Copper T atau Levonorgestrel): Dapat dipasang segera setelah aborsi trimester pertama atau kedua jika tidak ada infeksi. IUD pasca keguguran efektif dan aman.
  - b. KB hormonal seperti : Implan/Susuk KB, Suntik KB & Pil KB  
Pemberian kontrasepsi hormonal segera setelah abortus aman dan membantu mencegah kehamilan ulang. Tidak meningkatkan komplikasi signifikan (perdarahan/infeksi)
  - c. Metode Penghalang (Kondom): Dapat digunakan langsung
  - d. Kontrasepsi Darurat, digunakan jika terjadi hubungan seksual tanpa proteksi

#### **E. Mini Case**

Ny. Y, usia 26 tahun, G2P1A1, datang ke puskesmas untuk kontrol setelah mengalami keguguran spontan pada usia kehamilan 10 minggu. Berdasarkan hasil USG uterus 3 hari yang lalu di RS dinyatakan bahwa uterus sudah bersih. Saat ini Ny Y masih merasa cemas dan takut jika hamil lagi dalam waktu dekat.

Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa kontrasepsi harus diberikan segera setelah keguguran?
2. Apa risiko jika pasien tidak menggunakan kontrasepsi?
3. Pengkajian dan pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan sebelum memberikan berbagai macam alat kontrasepsi yang tepat untuk kasus di atas
4. Kontrasepsi yang tepat berdasarkan data kesehatan umum dan obstetri pada kasus di atas

### Rubrik penilaian

| Indikator                                                        | Skor 1 (Kurang)                                             | Skor 2 (Cukup)                           | Skor 3 (Baik)                                          | Skor 4 (Sangat Baik)                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Ketepatan pemilihan metode sesuai data klinis dan preferensi | Pilihan tidak sesuai kondisi/risiko; mengabaikan preferensi | Pilihan cukup sesuai namun belum optimal | Pilihan tepat sesuai kondisi dan preferensi            | Pilihan sangat tepat; mempertimbangkan alternatif, risiko, dan keberterimaan secara komprehensif              |
| 5.2 Kualitas edukasi penggunaan dan rencana kontrol              | Edukasi tidak jelas; kontrol tidak terencana                | Edukasi dasar ada; kontrol masih umum    | Edukasi jelas; kontrol dan pencegahan risiko terencana | Edukasi sangat jelas dan memberdayakan; kontrol terukur; strategi kepatuhan dan pencegahan risiko sangat kuat |

### F. Referensi

- BKKBN. (2021). *Pedoman KB Pascapersalinan dan Pasca Keguguran*.
- Dagnew GW, et al. (2025). *Post-abortion contraceptive uptake in Africa: systematic review and meta-analysis*
- Gonzales-Huaman P, et al. (2021). *Peri-abortion contraceptive counseling: A systematic review of randomized controlled trials*. PLoS ONE
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana*.
- Makenzius M, et al. (2018). *Contraceptive uptake in post abortion care*. PLoS ONE.
- Nugussa, B., Solomon, T., & Tadelu, H. (2023). *Modern postpartum family planning and associated factors*.  
[https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00469580231153268?utm\\_source=chatgpt.com](https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00469580231153268?utm_source=chatgpt.com)
- Sheila Nurhaliza Zulfa, Mita Dwi Ayudha, Ernawaty, Afif Kurniawan. "FACTORS ASSOCIATED POST PARTUM CONTRACEPTION PLANNING," Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 13, No. 1, pp. 29 – 37, July 2024.  
<https://e-journal.unair.ac.id/JBK/article/view/46778>
- Simanjuntak R. (2023). *Efektivitas kontrasepsi darurat: systematic review*. Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology.
- World Health Organization. (2022). *Family Planning: A Global Handbook for Providers*.
- Zhang Y, et al. (2016). *Oral contraception following abortion: systematic review and meta-analysis*. Medicine (Baltimore).

# BAB 3

## PENANGANAN EFEK SAMPING DAN KOMPLIKASI KB: PERDARAHAN TIDAK TERATUR, NYERI, DAN TANDA BAHAYA

### Capaian Pembelajaran Lulusan

---

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan penatalaksanaan yang tepat terhadap efek samping serta komplikasi penggunaan alat kontrasepsi (Perdarahan Tidak Teratur, Nyeri, dan Tanda Bahaya) sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

| CP                                                                                           | CPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPL                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanganan Efek Samping dan Komplikasi KB: Perdarahan Tidak Teratur, Nyeri, dan Tanda Bahaya | <p>CPMK-6: Menangani efek samping/komplikasi KB, menetapkan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara aman.</p> <p>CPMK-5: Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang tepat dan menyusun edukasi penggunaan sesuai kelayakan, kondisi, dan bukti.</p> <p>CPMK-4: Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut.</p> | <p>CPL 5:</p> <p>Melaksanakan layanan KB dan tindak lanjut secara aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan klien (metode, edukasi, pemantauan).</p> |

### A. Pendahuluan

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Penggunaan alat dan metode kontrasepsi bertujuan membantu pasangan usia subur dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran secara aman dan bertanggung jawab. Keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan metode kontrasepsi, tetapi juga oleh kualitas pelayanan serta kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan penanganan efek samping yang muncul pada akseptor KB.

Setiap metode kontrasepsi memiliki kemungkinan menimbulkan efek samping, baik yang bersifat ringan maupun yang memerlukan perhatian medis. Efek samping yang sering terjadi antara lain perdarahan tidak teratur, nyeri perut, sakit kepala, perubahan pola menstruasi, serta keluhan hormonal lainnya. Sebagian besar efek samping tersebut merupakan respons adaptasi tubuh terhadap perubahan hormon atau penggunaan alat kontrasepsi dan umumnya bersifat sementara. Namun, kurangnya pemahaman akseptor terhadap efek samping sering menyebabkan kecemasan dan penghentian penggunaan KB secara dini.

Penanganan efek samping yang tepat melalui konseling, pemantauan, serta intervensi medis sederhana sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. Tenaga kesehatan memiliki peran utama dalam membedakan efek samping normal dengan tanda bahaya yang memerlukan rujukan lebih lanjut. Edukasi yang baik dapat membantu akseptor memahami kondisi yang dialami sehingga kepatuhan penggunaan KB tetap terjaga dan risiko komplikasi dapat diminimalkan.

Selain itu, deteksi dini terhadap tanda bahaya seperti perdarahan hebat, nyeri perut berat, demam, atau gejala tromboemboli menjadi bagian penting dalam pelayanan KB yang aman. Pedoman internasional menekankan bahwa pelayanan kontrasepsi harus disertai pemantauan berkelanjutan untuk memastikan metode yang digunakan tetap sesuai dengan kondisi kesehatan pengguna. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penanganan efek samping dan komplikasi KB menjadi aspek penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi guna meningkatkan kualitas hidup akseptor serta keberhasilan program keluarga berencana secara berkelanjutan.

## **B. Pengertian**

1. Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan melalui penggunaan metode kontrasepsi guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program KB bertujuan meningkatkan kesehatan reproduksi serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2. Efek Samping Kontrasepsi. Efek samping kontrasepsi merupakan reaksi atau keluhan yang muncul setelah penggunaan metode KB akibat respons tubuh terhadap hormon atau alat kontrasepsi. Efek samping umumnya bersifat ringan dan sementara serta tidak membahayakan kesehatan apabila ditangani dengan benar.
3. Komplikasi adalah kondisi gangguan kesehatan atau masalah medis yang muncul sebagai akibat lanjutan dari suatu tindakan, penyakit, atau penggunaan metode tertentu, yang sifatnya lebih serius dibandingkan efek samping biasa dan memerlukan penanganan medis.

Penanganan efek samping merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi, mengatasi, dan mencegah memburuknya keluhan yang muncul akibat penggunaan suatu metode pengobatan atau alat kesehatan, termasuk penggunaan alat kontrasepsi (KB), tanpa menghilangkan manfaat utama dari tindakan tersebut.

Secara sederhana, penanganan efek samping diartikan sebagai usaha untuk membantu tubuh beradaptasi dan menjaga kondisi tetap aman ketika muncul reaksi atau keluhan setelah penggunaan obat atau metode tertentu.

### **Tujuan Penanganan Efek Samping**

1. Mengurangi rasa tidak nyaman pada pengguna
2. Mencegah komplikasi yang lebih serius
3. Memastikan penggunaan tetap aman dan efektif
4. Meningkatkan kepatuhan penggunaan (misalnya pada KB)

### **Contoh Penanganan**

1. Memberikan edukasi dan konseling
2. Observasi atau pemantauan kondisi
3. Pemberian obat sesuai keluhan
4. Penyesuaian atau penggantian metode bila diperlukan
5. Rujukan ke fasilitas kesehatan jika muncul tanda bahaya

### C. Perdarahan Tidak Teratur

Perdarahan tidak teratur adalah efek samping yang paling sering terjadi, terutama pada KB hormonal (pil, suntik, implan).

Penyebab:

1. Adaptasi tubuh terhadap hormon KB. Perdarahan tidak teratur pada akseptor KB hormonal merupakan kondisi yang sering terjadi, terutama pada 3–6 bulan pertama pemakaian. Hal ini merupakan bentuk adaptasi tubuh terhadap perubahan kadar hormon sintetis (estrogen dan/atau progesteron) yang diberikan melalui kontrasepsi. Mekanisme Terjadinya KB hormonal (pil, suntik, implan) bekerja dengan cara: menghambat ovulasi, menipiskan endometrium dan engentalkan lendir serviks
2. Penipisan dinding Rahim. Perdarahan tidak teratur dapat terjadi akibat penipisan lapisan dalam rahim (endometrium). Kondisi ini paling sering ditemukan pada pengguna kontrasepsi hormonal, terutama yang mengandung progesteron saja.
3. Ketidakteraturan penggunaan pil. Perdarahan tidak teratur sering terjadi akibat ketidakteraturan dalam mengonsumsi pil kontrasepsi, seperti lupa minum, terlambat minum, atau menghentikan pil secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan fluktuasi hormon yang memicu gangguan pada kestabilan endometrium. Mekanisme Terjadinya. Pil KB (kombinasi estrogen-progesteron atau progestin saja) bekerja dengan menjaga kadar hormon tetap stabil setiap hari. Jika penggunaannya tidak teratur, maka akan terjadi Penurunan Mendadak Kadar Hormon, ketidakseimbangan Estrogen–Progesteron dan ovulasi Tidak Terkontrol
4. Efek awal pemasangan implan atau IUD hormonal. Perdarahan tidak teratur merupakan efek samping yang sangat umum pada awal penggunaan kontrasepsi jangka panjang hormonal, seperti implan dan IUD hormonal. Kondisi ini biasanya bersifat sementara dan merupakan bagian dari proses adaptasi tubuh terhadap hormon progestin. Mekanisme Terjadinya baik implan maupun IUD hormonal bekerja dengan melepaskan hormon progestin dalam kadar rendah tetapi kontinu.

Bentuk Perdarahan :

1. Flek di luar jadwal haid
2. Haid lebih lama atau lebih sedikit
3. Tidak haid sama sekali (amenorea)

## Penanganan

1. Edukasi bahwa kondisi ini sering normal pada 3–6 bulan pertama
2. Pastikan penggunaan KB sesuai jadwal
3. Anjurkan konsumsi tablet zat besi bila perdarahan lama
4. Istirahat cukup dan nutrisi baik
5. Konsultasi tenaga kesehatan bila:
  - 1) Perdarahan sangat banyak
  - 2) Berlangsung lebih dari 7–10 hari
  - 3) Disertai pusing atau lemas

Komplikasi dari Perdarahan Tidak Teratur pada Pengguna KB yaitu terjadinya perdarahan tidak teratur merupakan efek samping yang sering terjadi pada penggunaan kontrasepsi, terutama KB hormonal. Namun, apabila perdarahan berlangsung lama, sangat banyak, atau tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi komplikasi yang membahayakan kesehatan. Ada beberapa komplikasi yang terjadi pada perdarahan tidak teratur yaitu :

1. Anemia (Kurang Darah). Perdarahan yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin dalam darah.

Tanda dan gejala:

- a. Lemas dan mudah lelah
- b. Pusing atau berkunang-kunang
- c. Wajah pucat
- d. Jantung berdebar

Risiko: menurunkan daya tahan tubuh dan aktivitas sehari-hari.

2. Syok Hipovolemik. Terjadi jika perdarahan sangat banyak sehingga tubuh kehilangan banyak darah dalam waktu singkat.

Tanda bahaya:

- a. Pusing berat atau pingsan
- b. Tekanan darah menurun
- c. Nadi cepat dan lemah
- d. Kulit dingin dan pucat

Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan medis dan harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan.

3. Infeksi Organ Reproduksi. Perdarahan berkepanjangan dapat meningkatkan risiko masuknya kuman ke saluran reproduksi, terutama pada pengguna IUD.

Gejala:

- a. Demam
- b. Nyeri perut bawah
- c. Keputihan berbau tidak sedap

4. Gangguan Siklus Menstruasi Berkepanjangan.

Perdarahan tidak teratur yang tidak ditangani dapat menyebabkan gangguan hormonal yang menetap sehingga siklus haid menjadi tidak normal dalam jangka panjang.

5. Penghentian Penggunaan KB (Drop Out Akseptor)

Walaupun bukan komplikasi medis langsung, perdarahan yang tidak ditangani dengan baik sering menyebabkan akseptor menghentikan KB secara dini, sehingga meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan.

#### **D. Nyeri**

Nyeri merupakan salah satu keluhan yang sering dialami oleh akseptor kontrasepsi, baik metode hormonal maupun non-hormonal. Keluhan ini umumnya bersifat ringan dan sementara, terutama pada fase awal penggunaan, sebagai bentuk adaptasi tubuh terhadap perubahan hormonal atau keberadaan alat kontrasepsi dalam tubuh. Namun demikian, tenaga kesehatan tetap harus mampu membedakan antara nyeri sebagai efek samping ringan dan nyeri yang merupakan tanda komplikasi serius.

Pada pengguna kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, atau implan, nyeri kepala sering terjadi akibat fluktuasi kadar estrogen. Perubahan hormonal ini dapat memicu vasodilatasi pembuluh darah otak sehingga menimbulkan sakit kepala ringan hingga sedang. Pada sebagian akseptor, nyeri kepala biasanya membaik setelah beberapa siklus penggunaan. Penatalaksanaan dilakukan secara konservatif dengan pemberian analgesik ringan dan observasi. Namun, apabila nyeri kepala bersifat berat, disertai gangguan penglihatan atau gejala neurologis, maka perlu evaluasi lebih lanjut dan pertimbangan penggantian metode kontrasepsi.

Nyeri payudara juga sering dilaporkan pada penggunaan kontrasepsi hormonal. Kondisi ini terjadi akibat stimulasi jaringan payudara oleh estrogen dan progesteron. Biasanya keluhan berupa rasa tegang atau sensitif pada payudara dan akan berkurang setelah tubuh beradaptasi. Edukasi kepada akseptor sangat penting agar tidak menimbulkan kecemasan. Penggunaan bra yang menopang dengan baik serta kompres hangat atau dingin dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan.

Pada pengguna alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau IUD hormonal seperti Mirena, nyeri perut bawah atau kram merupakan keluhan yang cukup umum, terutama pada minggu-minggu awal setelah pemasangan. Nyeri ini disebabkan oleh kontraksi uterus sebagai respons terhadap benda asing di dalam rongga rahim. Pada umumnya, keluhan akan membaik dalam 1–3 bulan. Penatalaksanaan dapat berupa pemberian obat antiinflamasi nonsteroid dan pemantauan berkala. Apabila nyeri berlangsung hebat, menetap, atau disertai demam dan perdarahan banyak, maka perlu dicurigai adanya infeksi atau malposisi alat.

Nyeri lokal pada area pemasangan implan, seperti pada penggunaan Implanon, dapat terjadi akibat trauma jaringan saat prosedur pemasangan. Biasanya keluhan berupa rasa nyeri tekan ringan atau memar pada lokasi insersi. Penanganan cukup dengan kompres dingin pada 24 jam pertama dan pemberian analgesik ringan. Namun, apabila terdapat tanda peradangan seperti kemerahan luas, bengkak, atau demam, maka perlu evaluasi lebih lanjut untuk menyingkirkan infeksi.

Dalam praktik kebidanan, prinsip utama penanganan nyeri pada akseptor KB adalah melakukan identifikasi penyebab secara menyeluruh, menilai tingkat keparahan, memberikan terapi simptomatik, serta melakukan edukasi yang adekuat. Sebagian besar keluhan nyeri bersifat ringan dan akan membaik dengan sendirinya. Akan tetapi, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap tanda bahaya seperti nyeri perut hebat mendadak, nyeri dada, sakit kepala berat yang tidak biasa, atau disertai gangguan kesadaran, karena kondisi tersebut dapat mengarah pada komplikasi yang lebih serius dan memerlukan rujukan segera.

Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi yang baik, serta pemantauan berkala, efek samping berupa nyeri pada akseptor KB dapat ditangani secara efektif tanpa harus menghentikan penggunaan kontrasepsi secara prematur.

Nyeri dapat muncul tergantung jenis KB yang digunakan.

Jenis Nyeri yang Umum:

1. Nyeri perut bawah (IUD/spiral)
2. Nyeri payudara (KB hormonal)
3. Sakit kepala ringan
4. Nyeri di lokasi suntikan atau implant

Penyebab:

1. Adaptasi hormon
2. Kontraksi rahim setelah pemasangan IUD
3. Reaksi lokal tubuh

#### Penanganan

1. Kompres hangat pada area nyeri
2. Obat pereda nyeri ringan sesuai anjuran tenaga Kesehatan
3. Istirahat cukup
4. Observasi selama beberapa hari setelah pemasangan

#### Kapan Harus Waspada

1. Nyeri semakin berat
2. Nyeri disertai demam
3. Nyeri perut hebat mendadak

### **E. Tanda Bahaya**

Pengguna KB harus mengetahui tanda bahaya agar segera mendapat pertolongan medis.

Tanda Bahaya Umum :

1. Perdarahan sangat banyak (ganti pembalut tiap  $\leq 1$  jam)
2. Nyeri perut hebat atau terus-menerus
3. Demam tinggi setelah pemasangan KB
4. Keputihan berbau menyengat (indikasi infeksi)
5. Pusing berat, sesak napas, atau nyeri dada
6. Bengkak dan nyeri pada kaki (risiko bekuan darah pada KB hormonal)

Tindakan:

1. Segera ke puskesmas atau rumah sakit
2. Jangan menunda pemeriksaan
3. Informasikan jenis KB yang digunakan

#### Komplikasi Tanda Bahaya pada Akseptor KB

Komplikasi pada akseptor Keluarga Berencana (KB) merupakan kondisi yang tidak normal dan berpotensi membahayakan kesehatan pengguna kontrasepsi sehingga memerlukan penanganan medis segera. Oleh karena itu, setiap akseptor KB perlu mengetahui tanda bahaya agar komplikasi dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.

1. Perdarahan Hebat. Perdarahan yang terjadi dalam jumlah banyak dan berlangsung lama dapat menyebabkan anemia bahkan syok.

Tanda bahaya:

- a. Mengganti pembalut setiap  $\leq 1$  jam
- b. Keluar gumpalan darah besar

- c. Pusing, lemas, atau hampir pingsan

Kemungkinan komplikasi:

- a. Anemia berat
- b. Syok hipovolemik

## 2. Nyeri Perut Hebat

Nyeri perut yang berat dan menetap bukan merupakan efek samping normal.

Kemungkinan penyebab:

- a. Infeksi panggul
- b. Kehamilan ektopik (hamil di luar kandungan)
- c. Pergeseran atau perforasi IUD

Tindakan: segera pemeriksaan medis.

## 3. Demam Tinggi Setelah Pemasangan KB

Demam dapat menandakan adanya infeksi.

Gejala yang menyertai:

- a. Nyeri panggul
- b. Keputihan berbau
- c. Badan menggigil

Kemungkinan komplikasi: Infeksi organ reproduksi (pelvic inflammatory disease).

## 4. Keputihan Abnormal

Keputihan yang berbau menyengat, berwarna kuning kehijauan, atau disertai nyeri dapat menunjukkan infeksi.

Risiko komplikasi:

- a. Infeksi saluran reproduksi
- b. Gangguan kesuburan bila tidak ditangani.

## 5. Nyeri Dada atau Sesak Napas

Terutama pada pengguna KB hormonal yang mengandung estrogen.

Kemungkinan komplikasi:

- a. Pembekuan darah (tromboemboli)
- b. Emboli paru

Ini merupakan kondisi darurat medis.

## 6. Bengkak dan Nyeri pada Kaki

Biasanya terjadi pada satu kaki.

Kemungkinan komplikasi: Deep Vein Thrombosis (DVT) atau pembekuan darah di pembuluh vena.

## 7. Sakit Kepala Berat Disertai Gangguan Penglihatan

Tidak sama dengan sakit kepala ringan biasa.

Kemungkinan komplikasi:

- a. Gangguan pembuluh darah otak
- b. Peningkatan tekanan darah akibat hormon.

## F. Cara Membedakan Efek Samping Umum Dengan Tanda Bahaya/Komplikasi

Cara Membedakan efek samping umum dengan tanda bahaya/komplikasi pada akseptor KB sangat penting agar tenaga kesehatan dapat menentukan apakah kondisi tersebut masih normal atau perlu penanganan segera. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Efek Samping Umum pada Akseptor KB

Efek samping umum adalah keluhan yang sering terjadi setelah penggunaan metode kontrasepsi dan biasanya tidak berbahaya, bersifat sementara, serta dapat hilang dengan sendirinya atau dengan penanganan sederhana.

Ciri-ciri efek samping umum

- a. Tidak mengancam nyawa
- b. Masih dalam batas normal penggunaan kontrasepsi
- c. Biasanya muncul pada awal penggunaan
- d. Dapat diatasi dengan konseling atau terapi sederhana
- e. Tidak memerlukan rujukan darurat

Adapun contoh efek samping umum dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.1**  
**Efek Samping pada Penggunaan KB**

| Metode KB | Efek Samping Umum                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Pil KB    | Mual, pusing, bercak perdarahan (spotting)                |
| Suntik KB | Amenore (tidak haid), kenaikan berat badan                |
| Implan    | Perdarahan tidak teratur                                  |
| IUD       | Nyeri perut ringan, haid lebih banyak pada awal pemakaian |

## 2. Tanda Bahaya / Komplikasi pada Akseptor KB

Tanda bahaya atau komplikasi adalah kondisi yang tidak normal, dapat membahayakan kesehatan akseptor, dan memerlukan pemeriksaan serta penanganan segera oleh tenaga kesehatan.

Ciri-ciri tanda bahaya

- Gejala berat atau tidak biasa
- Dapat mengancam kesehatan atau nyawa
- Tidak membaik dengan penanganan sederhana
- Memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut
- Kadang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap

Contoh tanda bahaya dapat dilihat pada table berikut :

| Metode KB | Tanda Bahaya / Komplikasi                            |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Pil KB    | Nyeri dada hebat, sesak napas, sakit kepala berat    |
| Suntik KB | Perdarahan sangat banyak dan lama                    |
| Implan    | Infeksi pada tempat pemasangan                       |
| IUD       | Nyeri perut hebat, demam tinggi, benang tidak teraba |

## 3. Perbedaan Efek Samping dan Tanda Bahaya

| Aspek             | Efek Samping Umum               | Tanda Bahaya / Komplikasi             |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tingkat keparahan | Ringan                          | Berat                                 |
| Risiko kesehatan  | Tidak membahayakan              | Berpotensi membahayakan               |
| Penanganan        | Konseling atau terapi sederhana | Pemeriksaan dan tindakan medis segera |
| Rujukan           | Biasanya tidak perlu            | Sering memerlukan rujukan             |
| Contoh            | Mual, spotting, amenore         | Perdarahan hebat, nyeri dada, infeksi |

## G. Algoritme penanganan awal, edukasi, dan rujukan pada keluhan prioritas

Algoritme Penanganan Awal, Edukasi, dan Rujukan pada Keluhan Prioritas Akseptor KB yang dapat digunakan oleh mahasiswa praktik klinik saat menghadapi kasus di pelayanan kebidanan.

Algoritme Penanganan Awal, Edukasi, dan Rujukan pada Keluhan Prioritas Akseptor KB

### Identifikasi Keluhan Prioritas

Mahasiswa melakukan anamnesis singkat dan cepat untuk mengetahui keluhan utama akseptor KB. Keluhan prioritas yang sering ditemukan:

1. Perdarahan tidak teratur
2. Nyeri perut atau nyeri pada lokasi pemasangan
3. Tanda infeksi
4. Tanda bahaya sistemik

Berikut algoritme yang digunakan sesuai jenis efek samping yang dialami oleh pasien :

#### 1. Algoritme Perdarahan Tidak Teratur

| <b>Tahap</b>          | <b>Tindakan</b>                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Penilaian awal        | Identifikasi jenis KB, lama penggunaan, jumlah perdarahan, dan riwayat menstruasi       |
| Skrining tanda bahaya | Perdarahan sangat banyak, pusing berat, pucat                                           |
| Penanganan awal       | Observasi kondisi umum, ukur tanda vital                                                |
| Edukasi               | Jelaskan bahwa perdarahan tidak teratur sering terjadi pada awal penggunaan KB hormonal |
| Tindak lanjut         | Anjurkan kontrol ulang jika perdarahan berlanjut                                        |
| Rujukan               | Jika perdarahan sangat banyak atau terjadi anemia                                       |

#### 2. Algoritme Nyeri pada Akseptor KB

| <b>Tahap</b>          | <b>Tindakan</b>                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Penilaian awal        | Tentukan lokasi nyeri (perut, panggul, tempat implan)           |
| Skrining tanda bahaya | Nyeri perut hebat, demam, nyeri saat bergerak                   |
| Penanganan awal       | Berikan analgesik ringan dan observasi                          |
| Edukasi               | Jelaskan bahwa nyeri ringan dapat terjadi setelah pemasangan KB |
| Tindak lanjut         | Anjurkan kontrol jika nyeri tidak membaik                       |
| Rujukan               | Jika nyeri hebat atau dicurigai infeksi                         |

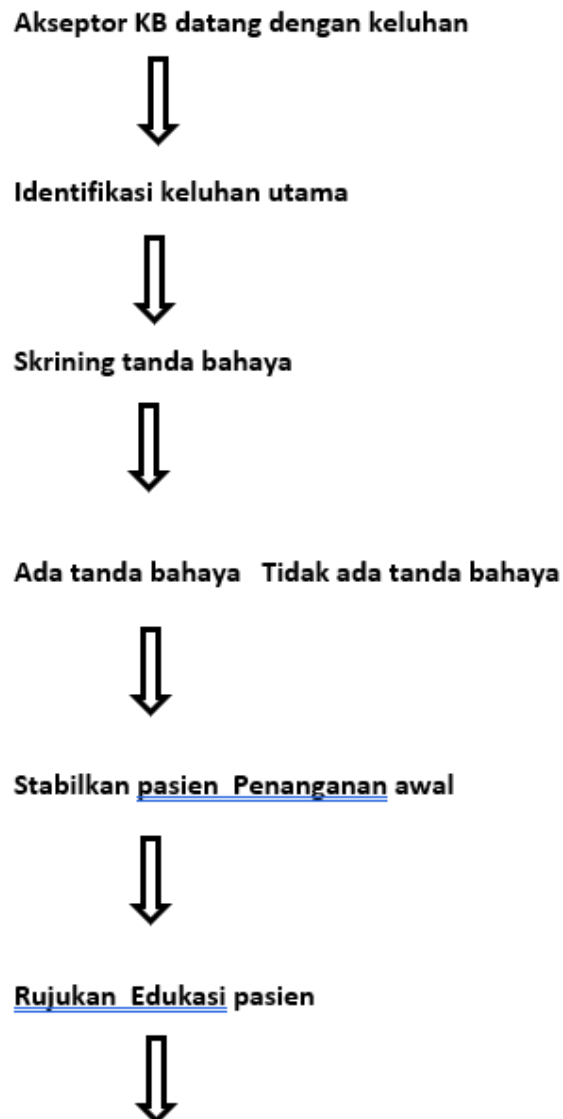
### 3. Algoritme Infeksi pada Akseptor KB

| <b>Tahap</b>          | <b>Tindakan</b>                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Penilaian awal        | Periksa tanda infeksi pada area pemasangan KB            |
| Skrining tanda bahaya | Demam tinggi, kemerahan, bengkak, keluar cairan bernanah |
| Penanganan awal       | Bersihkan area luka dan lakukan perawatan dasar          |
| Edukasi               | Ajarkan menjaga kebersihan area pemasangan               |
| Tindak lanjut         | Pantau perkembangan luka                                 |
| Rujukan               | Jika infeksi memburuk atau disertai demam tinggi         |

### 4. Algoritme Tanda Bahaya pada Akseptor KB

| <b>Tahap</b>    | <b>Tindakan</b>                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Penilaian awal  | Identifikasi gejala berat                                           |
| Tanda bahaya    | Nyeri dada, sesak napas, sakit kepala berat, penglihatan kabur      |
| Penanganan awal | Stabilkan kondisi pasien dan lakukan pemeriksaan tanda vital        |
| Edukasi         | Jelaskan bahwa kondisi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut          |
| Rujukan         | Segera rujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut |

## Flowchart Umum Penanganan Keluhan Prioritas Akseptor KB



### Prinsip Edukasi pada Akseptor KB

Mahasiswa harus menjelaskan kepada pasien mengenai:

1. Efek samping yang masih normal
2. Cara mengatasi keluhan ringan
3. Tanda bahaya yang harus segera diperiksa
4. Pentingnya kontrol ulang
5. Pilihan metode KB lain bila keluhan tidak tertoleransi

## H. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh kasus:

Seorang perempuan usia 30 tahun, P2A0, datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan bercak-bercak di luar jadwal haid sejak 2 minggu terakhir. Pasien menggunakan KB implan sejak 3 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluhkan nyeri ringan di perut bagian bawah, namun tidak disertai demam atau keputihan berbau. Hasil pemeriksaan: Keadaan umum baik, Tekanan darah: 110/70 mmHg, Nadi: 80 kali/menit, Suhu: 36,7°C, Tidak ada tanda anemia, Tidak ada nyeri tekan hebat pada abdomen.

Tugas Mahasiswa

1. Apa penyebab perdarahan tidak teratur pada kasus di atas ?
2. Jelaskan mekanisme terjadinya perdarahan tidak teratur pada pengguna kontrasepsi hormonal ?
3. Sebutkan langkah penanganan yang tepat untuk keluhan perdarahan dan nyeri yang dialami pasien ?
4. Jelaskan tanda bahaya pada akseptor KB yang memerlukan rujukan segera?
5. Jelaskan konseling yang tepat kepada pasien terkait efek samping kontrasepsi yang dialami ?

### Soal OSCE Kebidanan

| No. | Komponen    | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | No. Stasiun | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | Judul       | Penanganan Efek Samping dan Komplikasi KB: Perdarahan Tidak Teratur, Nyeri, dan Tanda Bahaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Kasus       | Penanganan Efek Samping dan Komplikasi KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | Tujuan      | Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:<br>1. Komunikasi terapeutik dengan pasien.<br>2. Anamnesis singkat terkait keluhan pasien.<br>3. Kemungkinan penyebab perdarahan tidak teratur pada pasien.<br>4. Penanganan yang tepat terhadap keluhan pasien.<br>5. Tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh pasien.<br>6. Konseling dan rencana tindak lanjut kepada pasien. |
| 5   | Kompetensi  | 1. Lakukan komunikasi terapeutik dengan pasien.<br>2. Lakukan anamnesis singkat terkait keluhan pasien.<br>3. Jelaskan kemungkinan penyebab perdarahan tidak teratur pada pasien.<br>4. Tentukan penanganan yang tepat terhadap keluhan pasien.<br>5. Jelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh pasien.                                                                                                                     |

| No. | Komponen                               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                        | 6. Berikan konseling dan rencana tindak lanjut kepada pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6   | Soal: Skenario dan tugas peserta ujian | <p><b>SKENARIO KLINIK</b></p> <p>Seorang perempuan usia 29 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan bercak-bercak di luar jadwal haid sejak 3 minggu terakhir. Pasien mengatakan bahwa ia menggunakan KB suntik 3 bulan sejak 6 bulan yang lalu.</p> <p>Selain itu pasien juga mengeluhkan nyeri ringan di perut bagian bawah, namun tidak ada demam, tidak ada keputihan berbau, dan tidak ada perdarahan banyak. Hasil pemeriksaan awal: Tekanan darah: 110/70 mmHg, Nadi: 80 kali/menit, Suhu: 36,7°C, Keadaan umum: baik</p> <p><b>TUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan komunikasi terapeutik dengan pasien.</li> <li>2. Lakukan anamnesis singkat terkait keluhan pasien.</li> <li>3. Jelaskan kemungkinan penyebab perdarahan tidak teratur pada pasien.</li> <li>4. Tentukan penanganan yang tepat terhadap keluhan pasien.</li> <li>5. Jelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh pasien.</li> <li>6. Berikan konseling dan rencana tindak lanjut kepada pasien.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7   | Instruksi pengujian                    | <p><b>INSTRUKSI UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji diminta membaca skenario dan checklist penilaian sebelum pelaksanaan OSCE.</li> <li>2. Pastikan seluruh alat dan bahan yang diperlukan pada stasiun tersedia sebelum peserta masuk.</li> <li>3. Penguji tidak diperkenankan memberi petunjuk atau membantu peserta, kecuali jika peserta meminta klarifikasi terhadap instruksi soal.</li> <li>4. Penguji hanya memberikan informasi tambahan jika peserta menanyakan secara langsung dan sesuai dengan skenario kasus.</li> <li>5. Penilaian dilakukan berdasarkan checklist yang telah disediakan secara objektif.</li> <li>6. Penguji harus memperhatikan komunikasi, ketepatan langkah, dan kemampuan analisis peserta selama simulasi.</li> <li>7. Waktu pelaksanaan stasiun adalah 10–15 menit untuk setiap peserta.</li> <li>8. Setelah waktu selesai, penguji meminta peserta menghentikan tindakan yang sedang dilakukan.</li> </ol> <p><b>INSTRUKSI KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Penguji berperan sebagai pengamat selama peserta melakukan anamnesis dan konseling kepada pasien standar.</li> <li>2. Jika peserta menanyakan kondisi pasien, penguji atau pasien standar memberikan jawaban sesuai dengan skenario berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien menggunakan KB suntik 3 bulan sejak 6 bulan terakhir</li> <li>b. Mengalami perdarahan bercak di luar haid selama 3 minggu</li> </ol> </li> </ol> |

| No. | Komponen | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mengeluhkan nyeri ringan di perut bagian bawah</li> <li>d. Tidak ada demam</li> <li>e. Tidak ada keputihan berbau</li> <li>f. Tidak ada perdarahan banyak</li> </ul> <p>3. Jika peserta menanyakan tanda vital, berikan data berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah: 110/70 mmHg</li> <li>b. Nadi: 80 kali/menit</li> <li>c. Suhu: 36,7°C</li> </ul> <p>4. Penguji menilai kemampuan peserta dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan komunikasi terapeutik</li> <li>b. Menggali riwayat penggunaan KB</li> <li>c. Mengidentifikasi penyebab perdarahan tidak teratur</li> <li>d. Menentukan penanganan yang tepat</li> <li>e. Mengidentifikasi tanda bahaya</li> <li>f. Memberikan konseling kepada pasien</li> </ul> <p>5. Berikan skor sesuai dengan rubrik atau checklist penilaian yang telah disediakan.</p> <p>6. Catat jika peserta melakukan kesalahan kritis (critical items), seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menjelaskan tanda bahaya</li> <li>b. Memberikan penatalaksanaan yang salah</li> <li>c. Tidak melakukan komunikasi dengan pasien</li> </ul> <p>7. Setelah peserta selesai, penguji menandatangani lembar penilaian OSCE.</p> <p><b>INSTRUKSI TAMBAHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji harus memastikan bahwa peserta memahami instruksi stasiun sebelum memulai kegiatan, namun tidak memberikan arahan mengenai langkah yang harus dilakukan peserta.</li> <li>2. Penguji harus menjaga suasana ujian yang kondusif, tenang, dan objektif, sehingga peserta dapat menunjukkan kompetensinya secara optimal.</li> <li>3. Apabila peserta terhenti atau ragu, penguji tidak diperkenankan memberikan petunjuk, tetapi dapat mengingatkan sisa waktu yang tersedia.</li> <li>4. Penguji harus mencatat setiap langkah penting yang dilakukan peserta sesuai dengan checklist penilaian.</li> <li>5. Apabila peserta melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, penguji tetap membiarkan peserta melanjutkan sampai waktu selesai, kemudian memberikan penilaian sesuai rubrik.</li> <li>6. Penguji perlu memperhatikan aspek komunikasi interpersonal, seperti sikap empati, kesopanan, dan kemampuan peserta dalam menjelaskan kondisi pasien.</li> </ul> |

| No. | Komponen                   | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | <p>7. Apabila peserta menanyakan informasi tambahan yang tidak tercantum dalam skenario, penguji dapat menjawab dengan kalimat:<br/> <i>"Data tersebut tidak tersedia dalam skenario."</i></p> <p>8. Penguji harus memastikan bahwa penilaian diberikan secara konsisten dan adil kepada semua peserta.</p> <p>9. Setelah ujian selesai, penguji diminta untuk menyerahkan lembar penilaian kepada panitia OSCE sesuai prosedur yang berlaku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   | Kebutuhan dan instruksi PS | <p>Instruksi PS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PS berperan sebagai pasien</li> <li>2. PS Pasien datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan bercak-bercak di luar jadwal haid sejak sekitar 3 minggu yang lalu.</li> <li>3. PS menjawab pertanyaan peserta sesuai dengan skenario yang telah diberikan.</li> <li>4. Jika peserta memberikan konseling, dengarkan dengan baik dan respon secara wajar sebagai pasien.</li> <li>5. Jangan membantu peserta dengan memberikan petunjuk tentang jawaban atau diagnosis.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9   | Dialog PS                  | <p>Peserta:</p> <p>Peserta : Selamat pagi, Bu. Perkenalkan saya bidan/mahasiswa yang bertugas hari ini. Nama saya Ani. Apakah Ibu bersedia saya lakukan wawancara singkat untuk mengetahui keluhan Ibu?</p> <p>PS : Iya, boleh, Bu.</p> <p>Peserta: Baik, Bu. Siapa nama Ibu dan berapa usia Ibu?</p> <p>PS : Nama saya Siti, umur saya 29 tahun.</p> <p>Peserta: Apa keluhan utama yang Ibu rasakan saat ini?</p> <p>PS : Saya mengalami perdarahan bercak-bercak di luar jadwal haid sejak sekitar tiga minggu yang lalu.</p> <p>Peserta: Apakah sebelumnya Ibu menggunakan alat kontrasepsi atau KB?</p> <p>PS: Iya, saya menggunakan KB suntik tiga bulan.</p> <p>Peserta: Sejak kapan Ibu menggunakan KB suntik tersebut?</p> <p>PS : Sudah sekitar enam bulan.</p> <p>Peserta: Selain perdarahan, apakah Ibu merasakan keluhan lain seperti nyeri perut, demam, atau keputihan berbau?</p> <p>PS :Ada sedikit nyeri di perut bagian bawah, tapi tidak terlalu sakit. Saya tidak demam dan tidak ada keputihan berbau.</p> <p>Peserta: Apakah perdarahannya banyak seperti haid atau hanya bercak?</p> <p>PS : Hanya bercak saja, tidak banyak.</p> <p>PS : Apakah kondisi ini berbahaya, Bu?</p> <p>Peserta: Keluhan yang Ibu alami kemungkinan merupakan efek samping dari penggunaan KB suntik. Pada beberapa wanita,</p> |

| No. | Komponen          | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | <p>penggunaan kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan perdarahan tidak teratur terutama pada awal penggunaan.</p> <p>PS : Apakah saya harus berhenti menggunakan KB suntik ini?</p> <p>Peserta: Tidak selalu harus dihentikan, Bu. Biasanya kondisi ini akan membaik seiring waktu. Namun jika perdarahan menjadi banyak, nyeri semakin hebat, atau muncul demam, Ibu perlu segera kembali ke fasilitas kesehatan.</p> <p>PS :Baik, Bu.</p> <p>Peserta: Saya sarankan Ibu tetap memantau kondisi perdarahan. Jika keluhan berlanjut atau bertambah berat, silakan kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut.</p> <p>PS : Baik, terima kasih atas penjelasannya.</p> <p>Peserta: Sama-sama, Bu. Semoga Ibu selalu sehat.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien standar harus mengikuti alur dialog sesuai skenario dan tidak memberikan informasi tambahan jika tidak ditanyakan oleh peserta.</li> <li>2. Jika peserta melakukan komunikasi terapeutik dengan baik, pasien dapat merespon secara kooperatif dan menunjukkan sikap terbuka terhadap pertanyaan yang diajukan.</li> <li>3. Pasien standar harus menyampaikan keluhan utama berupa perdarahan bercak di luar jadwal haid selama kurang lebih tiga minggu.</li> </ol> |
| 10  | Kebutuhan manikin | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11  | Kebutuhan laboran | <p>Peran laboran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan ruangan stasiun OSCE sesuai dengan skenario yang telah ditentukan.</li> <li>2. Menyiapkan manekin kebidanan atau alat simulasi yang diperlukan.</li> <li>3. Menyediakan alat dan bahan yang digunakan pada stasiun, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meja dan kursi</li> <li>b. Bed pemeriksaan</li> <li>c. Sarung tangan</li> <li>d. Tensimeter (simulasi)</li> <li>e. Termometer (simulasi)</li> <li>f. Lembar status pasien</li> </ol> </li> <li>4. Memastikan lembar soal peserta dan checklist penilaian tersedia untuk penguji.</li> <li>5. Memastikan timer atau penanda waktu berfungsi dengan baik.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12  | Kebutuhan alat    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter (alat pengukur tekanan darah)</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Termometer</li> <li>4. Jam tangan atau stopwatch (untuk menghitung nadi)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No. | Komponen  | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | 5. Sarung tangan (handscoon)<br>6. Bed pemeriksaan<br>7. Kain penutup pasien (duk)<br>8. Media edukasi tentang kontrasepsi atau efek samping KB<br>9. Leaflet atau lembar informasi KB<br>10. Lembar status pasien atau rekam medis<br>11. Lembar soal OSCE untuk peserta<br>12. Lembar checklist penilaian untuk penguji<br>13. Alat tulis (pulpen/pensil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13  | Penulis   | Bd. Nur Aliyah Rangkutim S.Keb, M.KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14  | Referensi | 1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.<br>2. World Health Organization. (2023). Family Planning: A Global Handbook for Providers (Updated Edition). Geneva: World Health Organization.<br>3. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2022). Birth Control (Contraception) FAQs. Washington, DC: ACOG.<br>4. Fatonah, S., Fitriani, Husna Sari, et al. (2023). Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.<br>5. Lestari, L., Septiana, A. R., Setyowati, et al. (2024). Hubungan KB Suntik dengan Efek Samping KB Suntik. Prosiding Seminar Nasional Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo.<br>6. Nurullah, F. A. (2021). Perkembangan Metode Kontrasepsi di Indonesia. <i>Cermin Dunia Kedokteran</i> , 48(3).<br>7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). Peraturan BKKBN tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan. Jakarta: BKKBN. |

## RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Penanganan Efek Samping dan Komplikasi KB

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

| No | Komponen Penilaian                                                       | Skor 0                  | Skor 1                           | Skor 2                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Komunikasi terapeutik (menyapa, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan) | Tidak dilakukan         | Dilakukan tetapi kurang lengkap  | Dilakukan dengan baik dan lengkap     |
| 2  | Anamnesis keluhan utama                                                  | Tidak menanyakan        | Menanyakan sebagian              | Menanyakan secara lengkap             |
| 3  | Riwayat penggunaan KB                                                    | Tidak menanyakan        | Menanyakan tetapi kurang lengkap | Menanyakan secara lengkap             |
| 4  | Identifikasi keluhan tambahan (nyeri, demam, keputihan)                  | Tidak dilakukan         | Sebagian ditanyakan              | Dilakukan secara lengkap              |
| 5  | Penilaian kondisi pasien (tanda vital atau kondisi umum)                 | Tidak dilakukan         | Dilakukan tetapi kurang tepat    | Dilakukan dengan benar                |
| 6  | Menjelaskan penyebab efek samping KB                                     | Tidak mampu menjelaskan | Penjelasan kurang tepat          | Penjelasan tepat dan jelas            |
| 7  | Penentuan penanganan yang tepat                                          | Tidak tepat             | Kurang tepat                     | Tepat sesuai standar                  |
| 8  | Identifikasi tanda bahaya                                                | Tidak menyebutkan       | Menyebutkan sebagian             | Menyebutkan dengan lengkap            |
| 9  | Pemberian konseling kepada pasien                                        | Tidak dilakukan         | Dilakukan tetapi kurang jelas    | Dilakukan dengan jelas dan sistematis |
| 10 | Rencana tindak lanjut atau kontrol                                       | Tidak dilakukan         | Disebutkan tetapi kurang jelas   | Dijelaskan dengan baik                |

| Rentang Nilai | Kategori    |
|---------------|-------------|
| 17 – 20       | Sangat Baik |
| 13 – 16       | Baik        |
| 9 – 12        | Cukup       |
| ≤ 8           | Kurang      |

## KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

| No | Tahapan Tindakan           | Prosedur                                                                                             | Skoring | Skor |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1  | Persiapan Petugas          | Petugas menggunakan pakaian kerja yang rapi, mencuci tangan, dan menyiapkan alat yang diperlukan.    |         |      |
| 2  | Persiapan Alat             | Menyiapkan tensimeter, stetoskop, termometer, sarung tangan, lembar status pasien, dan alat tulis.   |         |      |
| 3  | Persiapan Pasien           | Menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada pasien dan memastikan pasien dalam posisi nyaman.              |         |      |
| 4  | Komunikasi Terapeutik      | Menyapa pasien dengan ramah, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan pemeriksaan.                |         |      |
| 5  | Anamnesis Keluhan Utama    | Menanyakan keluhan utama pasien seperti perdarahan tidak teratur atau nyeri.                         |         |      |
| 6  | Riwayat Penggunaan KB      | Menanyakan jenis kontrasepsi yang digunakan, lama penggunaan, serta riwayat efek samping sebelumnya. |         |      |
| 7  | Anamnesis Keluhan Tambahan | Menanyakan adanya keluhan lain seperti nyeri perut, demam, keputihan berbau, atau perdarahan banyak. |         |      |
| 8  | Pemeriksaan Tanda Vital    | Mengukur tekanan darah, nadi, suhu, dan                                                              |         |      |

| No | Tahapan Tindakan          | Prosedur                                                                                                              | Skoring | Skor |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|    |                           | menilai kondisi umum pasien.                                                                                          |         |      |
| 9  | Identifikasi Masalah      | Menentukan kemungkinan penyebab efek samping berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan.                             |         |      |
| 10 | Penatalaksanaan           | Memberikan penanganan sesuai kondisi pasien dan menjelaskan kemungkinan efek samping dari kontrasepsi yang digunakan. |         |      |
| 11 | Identifikasi Tanda Bahaya | Mengidentifikasi tanda bahaya seperti perdarahan banyak, nyeri perut hebat, demam tinggi, atau dugaan kehamilan.      |         |      |
| 12 | Rujukan                   | Jika ditemukan tanda bahaya, pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.                                |         |      |
| 13 | Konseling                 | Memberikan edukasi mengenai efek samping KB, cara mengatasi keluhan, dan kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan.  |         |      |
| 14 | Dokumentasi               | Mencatat hasil anamnesis, pemeriksaan, tindakan yang diberikan, serta rencana tindak lanjut pada rekam medis.         |         |      |

| No   | Tahapan Tindakan                                  | Prosedur | Skoring | Skor |
|------|---------------------------------------------------|----------|---------|------|
| Skor | Kriteria                                          |          |         |      |
| 2    | Dilakukan dengan benar, lengkap, dan sistematis   |          |         |      |
| 1    | Dilakukan tetapi kurang tepat atau kurang lengkap |          |         |      |
| 0    | Tidak dilakukan atau dilakukan dengan salah       |          |         |      |

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh / Skor maksimal) × 100

### KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

| No | Komponen yang Dinilai                | Skor 0                                      | Skor 1                                               | Skor 2                                                           |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Membuka komunikasi dengan pasien     | Tidak menyapa dan tidak memperkenalkan diri | Menyapa tetapi tidak memperkenalkan diri atau tujuan | Menyapa, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan dengan baik |
| 2  | Menggali informasi pasien            | Tidak menanyakan keluhan atau riwayat KB    | Menanyakan sebagian informasi                        | Menanyakan keluhan dan riwayat KB secara lengkap                 |
| 3  | Menjelaskan kondisi pasien           | Tidak menjelaskan kondisi pasien            | Penjelasan kurang jelas                              | Menjelaskan kondisi pasien dengan jelas                          |
| 4  | Memberikan informasi efek samping KB | Tidak memberikan informasi                  | Informasi kurang lengkap                             | Informasi lengkap dan benar                                      |
| 5  | Menjelaskan tanda bahaya             | Tidak menjelaskan tanda bahaya              | Menyebutkan sebagian tanda bahaya                    | Menjelaskan tanda bahaya secara lengkap                          |
| 6  | Memberikan solusi atau penanganan    | Tidak memberikan solusi                     | Solusi kurang tepat                                  | Solusi tepat sesuai kondisi pasien                               |
| 7  | Memberikan kesempatan bertanya       | Tidak memberi kesempatan bertanya           | Memberi kesempatan tetapi terbatas                   | Memberi kesempatan dan merespon dengan baik                      |
| 8  | Memberikan anjuran kontrol           | Tidak menjelaskan kontrol                   | Menjelaskan tetapi kurang jelas                      | Menjelaskan jadwal kontrol dengan jelas                          |
| 9  | Menutup konseling                    | Tidak menutup konseling                     | Menutup tetapi kurang sistematis                     | Menutup konseling dengan baik                                    |

Skor maksimal: 18

Perhitungan Nilai

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh / 18) × 100

#### KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

| No | Komponen Penilaian        | Skor 0                              | Skor 1                                      | Skor 2                             |
|----|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Penampilan profesional    | Tidak rapi dan tidak sesuai standar | Rapi tetapi kurang lengkap                  | Rapi dan sesuai standar            |
| 2  | Sikap sopan dan empati    | Tidak menunjukkan empati            | Menunjukkan empati tetapi kurang konsisten  | Menunjukkan empati dengan baik     |
| 3  | Etika komunikasi          | Bahasa tidak sopan atau tidak jelas | Bahasa cukup jelas tetapi kurang sistematis | Bahasa sopan dan mudah dipahami    |
| 4  | Menghargai privasi pasien | Tidak menjaga privasi               | Menjaga privasi tetapi kurang optimal       | Menjaga privasi pasien dengan baik |
| 5  | Tanggung jawab            | Tidak mengikuti prosedur            | Mengikuti sebagian prosedur                 | Mengikuti prosedur dengan baik     |
| 6  | Kerja sama                | Tidak kooperatif                    | Cukup kooperatif                            | Kooperatif dan profesional         |
| 7  | Disiplin                  | Tidak mengikuti aturan              | Mengikuti aturan sebagian                   | Mengikuti aturan dengan baik       |

Skor maksimal: 14

Perhitungan Nilai

Nilai = (Jumlah skor yang diperoleh / 14) × 100

## TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

**TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3**

*(dicatat di rubrik penilaian)*

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

| TIDAK LULUS | BORDERLINE | LULUS | SUPERIOR |
|-------------|------------|-------|----------|
|             |            |       |          |

Jumlah total skore

Nilai akhir =  $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota), .....

.....  
Penguji:.....

### I. Aktivitas 2 — Shows How

1. Menunjukkan Cara Penanganan Perdarahan Tidak Teratur
2. Menunjukkan Cara Penanganan Nyeri pada Akseptor KB
3. Menunjukkan Cara Mengidentifikasi Tanda Bahaya
4. Menunjukkan Cara Edukasi kepada Akseptor KB

Asesmen (Piramida Miller)

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Level Miller      | Metode                          |
| Knows / Knows How | Self-check + analisis mini-case |
| Shows How         | OSCE Asuhan Kala II             |

Catatan untuk penulis:

Karena CP Bab = mendemonstrasikan

OSCE logis, bukan dipaksakan

### Asesmen (Piramida Miller)

| Level Miller      | Metode                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Knows / Knows How | Studi kasus tertulis+ Diskusi kelompok+ Analisis skenario |
| Shows How         | OSCE+ Simulasi praktik+ Role play konseling KB            |

### OSCE Ringkas + Critical Items

| Kriteria            | 4                | 3     | 2            | 1          |
|---------------------|------------------|-------|--------------|------------|
| Keselamatan pasien  | Aman & konsisten | Minor | Risiko kecil | Tidak aman |
| Asesmen & keputusan | Tepat & jelas    | Cukup | Ragu         | Keliru     |
| Komunikasi          | Empatik & jelas  | Baik  | Kurang       | Buruk      |

Catatan untuk penulis:

Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

### OSCE Ringkas + Critical Items

#### Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Melakukan komunikasi terapeutik.
2. Menggali riwayat penggunaan KB.
3. Mengidentifikasi efek samping atau tanda bahaya.
4. Memberikan edukasi yang benar.
5. Menentukan rencana tindak lanjut.

### Checklist Penilaian OSCE

| No | Komponen Penilaian                                           | Skor (0–1) |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Memberi salam dan memperkenalkan diri                        |            |
| 2  | Menanyakan keluhan utama                                     |            |
| 3  | Menggali riwayat penggunaan KB                               |            |
| 4  | Menanyakan pola perdarahan                                   |            |
| 5  | Menanyakan nyeri dan gejala penyerta                         |            |
| 6  | Menanyakan kemungkinan kehamilan                             |            |
| 7  | Menilai adanya tanda bahaya                                  |            |
| 8  | Menjelaskan bahwa spotting dapat menjadi efek samping normal |            |
| 9  | Memberikan edukasi tanda bahaya                              |            |
| 10 | Menjelaskan rencana tindak lanjut/kontrol                    |            |

| No | Komponen Penilaian             | Skor (0–1) |
|----|--------------------------------|------------|
| 11 | Komunikasi empatik dan jelas   |            |
| 12 | Menutup konsultasi dengan baik |            |

#### Kriteria Penilaian

1. 10–12 poin benar → Kompeten
2. 7–9 poin → Cukup kompeten (perlu perbaikan)
3. ≤6 poin → Belum kompeten

#### **DOPS (Does)**

Praktik di lahan praktek

1. Observasi langsung akseptor KB
2. Mini-CEX
3. Checklist + umpan balik singkat
4. Kesimpulan penilaian

#### **Portofolio**

1. Identitas + catatan kasus singkat
2. OSCE
3. Bukti Kegiatan (Evidence)
4. Feedback CI/dosen
5. Rencana Tindak Lanjut

#### **J. Ringkasan Materi**

Penanganan Efek Samping dan Komplikasi KB: Perdarahan Tidak Teratur, Nyeri, dan Tanda Bahaya

Pelayanan keluarga berencana (KB) bertujuan membantu pasangan usia subur dalam merencanakan kehamilan secara aman dan efektif. Penggunaan kontrasepsi, terutama metode hormonal seperti pil, suntik, dan implan, dapat menimbulkan efek samping maupun komplikasi yang perlu dipahami oleh tenaga kesehatan dan akseptor KB.

Perdarahan tidak teratur merupakan efek samping yang paling sering terjadi akibat perubahan hormon yang memengaruhi lapisan dinding rahim (endometrium). Kondisi ini umumnya tidak berbahaya dan sering muncul pada bulan-bulan awal penggunaan KB hormonal. Penanganan dilakukan dengan memastikan tidak terjadi kehamilan atau penyakit lain, memberikan edukasi kepada pasien, serta melakukan pemantauan lanjutan.

Nyeri ringan, seperti nyeri perut atau sakit kepala, juga dapat muncul sebagai respons tubuh terhadap perubahan hormonal. Penanganannya meliputi pengkajian intensitas nyeri, pemberian terapi simptomatik (misalnya analgesik ringan), serta observasi untuk memastikan tidak ada tanda komplikasi.

Adapun Red Flags (Tanda Bahaya pada Akseptor KB) yaitu :

1. Perdarahan
  - a. Perdarahan sangat banyak (mengganti pembalut setiap  $\leq 1$  jam)
  - b. Perdarahan berlangsung lama ( $> 14$  hari)
  - c. Disertai lemas berat, pucat, atau pingsan
  - d. Dugaan anemia berat
2. Nyeri
  - a. Nyeri perut hebat dan mendadak
  - b. Nyeri panggul berat
  - c. Nyeri tidak membaik dengan obat ringan
  - d. Nyeri disertai demam atau muntah
3. Tanda Sistemik Serius
  - a. Pusing berat atau kehilangan kesadaran
  - b. Sesak napas atau nyeri dada (dugaan emboli)
  - c. Sakit kepala hebat mendadak
  - d. Gangguan penglihatan atau bicara
  - e. Pembengkakan atau nyeri pada tungkai (dugaan trombosis)
4. Tanda Infeksi
  - a. Demam  $\geq 38^{\circ}\text{C}$
  - b. Keputihan berbau menyengat
  - c. Nyeri tekan perut bawah

Penatalaksanaan efek samping dan komplikasi KB dilakukan melalui langkah sistematis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, penilaian kondisi pasien, edukasi, konseling, serta keputusan melanjutkan, mengganti, atau merujuk metode kontrasepsi.

Secara umum, sebagian besar keluhan pada akseptor KB merupakan efek samping normal yang dapat ditangani dengan edukasi dan pemantauan. Komunikasi yang baik dan deteksi dini tanda bahaya sangat penting untuk menjaga keamanan serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi.

## K. Referensi

- Affandi, B., Adriaansz, G., Gunardi, E. R., & Koesno, H. (2014). *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Berek & Novak's Gynecology (2020) 16th edn. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: BKKBN; 2020 (masih digunakan dalam praktik pelayanan KB nasional).

- Centers for Disease Control and Prevention (2021) *U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use, 2021*. Atlanta: CDC.
- Eva Noordiana, M., & Eka Prameswari, V. (2025). *ASUHAN KEBIDANAN PADA Ny. F UMUR 26 TAHUN DI POLINDES MAJARAN (asuhan berkelanjutan pada masa kehamilan, bersalin, nifas, bbl, dan kb)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI).
- Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (2019) *Management of unscheduled bleeding in women using hormonal contraception*. London: FSRH.
- Fathonah, S., Dewi Y, A., & Yuswo Yani, L. (2025). *Asuhan Kebidanan Pada Ny. "A" Mulai Masa Kehamilan, Bersalin, Nifas, BBL, Neonatus dan KB di PMB "AINUN JARIYA" Desa Karang Nangkah, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) *Pedoman pelayanan keluarga berencana*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI; 2021–2023 edisi implementasi terbaru
- Kementerian Kesehatan RI. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) – Revisi terbaru*. Jakarta: Kemenkes RI; 2020–2023 revisi.
- Machfudloh, S. S., Kes, M. H., Keb, M., Lely Khulafa'ur, R., ST, S., Hardiningsih, S. S. T., ... & Lidya, B. N. (2025). *BUKU AJAR KB DAN PELAYANAN*. Optimal Untuk Negeri.
- Maya, D. R., & Mardiyana, R. (2025). *ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. M PADA MASA HAMIL SAMPAI KB DAN NEONATUS DI RUMAH SAKIT DIAN HUSADA MOJOKERTO* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI).
- Pranata, P. (2020) *Keluarga Berencana dan Reproduksi Sehat*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmawati, N. A. (2025). *ASUHAN KEBIDANAN PADA NY" A" USIA 28 TAHUN DI TPMB LIDA KHALIMATUS S DI PURI MOJOKERTO* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto).
- Saifuddin dkk. – *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (2014)
- Saifuddin, A. B. (2016). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Williams Gynecology (2020) 4th edn. New York: McGraw-Hill Education.

World Health Organization (2015) *Medical eligibility criteria for contraceptive use*. 5th edn. Geneva: WHO.

World Health Organization (2018) *Family planning: A global handbook for providers*. 3rd edn. Geneva: WHO.

# BAB 4

## KONTRASEPSI PADA KONDISI KHUSUS: REMAJA, PERIMENOPAUSE, PENYAKIT KRONIS, DAN RISIKO TINGGI

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang Didukung

---

- CPMK 1  
Menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika–legal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan.
- CPMK 3  
Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien.
- CPMK 4 (CPMK Utama)  
Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut.

### Sub Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

---

- Sub-CPMK4.1  
Mempraktikkan komunikasi terapeutik dan alur konseling terstruktur untuk menggali kebutuhan klien pada kondisi khusus.
- Sub-CPMK 4.2  
Melakukan informed choice, skrining kelayakan, dan menyusun rencana tindak lanjut dalam pemilihan kontrasepsi pada kondisi khusus.

### Tujuan Pembelajaran

---

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pemilihan kontrasepsi pada kondisi khusus serta mampu menerapkan konseling keluarga berencana secara efektif melalui komunikasi terapeutik, informed choice, dan skrining kelayakan dengan pendekatan yang berpusat pada klien.

## Capaian Pembelajaran Bab

---

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menganalisis konsep dan kebijakan pelayanan kontrasepsi pada kondisi khusus. *(CPMK 1)*
- Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak reproduksi klien dalam pemilihan kontrasepsi. *(CPMK 3)*
- mempraktikkan komunikasi terapeutik dalam menggali kebutuhan klien. *(Sub-CPMK 4.1)*
- Melakukan konseling KB menggunakan pendekatan informed choice. *(Sub-CPMK 4.2)*
- Melakukan skrining kelayakan metode kontrasepsi berdasarkan kondisi medis klien. *(Sub-CPMK 4.2)*
- Menentukan metode kontrasepsi yang aman dan sesuai pada kondisi khusus. *(CPMK 4)*
- Menyusun rencana tindak lanjut pelayanan KB. *(CPMK 4)*

## Uraian Materi

---

Kontrasepsi merupakan metode atau upaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan menggunakan alat, obat, atau prosedur tertentu yang bersifat sementara maupun permanen. Penggunaan kontrasepsi merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan reproduksi karena memungkinkan individu atau pasangan untuk merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta menentukan waktu kehamilan yang aman bagi kesehatan ibu dan anak. Layanan kontrasepsi juga berperan dalam menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan serta komplikasi kehamilan yang dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu. Dalam praktik klinis, pemilihan metode kontrasepsi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, kondisi kesehatan, riwayat penyakit, efektivitas metode, serta preferensi pengguna agar metode yang dipilih aman dan sesuai dengan kebutuhan reproduksi seseorang (Whitburn et al., 2025).

Pada kelompok remaja, penggunaan kontrasepsi merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Remaja merupakan kelompok usia yang mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan sehingga rentan terhadap perilaku seksual berisiko dan kehamilan yang tidak direncanakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa remaja, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis, tetap memiliki aktivitas seksual yang sebanding dengan remaja tanpa penyakit kronis sehingga membutuhkan akses terhadap layanan kontrasepsi yang memadai. Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap kontrasepsi dapat meningkatkan risiko kehamilan tidak diinginkan serta masalah kesehatan reproduksi lainnya pada kelompok ini (Addison et al., 2024). Selain itu, perkembangan pedoman terbaru juga menekankan pentingnya konseling kontrasepsi berbasis bukti dan berpusat pada pasien untuk membantu remaja memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan preferensi mereka (Carleen & Ebersole, 2025).

Pada perempuan yang memasuki masa perimenopause, penggunaan kontrasepsi tetap diperlukan meskipun tingkat kesuburan mulai menurun. Perimenopause merupakan masa transisi sebelum menopause yang ditandai dengan perubahan hormonal, ketidakaturan siklus menstruasi, dan penurunan fungsi ovarium secara bertahap. Meskipun fertilitas menurun, kemungkinan terjadinya kehamilan masih tetap ada sehingga kontrasepsi tetap diperlukan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan pada usia di atas 40 tahun memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi obstetri seperti keguguran, hipertensi dalam kehamilan, dan komplikasi perinatal. Oleh karena itu, pemilihan metode kontrasepsi pada masa ini perlu mempertimbangkan faktor risiko kesehatan seperti penyakit

kardiovaskular, gangguan metabolik, dan faktor usia. Beberapa metode kontrasepsi hormonal juga dapat memberikan manfaat tambahan pada masa perimenopause, seperti membantu mengontrol ketidakaturan menstruasi dan mengurangi gejala hormonal (Guerin et al., 2022). Selain faktor usia, kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit kronis juga memerlukan perhatian khusus dalam pemilihan metode kontrasepsi. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, lupus, epilepsi, dan penyakit ginjal dapat memengaruhi keamanan penggunaan metode kontrasepsi tertentu, terutama metode hormonal yang mengandung estrogen. Pada kondisi tersebut, tenaga kesehatan perlu melakukan penilaian medis yang komprehensif untuk memastikan bahwa metode kontrasepsi yang dipilih tidak memperburuk kondisi penyakit yang diderita. Pendekatan individual dalam konseling kontrasepsi sangat penting untuk menyeimbangkan antara manfaat dan risiko penggunaan kontrasepsi pada perempuan dengan kondisi medis tertentu (Addison et al., 2024).

Kontrasepsi juga sangat penting bagi perempuan dengan kondisi risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan. Kehamilan risiko tinggi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, riwayat komplikasi obstetri sebelumnya, jarak kehamilan yang terlalu dekat, maupun adanya penyakit kronis tertentu. Pada kondisi ini, kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi serius bagi ibu maupun janin sehingga pencegahan kehamilan melalui penggunaan kontrasepsi yang efektif menjadi sangat penting. Metode kontrasepsi jangka panjang yang reversibel seperti alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dan implan sering direkomendasikan karena memiliki efektivitas tinggi dan tingkat kegagalan yang rendah dibandingkan metode lainnya. Pemilihan metode kontrasepsi pada kelompok risiko tinggi harus dilakukan melalui konseling yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, faktor risiko, serta preferensi pengguna agar tercapai penggunaan kontrasepsi yang aman dan efektif (Whitburn et al., 2025);(Devalla, 2024). Secara keseluruhan, pemilihan metode kontrasepsi pada kondisi khusus seperti remaja, perempuan perimenopause, individu dengan penyakit kronis, serta kelompok dengan risiko tinggi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah. Konseling yang tepat oleh tenaga kesehatan sangat penting untuk membantu klien memahami berbagai pilihan metode kontrasepsi, manfaat, risiko, serta cara penggunaan yang benar. Dengan pemilihan metode kontrasepsi yang tepat, kesehatan reproduksi perempuan dapat terjaga, kehamilan yang tidak direncanakan dapat dicegah, dan risiko komplikasi kehamilan dapat diminimalkan.

## A. Mini Kasus

Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke klinik untuk memilih metode kontrasepsi. Ia memiliki dua anak dan tidak ingin menambah anak lagi dalam waktu dekat. Klien memiliki riwayat hipertensi yang terkontrol dengan obat. Saat ini ia masih menyusui anaknya yang berusia 6 bulan.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana pendekatan komunikasi yang harus dilakukan bidan untuk menggali kebutuhan klien dalam memilih kontrasepsi?
2. Informasi apa yang perlu disampaikan kepada klien mengenai pilihan metode kontrasepsi yang aman bagi ibu menyusui dan penderita hipertensi?
3. Metode kontrasepsi apa yang paling sesuai dengan kondisi klien tersebut? Jelaskan alasannya.
4. Skrining medis apa yang perlu dilakukan sebelum memberikan kontrasepsi?
5. Bagaimana rencana pemantauan atau tindak lanjut setelah klien menggunakan metode kontrasepsi yang dipilih?

## Soal OSCE Kebidanan

| No. | Komponen                               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | No. Stasiun                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Judul                                  | Kontrasepsi pada Kondisi Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | Kasus                                  | Seorang klien datang untuk berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Tujuan                                 | Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam mengambil keputusan                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5   | Kompetensi                             | 1. Anamnesis<br>2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana<br>3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah<br>4. Prosedur tindakan klinis<br>5. KIE/konseling<br>6. Kolaborasi/rujukan<br>7. Perilaku profesional                                                                                                                                                            |
| 6   | Soal: Skenario dan tugas peserta ujian | SKENARIO KLINIK<br>Ny. A berusia 19 tahun, baru menikah selama 4 bulan dan ingin menunda kehamilan karena masih melanjutkan pendidikan. Klien belum pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya dan merasa takut menggunakan kontrasepsi hormonal karena mendengar bahwa kontrasepsi dapat menyebabkan kemandulan.<br><br>TUGAS<br>1. Melakukan komunikasi terapeutik dengan klien. |

| No. | Komponen          | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menggali informasi mengenai kondisi kesehatan, riwayat obstetri, dan riwayat penggunaan kontrasepsi.</li> <li>3. Melakukan skrining kelayakan penggunaan metode kontrasepsi sesuai kondisi klien.</li> <li>4. Menjelaskan beberapa pilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi klien.</li> <li>5. Memberikan penjelasan mengenai manfaat, cara kerja, dan kemungkinan efek samping dari metode kontrasepsi yang disarankan.</li> <li>6. Membantu klien menentukan pilihan metode kontrasepsi berdasarkan prinsip informed choice.</li> <li>7. Menjelaskan rencana tindak lanjut setelah penggunaan kontrasepsi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   | Instruksi penguji | <p><b>INSTRUKSI UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguji bertugas menilai keterampilan peserta ujian berdasarkan lembar checklist penilaian yang telah disediakan.</li> <li>2. Waktu pelaksanaan stasiun adalah 7–10 menit untuk setiap peserta.</li> <li>3. Penguji tidak diperkenankan memberikan bantuan, petunjuk, atau koreksi kepada peserta selama ujian berlangsung.</li> <li>4. Penguji hanya melakukan observasi terhadap komunikasi, proses konseling, dan pengambilan keputusan klinis peserta.</li> <li>5. Penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kriteria pada checklist.</li> <li>6. Apabila waktu telah habis, penguji memberi tanda bahwa peserta harus mengakhiri tindakan konseling.</li> <li>7. Penguji menjaga suasana ujian tetap kondusif dan memastikan peserta memahami instruksi sebelum stasiun dimulai.</li> </ol> <p><b>INSTRUKSI KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan pasien standar (standardized patient) telah memahami skenario kasus yang akan diperankan.</li> <li>2. Perhatikan apakah peserta melakukan langkah-langkah konseling KB yang sistematis, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ komunikasi terapeutik (menyapa, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan konseling),</li> <li>➤ pengkajian kondisi klien (riwayat kesehatan, riwayat obstetri, penggunaan kontrasepsi sebelumnya),</li> <li>➤ skrining kelayakan metode kontrasepsi,</li> <li>➤ pemberian informasi metode kontrasepsi yang sesuai,</li> <li>➤ penerapan prinsip informed choice,</li> <li>➤ penjelasan rencana tindak lanjut.</li> </ul> </li> </ol> |

| No. | Komponen                   | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Nilai kemampuan peserta dalam menjelaskan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi khusus klien, seperti pada remaja, perimenopause, atau klien dengan penyakit kronis.</li> <li>4. Perhatikan kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan atau kekhawatiran klien secara jelas dan empatik.</li> <li>5. Pastikan peserta menutup sesi konseling dengan baik serta memberikan informasi kontrol atau tindak lanjut.</li> </ol> <p>INSTRUKSI TAMBAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika peserta tidak menanyakan informasi tertentu, pasien standar tidak perlu memberikan informasi tersebut secara spontan.</li> <li>2. Jika peserta bertanya sesuai skenario, pasien standar memberikan jawaban sesuai data kasus yang telah ditentukan.</li> <li>3. Apabila peserta memberikan informasi yang tidak tepat mengenai metode kontrasepsi, penguji tetap mencatat pada lembar penilaian tanpa melakukan koreksi langsung.</li> <li>4. Penguji dapat memberikan catatan singkat pada kolom komentar untuk evaluasi peserta setelah ujian selesai.</li> <li>5. Setelah waktu berakhir, penguji memastikan peserta meninggalkan stasiun sebelum peserta berikutnya masuk.</li> </ol> |
| 8   | Kebutuhan dan instruksi PS | <p>Instruksi PS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang klien datang untuk berkonsultasi mengenai pemilihan metode kontrasepsi pada kondisi khusus.</li> <li>2. Membangun komunikasi terapeutik</li> <li>3. Mengidentifikasi kondisi khusus (remaja/perimenopause/penyakit kronis/risiko tinggi)</li> <li>4. Memberikan informasi (informed choice)</li> <li>5. Menentukan metode yang aman</li> <li>6. Membantu klien mengambil keputusan</li> <li>7. Menyusun rencana tindak lanjut</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9   | Dialog PS                  | <p><b>Bidan</b> : "Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan saya bidan Nur apa yang bisa saya bantu hari ini?"</p> <p><b>PS</b>: "Pagi, Bu. Saya mau konsultasi tentang KB. Saya masih bingung mau pakai yang apa."</p> <p><b>Bidan</b>: "Baik, Bu. Sebelumnya boleh saya tahu apakah Ibu sudah punya anak?"</p> <p><b>PS</b>: "Saya sudah punya dua anak, Bu. Yang terakhir umur 2 tahun."</p> <p><b>Bidan</b>: "Apakah Ibu masih ingin menambah anak?"</p> <p><b>PS</b>: "Sepertinya tidak dulu, Bu. Mau ditunda saja."</p> <p><b>Bidan</b> : "Apakah Ibu punya riwayat penyakit tertentu?"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | Komponen       | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | <p><b>PS:</b> "Iya, saya punya darah tinggi, tapi kata dokter masih ringan dan saya minum obat, "Soalnya saya juga ada darah tinggi, Bu... itu pengaruh nggak ya ke KB?"</p> <p><b>Bidan :</b> "Ibu lebih tertarik KB jangka pendek atau jangka panjang?"</p> <p><b>PS:</b> "Saya maunya yang praktis saja, tidak ribet."<br/> " Oh iya Bu, saya pernah dengar pil KB... itu aman ya buat saya?"<br/> Tapi klo IUD/implant itu sakit nggak ya pas pasanganya bu ?"<br/> " Trus kalau saya darah tinggi, tidak semua KB boleh ya, Bu?"</p> <p><b>Bidan :</b> "Baik, Ibu. Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk kondisi Ibu yang memiliki riwayat hipertensi, memang tidak semua metode kontrasepsi cocok digunakan, terutama yang mengandung hormon estrogen seperti pil KB kombinasi, karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah dan gangguan pembuluh darah."<br/> "Untuk metode seperti IUD dan implant, proses pemasangannya memang bisa menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman, tetapi biasanya hanya sebentar dan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan prosedur yang aman."</p> <p><b>PS :</b> "Kalau saya minum pil KB, aman ya walaupun saya darah tinggi?"</p> <p><b>Bidan :</b> "Untuk Ibu dengan riwayat hipertensi, pil KB kombinasi sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko komplikasi. Namun, masih ada pilihan lain yang lebih aman seperti IUD, implant, atau metode non hormonal seperti kondom."</p> <p><b>PS:</b> "Kalau begitu saya pilih yang aman saja, Bu. Mungkin yang tidak pakai hormon estrogen."</p> <p><b>Bidan :</b> "Baik Bu. Itu pilihan yang tepat. Nanti saya akan membantu menjelaskan lebih lanjut tentang metode yang sesuai, serta kita bisa menentukan pilihan terbaik bersama. Setelah itu, kita juga akan menjadwalkan pemasangan dan kontrol untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik."<br/> "Apakah ada yang masih ingin Ibu tanyakan?"</p> <p><b>PS:</b> "Iya, Bu. Terima kasih penjelasannya, jadi lebih paham."<br/> Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawaban singkat, tidak langsung lengkap</li> <li>• Berikan informasi hanya jika ditanya</li> <li>• Gunakan <i>cue</i> jika mahasiswa tidak menggali</li> <li>• Tunjukkan emosi ringan (bingung, khawatir)</li> <li>• Jangan mengarahkan jawaban ke arah benar</li> </ul> |
| 10  | Kebutuhan alat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar status klien / rekam medis</li> <li>2. Alat tulis</li> <li>3. Leaflet/alat bantu edukasi kontrasepsi</li> <li>4. Alat peraga kontrasepsi (kondom, implant, IUD )</li> <li>5. Meja dan kursi konseling</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | Komponen  | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | 6. Ruang yang menjaga privasi klien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  | Referensi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. World Health Organization. (2019). <i>Family Planning: A Global Handbook for Providers</i>.</li> <li>2. World Health Organization. (2025). <i>Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (6th ed.)</i>.</li> <li>3. World Health Organization. (2016). <i>Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use</i>.</li> <li>4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). <i>Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana</i>.</li> <li>5. BKKBN. (2021). <i>Panduan Pelayanan Kontrasepsi</i>.</li> <li>6. Centers for Disease Control and Prevention. (2024). <i>U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use</i>.</li> </ol> |

## RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1:

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

| Komponen yang dinilai                                                                                     | Skoring | Skor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1. Memberi salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan konseling                                   |         |      |
| 2. Menunjukkan sikap empati, sopan, dan komunikasi terapeutik                                             |         |      |
| 3. Menggali keluhan utama klien                                                                           |         |      |
| 4. Menggali riwayat reproduksi (jumlah anak, rencana kehamilan)                                           |         |      |
| 5. Menggali riwayat kesehatan/penyakit (hipertensi, DM, dll)                                              |         |      |
| 6. Menjelaskan pilihan metode kontrasepsi dan cara kerja metode kontrasepsi                               |         |      |
| 7. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode dan efek samping metode                                    |         |      |
| 8. Melakukan skrining kelayakan berdasarkan kondisi medis                                                 |         |      |
| 9. Memberikan kesempatan klien bertanya                                                                   |         |      |
| 10. Membantu klien memilih metode kontrasepsi yang sesuai dan Menjelaskan cara penggunaan metode terpilih |         |      |
| 11. Menentukan jadwal kontrol/tindak lanjut dan Menyimpulkan hasil konseling                              |         |      |

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 11 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 11 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 11 langkah dengan benar.

- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

## KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

| Komponen yang dinilai                                                                                                                                                                                     | Skoring | Skor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>1. Persiapan</b>                                                                                                                                                                                       |         |      |
| a. Menyambut pasien dengan sopan dan ramah                                                                                                                                                                |         |      |
| b. Menjaga privasi klien                                                                                                                                                                                  |         |      |
| c. mempersilahkan klien duduk                                                                                                                                                                             |         |      |
| d. memperkenalkan diri pada klien                                                                                                                                                                         |         |      |
| e. menunjukkan rasa empati pada klien                                                                                                                                                                     |         |      |
| <b>2. Langkah-langkah</b>                                                                                                                                                                                 |         |      |
| a. menanyakan kepada klien apa yang perlu dibantu                                                                                                                                                         |         |      |
| b. menjelaskan pelayanan apa yang dapat diperolehnya                                                                                                                                                      |         |      |
| c. menyakan pada klien informasi tentang dirinya, bantu klien untuk berbicara mengenai pengalaman KB dan Kesehatan reproduksi, tujuan,kepentingan, harapan serta keadaan Kesehatan dan kehidupan keluarga |         |      |
| d. menanyakan kontrasepsi yang diinginkan klien                                                                                                                                                           |         |      |
| e. menguraikan kepada klien mengenai pilihannya dan memberitahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi                                                   |         |      |
| f. membantu klien menentukan pilihannya dengan mendorong klien untuk menunjukkan keinginannya dengan mengajukan pertanyaan                                                                                |         |      |
| g. menjelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya (jika diperlukan perlihatkan alat/obat kontrasepsi)                                                                            |         |      |
| h. melakukan kunjungan ulang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau permintaan kontrasepsi jika dibutuhkan                                                                                             |         |      |
| <b>3. Teknik</b>                                                                                                                                                                                          |         |      |
| a. Melaksanakan konseling secara sistematis                                                                                                                                                               |         |      |
| b. Menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti                                                                                                                                                               |         |      |
| c. percaya diri dan tanggap terhadap reaksi klien                                                                                                                                                         |         |      |
| d.menggunakan media secara efektif                                                                                                                                                                        |         |      |
| e.mendokumentasi hasil konseling yang telah dilakukan                                                                                                                                                     |         |      |

### Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Jika peserta ujian melakukan 15–18 langkah dengan tepat dan sistematis.
- 2= Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- 1= Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.

- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat

### KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

| Komponen yang dinilai                                             | Skoring | Skor |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1. Sapa dan salam                                                 |         |      |
| 2. Menjelaskan kondisi klien terkait pemilihan kontrasepsi        |         |      |
| 3. Melibatkan klien dalam pengambilan keputusan (informed choice) |         |      |
| 4. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab dengan jelas          |         |      |
| 5. Menjelaskan rencana tindak lanjut                              |         |      |

#### Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

### KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

| Komponen yang dinilai                                  | Skoring | Skor |
|--------------------------------------------------------|---------|------|
| 1. Melaksanakan secara sistematis                      |         |      |
| 2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien              |         |      |
| 3. Memberikan perhatian terhadap pemilihan kontrasepsi |         |      |
| 4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif        |         |      |
| 5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu                    |         |      |

#### Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

### TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

#### IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

| TIDAK LULUS | BORDERLINE | LULUS | SUPERIOR |
|-------------|------------|-------|----------|
|             |            |       |          |

Jumlah total skore

Nilai akhir =  $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

Jakarta, .....

.....  
Penguji:.....

### **Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)**

DOPS adalah penilaian ketrampilan procedural klinik (tindakan medik) mahasiswa saat berhadapan dengan pasien. DOPS mudah dilakukan secara rutin oleh supervisor yang bertugas dalam berbagai situasi poliklinik/ruangan dan hanya memerlukan 15 – 20 menit untuk dapat menilai interaksi mahasiswa dengan pasien, kemudian diikuti dengan umpan balik 5-10 menit. Dari berbagai penelitian, telah membuktikan bahwa DOPS merupakan alat yang valid dan dapat dipercaya untuk mengukur ketrampilan prosedural klinik mahasiswa.

#### **SETTING RUANGAN DOPS**

Pasien Rawat Inap (Bangsal)

Rawat Jalan

IGD, BPM

Lain-lain: Ruang Operasi

#### **PENILAI DOPS**

Supervisor klinik

Lembar penilaian (Formulir) DOPS rangkap 3, bila sudah selesai melakukan DOPS, serahkan aslinya kepada koordinator blok 1 untuk arsip CI dan 1 untuk mahasiswa. Rentang nilai adalah 1-9 dengan kategori:

1-3 jauh dibawah kompetensi yang diharapkan

4-5 mendekati kompetensi yang diharapkan

6-7 sesuai dengan kompetensi yang diharapkan

8-9 melampaui kompetensi yang diharapkan

#### **Kompetensi yang Ada Dalam DOPS**

1. Memahami indikasi dan kontraindikasi, anatomi, tehnik prosedur tindakan medik.
2. Mendapatkan informed consent
3. Memperagakan persiapan yang tepat sebelum melaksanakan tindakan medik
4. Teknik aseptik dan antiseptik
5. Kemampuan tehnik (Technical ability)
6. Memberikan asuhan atau terapi sesuai kebutuhan
7. Meminta bantuan kepada orang yang tepat (Seek help where appropriate)
8. Pengelolaan pasca tindakan medis
9. Kemampuan berkomunikasi
10. Kualitas humanistic/profesionalisme (humanistic quality/ pfessionalism)

## 11. Kompetensi klinik keseluruhan (Overall Clinical Competence)

**FORMULIR DIRECT OBSERVATION OF PROCEDURAL SKILLS (DOPS)**

**LEMBAR PENILAIAN FORMATIF KOMPETENSI KLINIK**

Penilai :  
 Tanggal :  
 Nama Mahasiswa :  
 NIM :  
 Evaluasi ke : ☐E1 ☐E2  
 Situasi Ruangan : ☐RawatJalan ☐IGD ☐RawatInap ☐Lain-lain  
 Problem Pasien :  
 Pasien : Umur:    Jenis Kelamin: ☐L ☐P ☐Baru  
☐Follow Up  
 Tingkat Kerumitan kasus : ☐Rendah ☐Sedang ☐Tinggi  
 Fokus pertemuan klinik : ☐Pengumpulan data ☐Anamnesa ☐Pemeriksaan fisik ☐Diagnosis ☐Managemen pasien ☐Konseling  
 Harap dinilai area kompetensi dibawah ini menggunakan angka 1– 9

| KOMPONEN KOMPETENSI                                                  | NILAI | KETERANGAN                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 1. Kemampuan membuat catatan medis                                   |       | 1-2 jauh di bawah kompetensi yang diharapkan |
| 2. Clinical Assessment                                               |       | 4-5 mendekati kompetensi yang diharapkan     |
| 3. Investigasi dan rujukan                                           |       | 6-7 sesuai dengan kompetensi yang diharapkan |
| 4. Terapi                                                            |       | 8-9 melampaui kompetensi yang diharapkan     |
| 5. Follow-up dan rencana pengelolaan selanjutnya                     |       |                                              |
| 6. Professionalisme                                                  |       |                                              |
| 7. Penilaian klinik secara keseluruhan (overall clinical judgetment) |       |                                              |

Nilai rata-rata = jumlah nilai : jumlah item yang diujikan

### UMPAN BALIK TERHADAP PERFORMANCE MAHASISWA

| Aspek Yang Sudah Bagus     | Aspek yang Perlu |
|----------------------------|------------------|
|                            |                  |
| Action plan yang disetujui |                  |

### Portofolio Kontrasepsi pada Kondisi Khusus

1. Nama :
2. NIM :
3. Program Studi :
4. Stase :
5. Institusi :
6. Pembimbing :

Contoh:

Seorang wanita usia 35 tahun dengan riwayat hipertensi datang untuk memilih metode kontrasepsi. Klien memiliki 2 anak dan ingin menunda kehamilan.

#### Pengkajian (Assessment)

1. Data Subjektif:
  - a. Keluhan utama
  - b. Riwayat reproduksi
  - c. Riwayat kesehatan
  - d. Preferensi klien
2. Data Objektif:
  - a. Hasil pemeriksaan (jika ada)
  - b. Kondisi umum klien
3. Identifikasi Masalah:
 

Kondisi khusus (remaja/perimenopause/penyakit kronis/risiko tinggi)

#### Analisis dan Diagnosis

1. Analisis kebutuhan kontrasepsi klien
2. Risiko yang mungkin terjadi
3. Kelayakan penggunaan metode kontrasepsi

### Perencanaan (*Planning*)

1. Rencana konseling KB
2. Pilihan metode kontrasepsi yang akan diberikan
3. Alternatif metode

### Implementasi

Jelaskan langkah yang telah dilakukan:

1. Komunikasi terapeutik
2. Penggalan kebutuhan klien
3. Pemberian informasi (informed choice)
4. Skrining kelayakan
5. Penentuan metode kontrasepsi

### Evaluasi

1. Respons klien terhadap konseling
2. Metode yang dipilih klien
3. Apakah tujuan tercapai

### Rencana Tindak Lanjut

1. Jadwal kontrol
2. Edukasi lanjutan
3. Monitoring efek samping

### Refleksi Diri Mahasiswa

Tuliskan pengalaman Anda selama melakukan konseling:

1. Hal yang sudah baik
2. Hal yang perlu diperbaiki
3. Pembelajaran yang didapat

### Bukti Kegiatan (Evidence)

Lampirkan:

1. Lembar konseling
2. Foto kegiatan (jika ada)
3. Logbook
4. Checklist/DOPS

## B. Ringkasan Materi

Pelayanan kontrasepsi pada kondisi khusus memerlukan perhatian terhadap *red flags*, yaitu tanda atau kondisi berisiko tinggi yang dapat mempengaruhi keamanan penggunaan metode kontrasepsi, sehingga identifikasinya sangat penting untuk mencegah komplikasi dan menjamin keselamatan klien (*patient safety*). Red flags yang sering ditemukan dalam praktik kebidanan meliputi aspek kardiovaskular seperti hipertensi berat ( $\geq 160/100$  mmHg), riwayat tromboemboli, dan perokok usia  $>35$  tahun; aspek neurologis seperti migrain dengan aura dan sakit kepala berat mendadak; aspek metabolik seperti diabetes dengan komplikasi; aspek reproduksi seperti perdarahan uterus yang tidak jelas penyebabnya, kecurigaan kehamilan, serta nyeri hebat pasca pemasangan IUD; aspek infeksi seperti infeksi menular seksual aktif dan demam tinggi pasca tindakan; serta aspek hematologi seperti anemia berat. Dalam menghadapi kondisi tersebut, tenaga kesehatan harus mampu melakukan identifikasi dini melalui anamnesis dan skrining, menghindari metode kontrasepsi yang berisiko (misalnya estrogen pada hipertensi berat), memberikan alternatif metode yang lebih aman, melakukan edukasi kepada klien, serta melakukan eskalasi atau rujukan bila diperlukan. Prinsip eskalasi dilakukan apabila terdapat kontraindikasi absolut, kondisi klien memerlukan evaluasi lanjutan, terjadi komplikasi pasca tindakan, atau dibutuhkan penanganan oleh dokter/spesialis. Dengan demikian, penatalaksanaan red flags bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien, mencegah komplikasi kontrasepsi, mendukung pengambilan keputusan berbasis kondisi klinis, serta menerapkan pelayanan yang berpusat pada klien (*client-centered care*).

## C. Alur Asuhan Singkat

Pengkajian Awal → Identifikasi Red Flags → Analisis Kelayakan → Konseling (Informed Choice) → keputusan tindakan → Eskalasi / Rujukan (jika perlu) → tindak lanjut

#### D. Tabel Red Flags & Eskalasi

Kontrasepsi pada Kondisi Khusus

| No | Kondisi / Red Flags                               | Risiko                                   | Tindakan Awal                                         | Eskalasi / Rujukan                        |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Tekanan darah $\geq$ 160/100 mmHg                 | Risiko stroke/komplikasi kardiovaskular  | Tunda kontrasepsi hormonal kombinasi, ukur ulang TD   | Rujuk ke dokter untuk evaluasi hipertensi |
| 2  | Riwayat tromboemboli (DVT/PE)                     | Risiko kekambuhan                        | Hindari estrogen, pilih metode non-hormonal/progestin | Konsultasi spesialis penyakit dalam       |
| 3  | Perdarahan uterus tidak jelas penyebabnya         | Risiko penyakit serius (misal keganasan) | Tunda pemasangan IUD/hormonal                         | Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan          |
| 4  | Kecurigaan atau konfirmasi kehamilan              | Kontraindikasi sebagian metode           | Lakukan tes kehamilan                                 | Konseling kehamilan / rujukan ANC         |
| 5  | Nyeri dada/sesak napas mendadak                   | Kemungkinan emboli paru                  | Hentikan penggunaan hormonal                          | Rujuk segera (emergency)                  |
| 6  | Sakit kepala berat/migrain dengan aura            | Risiko stroke                            | Hindari kontrasepsi kombinasi                         | Rujuk evaluasi neurologis                 |
| 7  | Diabetes dengan komplikasi (nefropati/retinopati) | Risiko vaskular tinggi                   | Hindari estrogen, pilih metode aman                   | Rujuk spesialis                           |
| 8  | Infeksi menular seksual aktif                     | Risiko komplikasi pemasangan IUD         | Tunda pemasangan IUD                                  | Obati IMS terlebih dahulu                 |
| 9  | Anemia berat                                      | Risiko perburukan kondisi                | Evaluasi sebelum memilih metode                       | Rujuk untuk penanganan anemia             |
| 10 | Perokok usia > 35 tahun                           | Risiko kardiovaskular                    | Hindari kontrasepsi kombinasi                         | Konseling dan rujuk jika perlu            |
| 11 | Nyeri perut hebat pasca pemasangan IUD            | Risiko perforasi/infeksi                 | Evaluasi posisi IUD                                   | Rujuk segera                              |
| 12 | Demam tinggi pasca tindakan                       | Risiko infeksi                           | Berikan penanganan awal                               | Rujuk jika tidak membaik                  |

## E. Referensi

- A Clinical Guide for Contraception – Speroff, L., & Darney, P. D. (2019). *A clinical guide for contraception* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Berek & Novak's Gynecology – Berek, J. S. (2020). *Berek & Novak's gynecology* (16th ed.). Wolters Kluwer.
- BKKBN. (2021). *Panduan pelayanan kontrasepsi*. BKKBN.
- Black, K. I., & Fraser, I. S. (2018). Contraception for women with medical conditions. *Medical Journal of Australia*, 208(5), 230–235.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use*. CDC.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *U.S. selected practice recommendations for contraceptive use*. CDC.
- Contraceptive Technology – Hatcher, R. A., Nelson, A. L., Trussell, J., et al. (2018). *Contraceptive technology* (21st ed.). Ayer Company Publishers.
- Curtis, K. M., Tepper, N. K., Jatlaoui, T. C., et al. (2016). U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use. *MMWR Recommendations and Reports*, 65(3), 1–103.
- Hall, K. S., et al. (2020). Contraceptive counseling and reproductive health outcomes. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 222(4), 1–9.
- International Federation of Gynecology and Obstetrics. (2021). *Contraception and family planning guidelines*. FIGO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan keluarga berencana*. Kemenkes RI.
- Senderowicz, L. (2020). Contraceptive autonomy and informed choice. *Studies in Family Planning*, 51(2), 161–176.
- Williams Obstetrics – Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill.
- World Health Organization. (2016). *Selected practice recommendations for contraceptive use* (3rd ed.). WHO.
- World Health Organization. (2019). *Family planning: A global handbook for providers* (3rd ed.). WHO.
- World Health Organization. (2021). *Quality of care in family planning services*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *Counseling for maternal and newborn health care: A handbook for building skills*. WHO.
- World Health Organization. (2025). *Medical eligibility criteria for contraceptive use* (6th ed.). WHO.

# BAB 5

## PENCEGAHAN IMS/HIV DALAM PELAYANAN KB: SKRINING RISIKO, EDUKASI, DAN RUJUKAN

### Capaian Pembelajaran Lulusan

| Kode CPL | Rumusan CPL                                                                                                                            | CPMK yang berkontribusi        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CPL-1    | Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan regulasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.                | CPMK-1, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-7 |
| CPL-2    | Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi berpusat pada klien/keluarga untuk mendukung pengambilan keputusan kontrasepsi.        | CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5         |
| CPL-3    | Menerapkan prinsip keselamatan, pencegahan infeksi, serta perlindungan privasi dan kerahasiaan dalam layanan KB/kespro.                | CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7 |
| CPL-4    | Menganalisis data klinis dan konteks klien untuk pengambilan keputusan berbasis bukti terkait pemilihan dan tindak lanjut kontrasepsi. | CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-6 |
| CPL-5    | Melaksanakan layanan KB dan tindak lanjut secara aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan klien (metode, edukasi, pemantauan).  | CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6         |
| CPL-6    | Mengelola layanan KB/kespro melalui pencatatan-pelaporan, logistik, rujukan, evaluasi mutu, dan perbaikan berkelanjutan.               | CPMK-7, CPMK-1                 |

**Tabel CPMK**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPMK-1    | Menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika–legal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan. |
| CPMK-2    | Menganalisis anatomi–fisiologi sistem reproduksi dan regulasi fertilitas sebagai dasar pemilihan metode kontrasepsi.         |
| CPMK-3    | Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien.                |
| CPMK-4    | Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut. |
| CPMK-5    | Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang tepat dan menyusun edukasi penggunaan sesuai kelayakan, kondisi, dan bukti.       |
| CPMK-6    | Menangani efek samping/komplikasi KB, menetapkan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara aman.              |
| CPMK-7    | Mengelola pelayanan KB/kespro (IMS/HIV, logistik, pencatatan-pelaporan, mutu, keselamatan, evaluasi kepuasan) berbasis data. |

## Uraian Materi

---

Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan reproduksi yang masih menjadi tantangan besar baik di tingkat global maupun nasional. IMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, maupun oral, dan dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Penyakit ini sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga banyak penderita tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi. Kondisi ini menyebabkan IMS mudah menyebar dan meningkatkan risiko komplikasi serius, terutama pada perempuan usia reproduksi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada kesehatan individu, tetapi juga pada kesehatan masyarakat secara luas, termasuk peningkatan angka infertilitas, kehamilan ektopik, kanker serviks, serta kematian akibat komplikasi infeksi yang tidak tertangani dengan baik.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, HIV memiliki dampak yang lebih kompleks karena menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi HIV yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem imun tubuh sangat lemah sehingga rentan terhadap infeksi oportunistik. Selain itu, HIV juga dapat ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, maupun menyusui, sehingga memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi berikutnya. Oleh karena itu, pencegahan IMS dan HIV menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan reproduksi masyarakat.

Integrasi pencegahan IMS/HIV dalam pelayanan keluarga berencana (KB) merupakan langkah strategis yang sangat penting. Pelayanan KB tidak hanya berfokus pada pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, tetapi juga menjadi pintu masuk utama untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Klien KB umumnya merupakan individu yang aktif secara seksual, sehingga memiliki risiko terhadap IMS dan HIV. Dengan mengintegrasikan layanan skrining, edukasi, dan rujukan dalam pelayanan KB, tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini serta memberikan intervensi yang tepat secara lebih efektif dan efisien.

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan IMS dan HIV. Bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan medis, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, dan advokat bagi klien. Dalam praktiknya, bidan harus mampu melakukan skrining risiko secara tepat, memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan klien, serta melakukan rujukan apabila diperlukan. Keberhasilan pelayanan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, empati, serta sikap profesional tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

## **A. Konsep Dasar IMS dan HIV**

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan kelompok penyakit infeksi yang ditularkan melalui aktivitas seksual dan dapat menyerang organ reproduksi maupun organ tubuh lainnya. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri (misalnya sifilis dan gonore), virus (seperti herpes dan HIV), serta parasit (seperti trikomoniasis). IMS sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas, terutama pada perempuan, sehingga banyak kasus yang tidak terdiagnosis dan tidak mendapatkan pengobatan yang memadai.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, sehingga menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Jika tidak ditangani, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), yaitu kondisi di mana sistem imun tubuh sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi oportunistik. HIV tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, termasuk stigma dan diskriminasi terhadap penderita.

Penularan IMS dan HIV dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain hubungan seksual tanpa pengaman, transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, termasuk perubahan perilaku dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan.

Dampak IMS dan HIV terhadap kesehatan reproduksi sangat signifikan. IMS yang tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi, infertilitas, kehamilan ektopik, serta meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks. Selain itu, IMS juga dapat meningkatkan risiko penularan HIV karena adanya luka atau peradangan pada organ reproduksi yang mempermudah masuknya virus ke dalam tubuh. Hubungan antara IMS dan HIV ini menunjukkan pentingnya penanganan IMS sebagai bagian dari strategi pencegahan HIV.

## **B. Konsep Pelayanan KB Terintegrasi dengan IMS/HIV**

Pelayanan KB komprehensif merupakan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada kontrasepsi, tetapi juga mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam kesehatan reproduksi. Dalam pendekatan ini, pelayanan KB diintegrasikan dengan berbagai layanan lain, termasuk pencegahan dan penanganan IMS/HIV. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Konsep integrasi layanan KB dengan IMS/HIV menekankan pada penyediaan layanan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini mencakup skrining risiko, edukasi, konseling, pemeriksaan, serta rujukan apabila diperlukan. Dengan adanya integrasi, klien dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu tempat, sehingga lebih efisien dan efektif.

Prinsip pelayanan berkesinambungan atau *continuum of care* merupakan pendekatan yang memastikan bahwa klien mendapatkan pelayanan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan sepanjang siklus hidupnya. Pendekatan ini mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis dini, pengobatan, hingga rehabilitasi.

Konsep *dual protection* juga menjadi bagian penting dalam pelayanan KB terintegrasi. *Dual protection* mengacu pada penggunaan metode yang dapat melindungi dari kehamilan sekaligus mencegah penularan IMS/HIV, seperti penggunaan kondom. Pendekatan ini sangat penting terutama bagi klien dengan risiko tinggi terhadap IMS/HIV.

### **C. Skrining Risiko IMS/HIV dalam Pelayanan KB**

Skrining risiko IMS/HIV merupakan proses identifikasi dini terhadap individu yang memiliki kemungkinan terinfeksi atau berisiko tinggi terhadap IMS/HIV. Skrining dilakukan sebagai bagian dari pelayanan KB untuk mendeteksi secara dini adanya faktor risiko sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat.

Tujuan utama skrining adalah untuk mendeteksi kasus secara dini, mencegah komplikasi, serta mengurangi penularan. Dalam pelaksanaannya, skrining harus dilakukan dengan prinsip kerahasiaan, tanpa diskriminasi, serta menghormati hak klien.

Komponen skrining meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis mencakup penggalan informasi terkait riwayat perilaku seksual, jumlah pasangan, penggunaan kondom, serta riwayat IMS sebelumnya. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk melihat tanda-tanda klinis seperti luka atau keputihan abnormal. Pemeriksaan penunjang meliputi tes laboratorium seperti tes HIV dan pemeriksaan IMS lainnya.

Berdasarkan hasil skrining, klien dapat dikategorikan ke dalam risiko rendah, sedang, atau tinggi. Tindak lanjut dari hasil skrining meliputi pemberian edukasi, konseling, serta rujukan jika diperlukan. Namun, pelaksanaan skrining sering menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya keterbukaan klien dalam memberikan informasi.

#### **D. Edukasi Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB**

Edukasi atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan proses penting dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku klien terkait pencegahan IMS/HIV. Edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, membantu pengambilan keputusan, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat.

Prinsip komunikasi efektif dalam edukasi meliputi penggunaan bahasa yang mudah dipahami, sikap empati, serta pendekatan yang tidak menghakimi. Materi edukasi mencakup seks aman, penggunaan kondom, pentingnya tes HIV, serta pencegahan penularan dari ibu ke anak.

Metode edukasi dapat dilakukan melalui konseling individu, kelompok, maupun menggunakan media seperti leaflet dan video. Edukasi juga harus disesuaikan dengan tingkat risiko klien agar lebih efektif.

Bidan memiliki peran penting sebagai edukator dalam memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, serta memotivasi klien untuk melakukan perubahan perilaku.

#### **E. Rujukan dalam Pelayanan KB terkait IMS/HIV**

Rujukan merupakan proses pengalihan pelayanan dari fasilitas kesehatan yang kurang mampu ke fasilitas yang lebih mampu. Tujuan rujukan adalah untuk memastikan klien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Rujukan dapat bersifat vertikal maupun horizontal, tergantung pada kebutuhan pelayanan. Indikasi rujukan meliputi hasil skrining positif, gejala berat, atau kebutuhan pemeriksaan lanjutan.

Alur rujukan meliputi identifikasi kasus, konseling, pencatatan, dan pengiriman klien ke fasilitas rujukan. Setelah rujukan dilakukan, tenaga kesehatan tetap harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan pelayanan.

#### **F. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan IMS/HIV**

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan IMS/HIV, mulai dari skrining, edukasi, konseling, hingga rujukan. Dalam menjalankan perannya, tenaga kesehatan harus menjunjung tinggi etika pelayanan, termasuk menjaga privasi dan kerahasiaan klien serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

## **G. Integrasi Pelayanan KB dengan Program HIV/IMS Nasional**

Integrasi pelayanan KB dengan program HIV/IMS nasional merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Program ini mencakup layanan komprehensif berkesinambungan yang meliputi edukasi, skrining, pengobatan, dan rujukan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, stigma, dan akses layanan yang belum merata.

## **H. Evidence Based Midwifery (EBM)**

Evidence Based Midwifery (EBM) merupakan pendekatan dalam praktik kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik. Dalam konteks pencegahan IMS/HIV, EBM menunjukkan bahwa skrining, edukasi, dan penggunaan kondom merupakan intervensi yang efektif dalam menurunkan angka penularan.

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku, sementara penggunaan kondom secara konsisten terbukti efektif dalam mencegah IMS dan HIV.

## **I. Aktivitas 1 — *Knows How***

*Mini-case* tertulis (diskusi kelompok)

Contoh 1

Seorang perempuan usia 28 tahun, datang ke klinik pukul 09.00 untuk konsultasi kontrasepsi. Ia telah memiliki satu anak dan ingin menggunakan metode KB jangka panjang. Saat anamnesis, diketahui bahwa suaminya sering bekerja di luar kota dan jarang menggunakan kondom.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama dan potensi risiko kesehatan reproduksi pada kasus di atas?
2. Faktor risiko IMS/HIV apa saja yang dapat diidentifikasi dari hasil anamnesis tersebut?
3. Data tambahan apa yang perlu digali lebih lanjut untuk memperkuat skrining risiko IMS/HIV?
4. Bagaimana langkah skrining risiko IMS/HIV yang harus dilakukan oleh bidan pada kasus ini?
5. Apakah klien memerlukan pemeriksaan atau tes lanjutan terkait IMS/HIV? Jelaskan alasan Anda.
6. Metode kontrasepsi apa yang paling tepat untuk klien ini, dengan mempertimbangkan aspek pencegahan IMS/HIV?
7. Edukasi apa saja yang harus diberikan kepada klien terkait pencegahan IMS/HIV?

8. Bagaimana cara menyampaikan edukasi yang efektif dan empatik pada klien dengan situasi seperti ini?
9. Apakah kasus ini memerlukan rujukan? Jika ya, ke mana dan dalam kondisi apa rujukan dilakukan?
10. Apa saja prinsip etika dan keselamatan pasien yang harus diperhatikan dalam kasus ini?
11. Bagaimana peran bidan dalam memastikan keberlanjutan pelayanan (follow-up) pada klien ini?

## Contoh 2

Seorang perempuan usia 22 tahun datang ke klinik untuk meminta suntik KB. Ia belum menikah dan memiliki pacar. Dari anamnesis awal, ia mengaku pernah berganti pasangan sebelumnya dan tidak selalu menggunakan kondom. Saat ini ia tidak mengeluh gejala apapun.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa pendekatan terbaik saat menghadapi pasien yang belum menikah tetapi aktif secara seksual?
2. Mengapa IMS bisa tidak bergejala namun tetap berbahaya?
3. Apa perbedaan antara proteksi KB dan proteksi IMS?
4. Apa etika dalam menjaga kerahasiaan pasien dalam kasus ini?
5. Bagaimana cara mengatasi stigma terkait pemeriksaan HIV di masyarakat?

## J. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/Skill Lab Pelayanan KB dalam Pencegahan IMS/HIV

Fokus: Urutan Tindakan + Komunikasi + Keselamatan

Aktivitas pembelajaran pada tahap *Shows How* bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mendemonstrasikan keterampilan klinis secara langsung, khususnya dalam konteks pencegahan IMS/HIV pada pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Simulasi dilakukan dalam bentuk *skill lab* yang menekankan tiga aspek utama, yaitu:

1. Ketepatan urutan tindakan (*clinical sequence*)
2. Kemampuan komunikasi terapeutik
3. Penerapan prinsip keselamatan pasien (*patient safety*)

Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan teoritis ke dalam praktik klinis melalui pendekatan yang sistematis, aman, dan berbasis *evidence*.

### Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu:

1. Melakukan skrining risiko IMS/HIV dalam pelayanan KB secara sistematis
2. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi dengan komunikasi efektif
3. Mengidentifikasi indikasi rujukan secara tepat
4. Menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam setiap tindakan

### Alur Simulasi (Skill Lab)

1. Tahap Persiapan
  - a. Melakukan hand hygiene
  - b. Menyiapkan alat dan lingkungan
  - c. Memastikan privasi klien
2. Tahap Orientasi
  - a. Memberikan salam terapeutik
  - b. Memperkenalkan diri
  - c. Verifikasi identitas klien
  - d. Menjelaskan tujuan tindakan
3. Tahap Kerja
  - a. Melakukan skrining risiko IMS/HIV (anamnesis terarah)
  - b. Mengidentifikasi faktor risiko
  - c. Memberikan edukasi (kondom, perilaku seksual aman, tes HIV)
  - d. Menentukan kebutuhan rujukan
  - e. Mendokumentasikan hasil
4. Tahap Terminasi
  - a. Menyimpulkan hasil
  - b. Memberikan kesempatan bertanya
  - c. Memberikan reinforcement positif

### Fokus Penilaian dalam Skill Lab

1. Urutan Tindakan
  - a. Sistematis dan tidak terlewat
  - b. Sesuai standar pelayanan KB
2. Komunikasi
  - a. Empatik dan tidak menghakimi
  - b. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
  - c. Menjaga kerahasiaan klien

3. Keselamatan
  - a. Hand hygiene
  - b. Privasi dan kenyamanan
  - c. Pencegahan infeksi

#### Asesmen (Piramida Miller)

| Level Miller      | Metode                          |
|-------------------|---------------------------------|
| Knows / Knows How | Self-check + Analisis Mini-Case |
| Shows How         | OSCE Pelayanan KB (IMS/HIV)     |

#### Penjelasan Asesmen

1. Knows / Knows How
  - a. Mahasiswa memahami konsep IMS/HIV
  - b. Mampu menganalisis kasus sederhana
  - c. Dilakukan melalui:
    - 1) Soal refleksi
    - 2) Mini-case klinis
2. Shows How
  - a. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan
  - b. Dilakukan melalui:
    - 1) OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
    - 2) Fokus pada skrining, edukasi, dan rujukan

### TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

| No. | Komponen                               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | No. Stasiun                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Judul                                  | Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3   | Kasus                                  | Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke klinik untuk konsultasi kontrasepsi. Ia telah memiliki satu anak dan ingin menggunakan metode KB jangka panjang.<br>Saat anamnesis awal, klien menyampaikan bahwa suaminya sering bekerja di luar kota dan mereka jarang menggunakan kondom dalam hubungan seksual. Klien tampak sehat dan tidak mengeluhkan gejala khusus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | Tujuan                                 | Menilai kemampuan peserta dalam melakukan skrining risiko IMS/HIV, memberikan edukasi pencegahan, serta menentukan kebutuhan rujukan dalam pelayanan KB:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | Kompetensi                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anamnesis</li> <li>2. Pemeriksaan/skrining sederhana</li> <li>3. Perumusan masalah</li> <li>4. Tindakan klinis (skrining risiko)</li> <li>5. KIE/konseling</li> <li>6. Kolaborasi/rujukan</li> <li>7. Perilaku profesional</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   | Soal: Skenario dan tugas peserta ujian | <p><b>SKENARIO KLINIK</b><br/>Anda adalah seorang bidan di klinik KB. Seorang perempuan usia 28 tahun datang untuk konsultasi pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang. Dari hasil anamnesis awal diketahui adanya faktor risiko terkait IMS/HIV.</p> <p><b>TUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan anamnesis terarah untuk mengidentifikasi risiko IMS/HIV.</li> <li>2. Identifikasi masalah atau faktor risiko yang ditemukan.</li> <li>3. Jelaskan kepada klien mengenai risiko IMS/HIV secara sederhana.</li> <li>4. Berikan edukasi pencegahan IMS/HIV yang sesuai dengan kondisi klien.</li> <li>5. Tentukan pilihan kontrasepsi yang tepat disertai alasan.</li> <li>6. Jelaskan kebutuhan penggunaan <i>dual protection</i>.</li> <li>7. Tentukan apakah diperlukan rujukan dan jelaskan alasannya.</li> </ol> |
| 7   | Instruksi penguji                      | <p><b>INSTRUKSI UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amati peserta tanpa intervensi</li> <li>2. Gunakan checklist penilaian</li> <li>3. Berikan data tambahan jika peserta meminta</li> </ol> <p><b>INSTRUKSI KHUSUS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | Komponen                   | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | <p>1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, berikan informasi tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klien tidak memiliki keluhan keputihan abnormal</li> <li>• Tidak ada riwayat IMS yang diketahui</li> <li>• Klien belum pernah tes HIV</li> </ul> <p>Tindakan yang diharapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining risiko IMS/HIV</li> <li>• Edukasi penggunaan kondom</li> <li>• Menjelaskan dual protection</li> <li>• Menawarkan tes HIV</li> <li>• Menentukan metode KB yang sesuai</li> <li>• Menentukan kebutuhan rujukan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   | Kebutuhan dan instruksi PS | <p>Instruksi PS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tampak tenang, kooperatif</li> <li>7. Menjawab pertanyaan sesuai skenario</li> <li>8. Jika diberikan edukasi, merespons dengan baik</li> <li>9. Jika disarankan tes HIV, tampak ragu namun bersedia jika dijelaskan dengan baik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9   | Dialog PS                  | <p>Peserta: Selamat pagi, Bu.<br/> PS: Pagi, Bu.<br/> Peserta: Ada yang bisa saya bantu?<br/> PS: Saya mau konsultasi KB, Bu.<br/> Peserta: Apa tujuan ibu datang hari ini?<br/> PS: Saya ingin pakai KB yang jangka panjang, Bu.<br/> Riwayat Reproduksi<br/> Peserta: Sudah punya anak berapa, Bu?<br/> PS: Baru satu, Bu.<br/> Peserta: Sebelumnya pakai KB apa?<br/> PS: Pernah suntik, tapi sekarang mau yang lebih lama.<br/> Peserta: Apakah ibu menggunakan kondom?<br/> PS: Jarang, Bu.<br/> Peserta: Bagaimana dengan suami, apakah sering di rumah?<br/> PS: Suami saya sering kerja di luar kota, Bu.<br/> Peserta: Apakah ibu atau suami pernah didiagnosis IMS?<br/> PS: Tidak pernah, Bu, setahu saya.<br/> Peserta: Apakah ibu pernah tes HIV?<br/> PS: Belum pernah, Bu.<br/> Peserta : menjelaskan risiko IMS/HIV<br/> PS: Oh begitu ya, Bu... saya baru tahu.<br/> Peserta : menjelaskan penggunaan kondom<br/> PS: Tapi suami saya jarang mau pakai kondom, Bu.<br/> Peserta : menjelaskan dual protection<br/> PS: Jadi tetap harus pakai kondom ya walaupun KB?</p> |

| No. | Komponen                     | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | <p>Peserta: Apakah ibu bersedia tes HIV?</p> <p>PS : Aduh... saya agak takut, Bu. Tetapi kalau memang penting, saya mau coba, Bu.</p> <p>PS: Untuk tes HIV bisa dilakukan disini atau tidak ya, Bu ?</p> <p>Peserta : Untuk pemeriksaan tes HIV nanti akan saya berikan rujukannya ke Puskesmas X ya Bu</p> <p>PS : Baiklah bu, akan saya coba.</p> <p>Peserta: Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ?</p> <p>PS: Tidak, Bu. Terima kasih penjelasannya.</p>                                                                                                                       |
| 10  | Kebutuhan Alat               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja dan kursi konseling</li> <li>2. Form skrining IMS/HIV</li> <li>3. Leaflet edukasi</li> <li>4. Alat tulis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  | Critical Items (Wajib Lulus) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan skrining risiko IMS/HIV</li> <li>2. Menjaga privasi dan komunikasi empatik</li> <li>3. Memberikan edukasi kondom/dual protection</li> <li>4. Menawarkan tes HIV</li> <li>5. Menentukan rujukan bila perlu</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12  | Output yang diharapkan       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi risiko IMS/HIV</li> <li>2. Memberikan edukasi yang tepat</li> <li>3. Menentukan keputusan klinis secara aman dan profesional</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13  | Penulis                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14  | Referensi                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). <i>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual</i>. Jakarta: Kemenkes RI.</li> <li>2. World Health Organization. (2017). <i>Family planning: A global handbook for providers</i> (3rd ed.). Geneva: WHO Press.</li> <li>3. World Health Organization. (2021). <i>Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring</i>. Geneva: WHO Press.</li> </ol> |

## RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan

### KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

| Komponen yang dinilai                                           | Skoring | Skor |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1. Keluhan utama dan tujuan kunjungan                           |         |      |
| 2. Riwayat seksual (pasangan, frekuensi, perilaku)              |         |      |
| 3. Riwayat penggunaan kondom                                    |         |      |
| 4. Riwayat pasangan berisiko (misal sering bepergian)           |         |      |
| 5. Riwayat IMS sebelumnya                                       |         |      |
| 6. Riwayat tes HIV                                              |         |      |
| 7. Riwayat kesehatan reproduksi (paritas, KB sebelumnya)        |         |      |
| 8. Data tambahan relevan (dukungan pasangan, pengetahuan klien) |         |      |

#### Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

### KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

| Komponen yang dinilai                                  | Skoring | Skor |
|--------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>1. Persiapan</b>                                    |         |      |
| a. Menyapa dan memperkenalkan diri                     |         |      |
| b. Menjelaskan tujuan pemeriksaan                      |         |      |
| c. Meminta persetujuan (informed consent)              |         |      |
| d. Menjaga privasi klien                               |         |      |
| e. Hand hygiene                                        |         |      |
| <b>2. Langkah-langkah</b>                              |         |      |
| a. Melakukan skrining risiko IMS/HIV secara sistematis |         |      |
| b. Mengidentifikasi faktor risiko dengan tepat         |         |      |
| c. Menyimpulkan adanya risiko IMS/HIV                  |         |      |
| d. Menentukan kebutuhan tes HIV                        |         |      |
| e. Menentukan metode kontrasepsi yang sesuai           |         |      |
| f. Menjelaskan konsep dual protection                  |         |      |
| g. Menentukan kebutuhan rujukan                        |         |      |
| <b>3. Pasca tindakan</b>                               |         |      |
| a. Menjelaskan hasil dan rencana tindak lanjut         |         |      |

| Komponen yang dinilai              | Skoring | Skor |
|------------------------------------|---------|------|
| b. Dokumentasi/penyampaian rencana |         |      |
| c. Menutup tindakan dengan baik    |         |      |

### Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Melakukan  $\geq 12$  langkah dengan tepat
- 2= Melakukan 8–11 langkah
- 1= Melakukan 1–7 langkah
- 0= Tidak melakukan / tidak tepat

### KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

| Komponen yang dinilai                          | Skoring | Skor |
|------------------------------------------------|---------|------|
| 1. Menyapa dan membangun hubungan terapeutik   |         |      |
| 2. Menjelaskan risiko IMS/HIV secara sederhana |         |      |
| 3. Edukasi penggunaan kondom                   |         |      |
| 4. Edukasi dual protection                     |         |      |
| 5. Edukasi tes HIV dan manfaatnya              |         |      |
| 6. Memberikan kesempatan bertanya              |         |      |

### Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

### KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

| Komponen yang dinilai                   | Skoring | Skor |
|-----------------------------------------|---------|------|
| 1. Bertindak sistematis dan terstruktur |         |      |
| 2. Menjaga privasi dan kerahasiaan      |         |      |
| 3. Komunikasi jelas dan empatik         |         |      |
| 4. Percaya diri dan tidak ragu          |         |      |
| 5. Menghargai klien (non-judgmental)    |         |      |

### Skoring KOMPETENSI 4

- 3= Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar.
- 2= Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar.
- 1= Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar.
- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

## TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

(dicatat di rubrik penilaian)

### IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

| TIDAK LULUS | BORDERLINE | LULUS | SUPERIOR |
|-------------|------------|-------|----------|
| < 60        | 60-75      | 76-85 | > 85     |

Jumlah total skor

**TOTAL SKOR** =  $\frac{\text{Jumlah total skor}}{12} \times 100 =$

(Kota), .....

.....

Penguji : .....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan

| Komponen         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode penilaian | <p>DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinis mahasiswa saat melakukan tindakan pada pasien nyata di lahan praktik. Penilaian dilakukan oleh pembimbing klinik atau dosen dengan menggunakan checklist terstruktur dan diikuti dengan umpan balik langsung setelah tindakan selesai.</p> <p>Pada topik ini, DOPS digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan skrining risiko IMS/HIV, memberikan edukasi pencegahan, serta menentukan kebutuhan rujukan dalam pelayanan KB secara aman dan berpusat pada klien.</p>   | Pembimbing klinik mengamati mahasiswa saat melakukan konseling KB, skrining risiko IMS/HIV, serta edukasi pada klien secara langsung di ruang pelayanan. |
| Tujuan penilaian | <p>Tujuan DOPS pada materi ini adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan skrining risiko IMS/HIV secara sistematis</li> <li>• Mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan data klien</li> <li>• Memberikan edukasi yang tepat terkait pencegahan IMS/HIV</li> <li>• Menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan atau rujukan</li> <li>• Menunjukkan komunikasi efektif dan profesional</li> </ul> <p>Penilaian tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada performa nyata mahasiswa dalam situasi klinik.</p> | Menilai kemampuan mahasiswa dalam menggali faktor risiko IMS/HIV, memberikan edukasi pencegahan, serta menentukan kebutuhan tes HIV dan rujukan.         |
| Kasus klinik     | Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke klinik KB untuk memilih metode kontrasepsi jangka panjang. Dari anamnesis diketahui bahwa suaminya sering bekerja di luar kota dan klien jarang menggunakan kondom. Klien tidak memiliki keluhan IMS dan belum pernah melakukan tes HIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perempuan 28 tahun ingin KB jangka panjang, suami sering ke luar kota, tidak rutin menggunakan kondom, belum pernah tes HIV, tanpa gejala IMS.           |

| Komponen                         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Kasus ini mencerminkan kondisi umum di pelayanan KB, di mana klien tampak sehat tetapi memiliki faktor risiko tersembunyi terhadap IMS/HIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
| Aktivitas mahasiswa yang diamati | <p>Dalam DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan tindakan nyata, bukan sekadar diskusi. Aktivitas yang diamati meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan diri dan membangun hubungan terapeutik</li> <li>• Melakukan anamnesis terarah terkait risiko IMS/HIV</li> <li>• Mengidentifikasi faktor risiko dari hasil anamnesis</li> <li>• Menjelaskan risiko IMS/HIV kepada klien</li> <li>• Memberikan edukasi tentang penggunaan kondom dan <i>dual protection</i></li> <li>• Menawarkan tes HIV secara tepat dan etis</li> <li>• Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang sesuai</li> <li>• Menentukan kebutuhan rujukan atau tindak lanjut</li> </ul> | Mahasiswa melakukan anamnesis risiko seksual, mengidentifikasi faktor risiko, menjelaskan risiko IMS/HIV, memberikan edukasi kondom dan <i>dual protection</i> , menawarkan tes HIV, serta membantu pemilihan metode KB. |
| Aspek yang dinilai               | <p>Aspek yang dinilai dalam DOPS mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikasi tindakan:</b> ketepatan melakukan skrining risiko</li> <li>• <b>Komunikasi:</b> kemampuan menjelaskan dengan bahasa sederhana dan empatik</li> <li>• <b>Keterampilan klinis:</b> sistematis anamnesis dan pengambilan keputusan</li> <li>• <b>Profesionalisme:</b> menjaga privasi, kerahasiaan, dan sikap non-diskriminatif</li> <li>• <b>Keselamatan pasien:</b> memastikan keputusan yang aman dan berbasis kebutuhan klien</li> </ul>                                                                                                                                        | Keterampilan skrining risiko, komunikasi edukatif, pengambilan keputusan klinis, profesionalisme, serta keselamatan pasien.                                                                                              |
| Fokus observasi pembimbing       | Pembimbing fokus pada mutu performa mahasiswa selama interaksi dengan klien, antara lain:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kemampuan mahasiswa menggali riwayat seksual secara sensitif, ketepatan                                                                                                                                                  |

| Komponen            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah mahasiswa mampu menggali faktor risiko secara komprehensif</li> <li>• Apakah mahasiswa mampu menghubungkan data dengan risiko IMS/HIV</li> <li>• Apakah edukasi yang diberikan relevan dan mudah dipahami</li> <li>• Apakah mahasiswa mampu menawarkan tes HIV tanpa menimbulkan stigma</li> <li>• Apakah keputusan rujukan atau tindak lanjut sudah tepat</li> </ul>                                                                                                          | mengidentifikasi risiko, kejelasan edukasi, serta kemampuan menawarkan tes HIV tanpa stigma.                                                                           |
| Umpan balik         | <p>Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kekuatan:</b> misalnya komunikasi baik dan empatik</li> <li>• <b>Area perbaikan:</b> misalnya belum lengkap menggali riwayat seksual atau belum menjelaskan dual protection secara optimal</li> <li>• <b>Rencana perbaikan:</b> latihan komunikasi sensitif, penggunaan checklist skrining</li> </ul> <p>Umpan balik bersifat konstruktif untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan</p> | Mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan edukasi, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam menggali riwayat seksual dan lebih percaya diri saat menawarkan tes HIV.. |
| Keputusan penilaian | <p>Hasil DOPS dikategorikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kompeten:</b> mahasiswa mampu melakukan semua langkah secara sistematis, aman, dan tepat</li> <li>• <b>Perlu supervisi:</b> langkah utama sudah benar tetapi masih membutuhkan arahan</li> <li>• <b>Remedial:</b> mahasiswa belum mampu mengidentifikasi risiko atau salah dalam pengambilan keputusan</li> </ul>                                                                                                                         | Mahasiswa dinyatakan kompeten dengan supervisi minimal karena mampu melakukan sebagian besar langkah dengan baik.                                                      |
| Makna dalam OBE     | <p>DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran pada level “<b>does</b>” dalam piramida Miller.</p> <p>Melalui observasi langsung di lahan praktik, mahasiswa tidak hanya memahami konsep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mahasiswa menunjukkan capaian pada level “does”, yaitu mampu melakukan skrining IMS/HIV, edukasi, dan pengambilan keputusan secara nyata dalam pelayanan KB.           |

| Komponen | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                  | Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          | pencegahan IMS/HIV, tetapi mampu menerapkannya dalam pelayanan KB secara nyata, aman, dan profesional. Hal ini sangat penting dalam menghasilkan bidan yang kompeten, responsif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. |                                                                         |

### Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

### Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

**Tabel 5.1**

### **Portofolio pada Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan**

| Komponen           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                  | Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hakikat portofolio | Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata, bukan hanya hasil ujian. | Mahasiswa mengumpulkan bukti bahwa ia mampu melakukan skrining IMS/HIV, memberikan edukasi, dan menentukan rujukan pada klien KB dengan faktor risiko |
| Tujuan portofolio  | Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.                                                                                  | Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan dari awal belum mampu skrining hingga mampu melakukan skrining risiko IMS/HIV secara mandiri.            |
| OSCE dan DOPS      | OSCE memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium, sedangkan                                                                                                                                  | OSCE berisi simulasi skrining IMS/HIV dan edukasi kondom,                                                                                             |

| Komponen                     | Deskripsi                                                                                                                 | Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | DOPS menunjukkan performa nyata di lahan praktik.                                                                         | sedangkan DOPS berisi observasi langsung saat mahasiswa melakukan konseling KB dengan skrining risiko IMS/HIV di klinik.                                                |
| Catatan kasus singkat        | Ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, meliputi data subjektif, objektif, analisis, tindakan, dan hasil. | Mahasiswa menuliskan kasus perempuan 28 tahun dengan faktor risiko IMS/HIV, hasil skrining, edukasi yang diberikan, serta keputusan penggunaan kontrasepsi dan rujukan. |
| Refleksi patient safety      | Refleksi mengenai keselamatan pasien, termasuk identifikasi risiko, potensi kesalahan, dan upaya pencegahan.              | Mahasiswa merefleksikan pentingnya menjaga kerahasiaan status HIV, komunikasi non-diskriminatif, serta tidak melewatkan skrining risiko pada klien tanpa gejala.        |
| Feedback CI/dosen            | Umpan balik dari Clinical Instructor atau dosen mengenai performa mahasiswa selama praktik.                               | CI memberikan masukan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan ketelitian dalam menggali riwayat seksual dan menjelaskan dual protection. |
| Karakteristik penilaian      | Penilaian portofolio bersifat berkelanjutan, menilai konsistensi performa dalam berbagai situasi klinik.                  | Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman pelayanan KB, bukan hanya satu kasus skrining IMS/HIV.                                                                       |
| Bukti konsistensi kompetensi | Menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mempertahankan kualitas performa dari waktu ke waktu.                                   | Dari OSCE, DOPS, dan catatan kasus, mahasiswa secara konsisten mampu melakukan skrining risiko, edukasi, dan menentukan rujukan dengan tepat.                           |
| Makna dalam OBE              | Portofolio memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level "does" (mampu melakukan dalam praktik nyata).        | Mahasiswa tidak hanya memahami teori IMS/HIV, tetapi mampu menerapkannya dalam pelayanan KB secara profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien.                |

**Tabel 5.2**  
**Case Report pada Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan**

| <b>Komponen</b>                    | <b>Deskripsi</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB</b>                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hakikat case report</b>         | Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, berfungsi sebagai bukti kemampuan analisis dan dokumentasi klinis. | Mahasiswa menyusun laporan tentang klien KB dengan faktor risiko IMS/HIV yang teridentifikasi melalui skrining.   |
| <b>Tujuan</b>                      | Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data, menganalisis masalah, menentukan tindakan, dan mengevaluasi hasil.                                                                              | Mahasiswa mampu menghubungkan faktor risiko dengan kebutuhan edukasi dan rujukan pada klien KB.                   |
| <b>Identitas pasien</b>            | Data dasar pasien yang relevan untuk konteks klinis.                                                                                                                                                         | Perempuan, 28 tahun, P1A0, datang untuk memilih metode KB jangka panjang.                                         |
| <b>Keluhan utama</b>               | Alasan utama pasien datang ke fasilitas kesehatan.                                                                                                                                                           | Ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang.                                                                     |
| <b>Data subjektif</b>              | Data hasil anamnesis dari pasien.                                                                                                                                                                            | Suami sering bekerja di luar kota, jarang menggunakan kondom, belum pernah tes HIV, tidak ada keluhan IMS.        |
| <b>Data objektif</b>               | Hasil pemeriksaan fisik atau data pendukung lainnya.                                                                                                                                                         | Keadaan umum baik, tidak ditemukan tanda-tanda IMS secara klinis.                                                 |
| <b>Analisis masalah</b>            | Interpretasi data untuk mengidentifikasi masalah kebidanan/kesehatan.                                                                                                                                        | Klien memiliki risiko IMS/HIV berdasarkan riwayat pasangan dan tidak menggunakan kondom secara konsisten.         |
| <b>Diagnosis/masalah kebidanan</b> | Penetapan masalah utama berdasarkan analisis data.                                                                                                                                                           | Risiko tinggi terhadap IMS/HIV pada klien KB.                                                                     |
| <b>Rencana tindakan</b>            | Perencanaan asuhan berdasarkan masalah yang ditemukan.                                                                                                                                                       | Melakukan edukasi IMS/HIV, menawarkan tes HIV, menganjurkan penggunaan kondom, dan memilih metode KB yang sesuai. |
| <b>Implementasi</b>                | Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa/bidan.                                                                                                                                                                | Memberikan konseling tentang risiko IMS/HIV,                                                                      |

| Komponen                 | Deskripsi                                                           | Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                     | menjelaskan <i>dual protection</i> , menawarkan tes HIV, dan membantu pemilihan metode kontrasepsi.                                  |
| Evaluasi                 | Penilaian hasil dari tindakan yang telah dilakukan.                 | Klien memahami risiko, bersedia menggunakan kondom, dan mempertimbangkan tes HIV.                                                    |
| Pembelajaran dari kasus  | Refleksi mahasiswa terhadap pengalaman klinik yang didapatkan.      | Pentingnya skrining risiko IMS/HIV meskipun klien tidak memiliki gejala, serta pentingnya komunikasi empatik dalam edukasi sensitif. |
| Keterkaitan dengan teori | Hubungan antara kasus dengan konsep atau teori yang dipelajari.     | Kasus menunjukkan penerapan skrining risiko, edukasi <i>dual protection</i> , dan sistem rujukan sesuai pedoman nasional.            |
| Makna dalam OBE          | Menunjukkan capaian pembelajaran berbasis performa nyata mahasiswa. | Mahasiswa mampu menerapkan teori ke praktik pelayanan KB secara komprehensif dan profesional.                                        |

**Tabel 5.3**  
**Refleksi Patient Safety pada Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan**

| Komponen                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                 | Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hakikat refleksi patient safety | Refleksi patient safety merupakan proses berpikir kritis mahasiswa untuk mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, potensi kesalahan, serta upaya pencegahan dalam pelayanan kesehatan. | Mahasiswa merefleksikan pengalaman saat melakukan skrining IMS/HIV pada klien KB dengan faktor risiko tersembunyi. |
| Identifikasi risiko             | Mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat memengaruhi keselamatan pasien.                                                                                                                | Risiko tidak terdeteksinya IMS/HIV karena klien tidak menunjukkan gejala, serta risiko penularan dari pasangan.    |

| <b>Komponen</b>                   | <b>Deskripsi</b>                                                | <b>Contoh pada Kasus Skrining Risiko IMS/HIV dan Edukasi pada Pelayanan KB</b>                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potensi kesalahan (error)</b>  | Kesalahan yang mungkin terjadi selama pelayanan.                | Tidak menggali riwayat seksual secara lengkap, tidak menawarkan tes HIV, atau mengabaikan penggunaan kondom dalam konseling.             |
| <b>Faktor penyebab</b>            | Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan.                   | Kurangnya keterampilan komunikasi sensitif, keterbatasan waktu pelayanan, atau asumsi bahwa klien "tidak berisiko".                      |
| <b>Dampak terhadap pasien</b>     | Konsekuensi yang dapat terjadi jika kesalahan tidak dicegah.    | Keterlambatan diagnosis IMS/HIV, peningkatan risiko penularan, serta komplikasi kesehatan reproduksi.                                    |
| <b>Tindakan pencegahan</b>        | Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan.       | Melakukan skrining risiko secara sistematis, menggunakan checklist, dan meningkatkan keterampilan komunikasi empatik.                    |
| <b>Prinsip keselamatan pasien</b> | Prinsip yang harus diterapkan dalam pelayanan.                  | Menjaga kerahasiaan status HIV, informed consent sebelum tes, serta pelayanan non-diskriminatif.                                         |
| <b>Peran tenaga kesehatan</b>     | Peran bidan dalam menjaga keselamatan pasien.                   | Bidan memastikan skrining dilakukan pada semua klien berisiko, memberikan edukasi yang tepat, dan menentukan rujukan secara aman.        |
| <b>Refleksi diri mahasiswa</b>    | Evaluasi diri terhadap performa yang telah dilakukan.           | Mahasiswa menyadari pentingnya tidak melewatkan skrining IMS/HIV meskipun klien tampak sehat.                                            |
| <b>Rencana perbaikan</b>          | Langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan. | Meningkatkan kemampuan komunikasi, menggunakan panduan skrining, dan lebih aktif dalam edukasi pencegahan IMS/HIV.                       |
| <b>Makna dalam OBE</b>            | Refleksi sebagai bagian dari pembelajaran berbasis outcome.     | Mahasiswa menunjukkan perkembangan kompetensi tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam aspek keselamatan pasien dan profesionalisme. |

## K. Ringkasan Materi

Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan reproduksi yang signifikan karena sering tidak bergejala pada tahap awal, sehingga banyak kasus tidak terdeteksi dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti infertilitas, kehamilan ektopik, hingga kanker serviks. HIV memiliki dampak yang lebih kompleks karena menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat berkembang menjadi AIDS, serta berisiko ditularkan dari ibu ke anak. Oleh karena itu, pencegahan IMS/HIV menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan reproduksi, khususnya pada kelompok usia reproduktif yang aktif secara seksual.

Integrasi pencegahan IMS/HIV dalam pelayanan keluarga berencana (KB) merupakan strategi yang efektif karena pelayanan KB menjadi pintu masuk utama bagi klien untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Pendekatan ini mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan prinsip continuum of care serta konsep dual protection, yaitu perlindungan terhadap kehamilan sekaligus IMS/HIV. Dengan integrasi ini, klien dapat memperoleh layanan yang lebih menyeluruh, efisien, dan berkesinambungan.

Skrining risiko IMS/HIV dalam pelayanan KB merupakan langkah penting untuk mendeteksi dini individu yang berisiko. Skrining dilakukan melalui anamnesis riwayat seksual, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti tes HIV. Hasil skrining digunakan untuk mengelompokkan risiko klien menjadi rendah, sedang, atau tinggi, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut berupa edukasi, konseling, atau rujukan. Namun, pelaksanaan skrining sering menghadapi tantangan seperti stigma, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya keterbukaan klien.

Edukasi atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan komponen penting dalam pencegahan IMS/HIV. Edukasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku melalui komunikasi yang empatik, tidak menghakimi, dan mudah dipahami. Materi edukasi meliputi seks aman, penggunaan kondom, pentingnya tes HIV, serta pencegahan penularan ibu ke anak. Bidan berperan sebagai edukator dan konselor yang membantu klien dalam pengambilan keputusan yang tepat, termasuk dalam pemilihan metode kontrasepsi dan penerapan dual protection.

Rujukan merupakan bagian penting dalam pelayanan KB terintegrasi IMS/HIV untuk memastikan klien mendapatkan pelayanan lanjutan yang sesuai. Proses rujukan dilakukan secara sistematis dengan tetap menjaga kontinuitas pelayanan melalui tindak lanjut. Dalam keseluruhan proses ini, tenaga kesehatan harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, etika, keselamatan pasien, serta kerahasiaan. Pendekatan Evidence Based Midwifery (EBM) memperkuat bahwa

skrining, edukasi, dan penggunaan kondom merupakan intervensi yang efektif dalam menurunkan penularan IMS/HIV, sehingga penting diterapkan secara konsisten dalam praktik kebidanan.

#### L. Alur asuhan singkat

Skrining risiko IMS/HIV → Analisis & klasifikasi risiko (rendah / tinggi) → Edukasi (penularan, pencegahan, kondom, *dual protection*) → Tindakan lanjut (pilih metode KB + tawarkan tes HIV) → Rujukan (jika risiko tinggi/gejala IMS) → Dokumentasi.

#### M. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan

| Red Flags (Tanda Bahaya)                                                            | Makna Klinis                       | Tindakan/Eskalasi yang Dilakukan                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Riwayat pasangan berisiko (sering bepergian, multi partner)                         | Risiko tinggi terpapar IMS/HIV     | Lakukan skrining mendalam, edukasi intensif, tawarkan tes HIV |
| Tidak menggunakan kondom secara konsisten                                           | Risiko penularan IMS/HIV meningkat | Edukasi penggunaan kondom, anjurkan <i>dual protection</i>    |
| Riwayat IMS sebelumnya                                                              | Menandakan paparan infeksi seksual | Evaluasi ulang, pertimbangkan pemeriksaan IMS dan tes HIV     |
| Belum pernah tes HIV                                                                | Status HIV tidak diketahui         | Tawarkan tes HIV secara sukarela dan konseling                |
| Gejala IMS (keputihan abnormal, luka genital, nyeri saat berkemih/hubungan seksual) | Kemungkinan infeksi aktif          | Lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau rujuk ke layanan IMS    |

| Red Flags (Tanda Bahaya)                                 | Makna Klinis                           | Tindakan/Eskalasi yang Dilakukan                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pasangan diketahui HIV positif                           | Risiko penularan sangat tinggi         | Rujuk untuk tes HIV, konseling, dan layanan lanjutan          |
| Klien dengan perilaku berisiko (misal berganti pasangan) | Risiko tinggi penularan IMS/HIV        | Skrining komprehensif, edukasi perilaku aman, tes HIV         |
| Ibu hamil dengan faktor risiko IMS/HIV                   | Risiko penularan ibu ke bayi           | Rujuk untuk pemeriksaan dan penanganan sesuai program PMTCT   |
| Klien menolak edukasi atau tidak memahami informasi      | Risiko kesalahan persepsi dan perilaku | Ulangi edukasi dengan pendekatan berbeda, gunakan media bantu |
| Ditemukan hasil skrining/tes reaktif HIV                 | Indikasi kemungkinan infeksi HIV       | Rujuk segera ke layanan HIV untuk konfirmasi dan terapi ARV   |

## N. Referensi

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2017). *Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi*. Jakarta: BKKBN.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Buku saku IMS HIV: Siap cetak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Buku saku HIV/AIDS dan infeksi menular seksual*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Diseminasi pedoman layanan HIV/AIDS dan IMS dalam skema JKN*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Rusmini, et al. (2023). *Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi berbasis evidence based*. Jakarta: Kubuku.
- Ruwayda, R., dkk. (2020). *Buku ajar pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi*. Jakarta: EGC.

# BAB 6

## MANAJEMEN PELAYANAN KB: LOGISTIK, PENCATATAN-PELAPORAN, MUTU DAN KESELAMATAN.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):

---

**CPL-1:** Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan regulasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

**CPL-3:** Menerapkan prinsip keselamatan, pencegahan infeksi, serta perlindungan privasi dan kerahasiaan dalam layanan KB/kespro

**CPL-6:** Mengelola layanan KB/kespro melalui pencatatan-pelaporan, logistik, rujukan, evaluasi mutu, dan perbaikan berkelanjutan

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

---

#### CPMK Utama

**CPMK-7:** Mengelola pelayanan KB/kespro (IMS/HIV, logistik, pencatatan-pelaporan, mutu, keselamatan, evaluasi kepuasan) berbasis data

#### CPMK Penguat

**CPMK-1:** Menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika–legal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan.

#### Sub-CPMK:

Sub-CPMK 1: Merancang sistem logistik kontrasepsi (perencanaan, penyimpanan, ketersediaan)

Sub-CPMK 2: Menyusun pencatatan-pelaporan, audit mutu, dan penerapan keselamatan layanan

## Uraian Materi

---

### A. Pendahuluan

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) merupakan intervensi strategis yang melampaui tindakan klinis semata, karena secara langsung berkontribusi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pencegahan kehamilan berisiko tinggi, jarak kelahiran pendek, serta aborsi tidak aman. Data terbaru menunjukkan kemajuan signifikan pasca-SUPAS 2015 (AKI 305 per 100.000 kelahiran hidup), di mana AKI Indonesia pada 2020-2022 turun menjadi sekitar 189-305 per 100.000 KH, meski masih di atas target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 KH, sementara AKB berada di kisaran 20-25 per 1.000 kelahiran hidup dengan tantangan stunting dan unmet need KB yang tinggi.

Program KB, yang dikoordinasikan BKKBN dan Kemenkes, menargetkan *Total Fertility Rate* (TFR) 2,24 pada 2021 dan 2,1 pada 2024, dengan peningkatan peserta KB aktif menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hingga 28,39%. Akses KB yang optimal dapat mengurangi 24% AKI dan 18% kematian bayi baru lahir melalui pemenuhan 100% kebutuhan kontrasepsi, termasuk pencegahan kehamilan tak direncanakan hingga 70% (Kemenkes RI, 2024).

Manajemen pelayanan KB efektif difokuskan pada peningkatan *availability* (ketersediaan alat kontrasepsi via e-procurement dan sistri), *accessibility* (perluasan layanan ramah remaja dan pasca-salin), *acceptability* (konseling informed choice dan KIE), serta *quality* (standar mutu terintegrasi dengan jaga mutu KB-KIA). Tanpa logistik kuat dan pelaporan berbasis data (seperti Pendataan Keluarga 2021), hambatan akses terhadap kontrasepsi aman akan memperburuk indikator kesehatan reproduksi (BKKBN, 2021).

Renstra Kemenkes 2020-2024 menekankan kolaborasi swasta-pemerintah untuk optimalisasi layanan, termasuk promosi MKJP, revisi standar konseling, dan sistem jaminan kualitas yang terintegrasi dengan pencegahan IMS/HIV. Upaya ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penurunan unmet need KB via peningkatan demand dan infrastruktur (Kemenkes RI, 2024; YKPI, 2025).

### B. Manajemen Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)

#### 1. Konsep Dasar

Manajemen logistik alat dan obat kontrasepsi (alokon) merupakan komponen kunci keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) karena menentukan kesinambungan ketersediaan metode kontrasepsi yang aman, bermutu, dan terjangkau di semua jenjang fasilitas pelayanan kesehatan. Integrasi manajemen logistik alokon dengan sistem manajemen farmasi nasional

dan tata kelola rantai pasok kesehatan menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan farmasi dan alat kesehatan dalam kerangka RPJMN 2025–2029, termasuk upaya menurunkan unmet need KB melalui ketersediaan pasokan yang terjamin hingga level Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Buntoro, dkk, 2021)

Manajemen logistik alokon adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi alat dan obat kontrasepsi untuk menjamin tercapainya jaminan ketersediaan kontrasepsi (JKK) yang berkesinambungan. Sistem JKK yang baik memastikan bahwa setiap pasangan usia subur yang menginginkan layanan KB dapat mengakses metode yang sesuai tanpa hambatan ketersediaan, sehingga mendukung penurunan angka kelahiran dan pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi (Pratiwi, D.A., 2020)

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa kekosongan stok pil, suntik, implan, IUD, dan kondom di Puskesmas masih terjadi bila sistem logistik tidak terintegrasi dan tidak mengikuti kaidah manajemen logistik modern. Puskesmas yang menerapkan sistem logistik kontrasepsi terintegrasi terbukti memiliki peluang lebih besar untuk mencapai ketercukupan JKK dibandingkan fasilitas yang belum menerapkannya, menunjukkan pentingnya penguatan manajemen logistik sebagai pilar program KB (Buntoro, dkk, 2021)

## 2. Manajemen Logistik Alokon dalam Kerangka Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional kefarmasian dan alat kesehatan menempatkan pengelolaan logistik obat dan alat kesehatan, termasuk alokon, sebagai bagian dari standar pelayanan kefarmasian dan upaya penguatan ketahanan kesehatan. Pedoman manajemen pelayanan KB dan standar kefarmasian menekankan fungsi manajemen logistik yang meliputi seleksi produk, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi logistik.

Dalam konteks RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan penguatan sistem logistik kesehatan melalui efisiensi distribusi, pengurangan ketergantungan impor obat dan alat kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan stok secara real time. Dalam sektor KB, BKKBN mengintegrasikan supply chain management alokon dengan strategi Bangga Kencana guna menurunkan unmet need KB dan meningkatkan akses layanan KB yang berkualitas, terutama di wilayah tertinggal, terpencil, dan kepulauan (DTPK).

### 3. Tujuan dan Prinsip Manajemen Logistik Alokon

Tujuan utama manajemen logistik alokon adalah menjamin ketersediaan metode kontrasepsi yang tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, dan tempat, dengan biaya yang efisien dan selaras dengan kebutuhan populasi sasaran. Selain itu, pengelolaan logistik bertujuan mendukung penggunaan kontrasepsi yang rasional dan berbasis hak, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, efektivitas, dan preferensi klien (UNFPA Indonesia & BKKBN, 2020)

Prinsip yang digunakan antara lain pendekatan berbasis kebutuhan (*demand-driven*), integrasi dengan sistem logistik farmasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan, penerapan standar penyimpanan dan distribusi yang menjamin mutu fisik, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Di tingkat fasyankes, keterlibatan tenaga kesehatan, farmasis, dan pengelola program KB dalam tim logistik menjadi faktor penting agar kebijakan dan praktik manajemen logistik alokon berjalan konsisten (Kemenkes RI, 2020).

### 4. Perencanaan Kebutuhan Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi)

Perencanaan kebutuhan alokon merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan keseluruhan sistem logistik karena menjadi dasar pengadaan dan distribusi. Perencanaan yang tidak akurat dapat berujung pada kekosongan stok (stockout) atau kelebihan stok (overstock) yang meningkatkan risiko kedaluwarsa, pemborosan anggaran, dan terganggunya kontinuitas layanan KB (BKKBN, 2020).

Pendekatan bottom-up dianjurkan dalam perencanaan kebutuhan alokon, di mana data kebutuhan dihimpun dari level pelayanan terendah (Puskesmas, klinik, praktik mandiri) berdasarkan tren pemakaian, peserta aktif, peserta baru, dan proyeksi permintaan masyarakat (PPM). Data tersebut kemudian dikompilasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, sehingga perencanaan mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Perencanaan dilakukan dengan metode bottom-up untuk menghindari kekosongan atau kelebihan stok. Perkiraan kebutuhan tahunan dihitung berdasarkan rumus berikut,:

- a. AKDR/IUD : 1 biji  $\times$  Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) Peserta Baru.
- b. Implan : 1 set  $\times$  PPM Peserta Baru.
- c. Suntikan : 4 vial  $\times$  PPM Peserta Aktif (PA) per tahun.
- d. Pil : 13 cycle  $\times$  PPM PA Pil per tahun.
- e. Kondom : 6 lusin  $\times$  PPM PA Kondom per tahun.

Formulasi ini mempermudah petugas dalam menyusun rencana kebutuhan tahunan alokon sekaligus mengantisipasi variasi permintaan musiman, migrasi, dan faktor lain yang memengaruhi pola pemakaian kontrasepsi. Namun,

perhitungan harus disertai koreksi berdasarkan tren realisasi pemakaian tahun sebelumnya, kebijakan promosi metode jangka panjang, dan perubahan pola fertilitas di wilayah kerja (UNFPA Indonesia & BKKBN, 2020)

#### 5. Integrasi Perencanaan dengan Sistem Informasi

Perencanaan kebutuhan alokon semakin efektif bila didukung sistem informasi manajemen logistik yang merekam data stok, pemakaian, dan distribusi secara berkala. Integrasi dengan sistem informasi manajemen keluarga berencana dan sistem informasi farmasi memungkinkan analisis indikator seperti tingkat kelangkaan stok, lead time distribusi, dan tingkat kedaluwarsa, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan proyeksi kebutuhan berikutnya.

Penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk pencatatan dan pelaporan logistik alokon juga mendukung transparansi dan koordinasi antara BKKBN, dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, dan mitra swasta. Dengan demikian, perencanaan kebutuhan alokon tidak lagi mengandalkan perkiraan subjektif, tetapi berbasis data dan dapat diaudit (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

#### 6. Penyimpanan dan Penjagaan Mutu Fisik

Penyimpanan alokon harus memenuhi standar kefarmasian karena sebagian besar produk kontrasepsi sensitif terhadap suhu, kelembapan, dan paparan cahaya. Kondisi penyimpanan yang tidak sesuai dapat menurunkan stabilitas obat, merusak kemasan, dan menurunkan efektivitas klinis sehingga membahayakan keselamatan klien.

Pedoman pelayanan KB dan standar penyimpanan obat mengatur bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib menyediakan ruang penyimpanan yang bersih, kering, terlindung dari sinar matahari langsung, dengan ventilasi dan pengendalian suhu yang memadai. Penataan alokon dalam gudang hendaknya memperhatikan jarak dari lantai dan dinding, penggunaan rak, serta adanya pemisahan dengan bahan lain yang dapat menimbulkan kontaminasi atau kerusakan (BKKBN, 2020)

Alokon memiliki sensitivitas terhadap suhu dan kelembapan. Standar penyimpanan yang wajib dipatuhi adalah:

##### a. Pil & Kondom

Pil kontrasepsi dan kondom merupakan produk yang relatif stabil pada suhu ruang, tetapi sangat sensitif terhadap kelembapan tinggi dan paparan panas ekstrem atau sinar matahari langsung. Standar penyimpanan mensyaratkan bahwa pil dan kondom disimpan di tempat kering dengan suhu tidak lebih dari 40°C, terlindung dari cahaya langsung, dan dalam kemasan aslinya hingga waktu pemakaian

Untuk kondom, integritas kemasan (*foil* atau sachet) harus sering diperiksa karena kerusakan kecil dapat menurunkan keandalan sebagai alat kontrasepsi dan pencegah infeksi menular seksual. Kondom sebaiknya tidak disimpan berdekatan dengan sumber panas seperti lampu, mesin, atau jendela dengan paparan cahaya kuat, dan tidak ditekan oleh beban berat agar struktur lateks tetap terjaga (Kemenkes RI, 2020).

b. Suntikan & AKDR

Sediaan suntik kontrasepsi dan AKDR (IUD) memerlukan penyimpanan pada suhu ruang yang terkontrol, umumnya berkisar 15–30°C sesuai standar farmakope dan pedoman nasional. Vial suntik harus disimpan dalam posisi tegak dengan label terbaca jelas, sehingga meminimalkan risiko kebocoran, kontaminasi, atau penggumpalan sediaan (BKKBN, 2020)

AKDR disimpan dalam kemasan steril pabrik dan harus terlindungi dari kelembapan dan kontaminasi mikroba; oleh karena itu, penempatannya di rak tertutup atau lemari dengan pintu lebih dianjurkan. Petugas wajib secara berkala memeriksa tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan, dan adanya perubahan fisik pada sediaan sebelum digunakan pada klien (Buntoro, K., dkk, 2021)

c. Implan

Alat kontrasepsi Implan, yang umumnya berupa rod berisi hormon dalam kemasan steril, sensitif terhadap suhu tinggi dan kelembapan. Standar penyimpanan mengharuskan implan disimpan di tempat kering dengan suhu di bawah 30°C, jauh dari sumber panas dan sinar matahari langsung, serta tetap dalam kemasan steril sampai saat pemasangan. Ketelitian dalam menjaga mutu fisik implan sangat penting karena kerusakan kemasan atau paparan suhu di luar batas dapat memengaruhi pelepasan hormon dan efektivitas jangka panjang. Pencatatan batch number dan tanggal kedaluwarsa setiap implan yang dipakai juga menjadi bagian dari farmakovigilans dan pelacakan jika terjadi masalah mutu (Buntoro, K., dkk, 2021)

7. Sistem Distribusi: Kebijakan FEFO dan FIFO

Distribusi alokon adalah proses pemindahan alat dan obat kontrasepsi dari gudang pusat ke unit pelayanan, baik antar level (nasional–provinsi–kabupaten–Puskesmas) maupun antar fasilitas. Sistem distribusi yang baik menjamin bahwa alokon yang diterima klien masih berada dalam masa edar yang aman, tidak rusak, serta sesuai jenis dan jumlah dengan kebutuhan pelayanan.

Dua prinsip utama yang digunakan dalam distribusi alokon adalah FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (*First In First Out*). Penerapan kedua prinsip ini

melindungi mutu produk dan mencegah kerugian akibat kedaluwarsa, sehingga berkontribusi pada efisiensi pembiayaan program KB.

Untuk menjamin kualitas alokon yang diterima klien, diterapkan sistem distribusi FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*):

a. FEFO

Alokon dengan masa kadaluwarsa lebih awal harus dikeluarkan/digunakan terlebih dahulu.

b. Langkah Teknis FEFO

Petugas wajib meneliti setiap dus alokon, menyusunnya berdasarkan urutan kedaluwarsa, dan menempatkan dus dengan masa kadaluwarsa terdekat di posisi paling atas agar mudah diambil.

c. FIFO

FIFO berarti bahwa alokon yang pertama kali masuk ke gudang harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk digunakan atau didistribusikan. Prinsip ini penting saat produk memiliki tanggal kedaluwarsa yang relatif seragam atau ketika informasi kedaluwarsa tidak tersedia lengkap, sehingga urutan kedatangan menjadi acuan.

Dalam praktik, FEFO dan FIFO sering diterapkan secara bersamaan, dengan prioritas pertama pada tanggal kedaluwarsa dan prioritas kedua pada tanggal penerimaan barang. Hal ini memastikan tidak ada stok lama yang terlupakan di rak dan mengurangi risiko penumpukan stok usang yang menurunkan efisiensi logistik program KB (BKKBN, 2020; Pratiwi, 2020).

### C. Manajemen Pencatatan dan Pelaporan

Manajemen pencatatan dan pelaporan pelayanan KB merupakan fondasi utama pengambilan keputusan berbasis data dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, memastikan akurasi data peserta aktif, mutasi stok alokon, dan kontinuitas layanan. Sistem ini mendukung pemantauan wilayah setempat KB, pencegahan duplikasi data, dan integrasi dengan Sistem Kesehatan Nasional serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Kemenkes RI, 2025).

#### 1. Pentingnya Pencatatan dan Pelaporan dalam Program KB

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu menyediakan data primer untuk perencanaan kebutuhan alokon, alokasi sumber daya, dan evaluasi pencapaian target KB seperti cakupan peserta aktif (CPR) dan penurunan unmet need. Tanpa sistem pencatatan yang baik, pengelola program sulit mengidentifikasi masalah seperti drop-out peserta atau kekosongan stok, yang dapat menghambat target RPJMN 2025–2029.

Pelaporan berjenjang memungkinkan agregasi data dari level mikro (Pustu, Puskesmas) hingga nasional, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti BKKBN, Kemenkes, dan pemerintah daerah. Pedoman nasional menekankan prinsip keseragaman instrumen dan alur pelaporan untuk menghindari kesalahan data dan meningkatkan kualitas manajemen pelayanan KB.

## 2. Instrumen Pencatatan Standar di Fasilitas Kesehatan

Setiap fasilitas pelayanan KB (faskes KB) wajib menggunakan instrumen standar yang dirancang untuk mencatat data klinis, administratif, dan logistik secara lengkap dan akurat. Instrumen ini mencakup kartu peserta, register kohort, dan register stok alokon, yang menjadi sumber data utama untuk pelaporan bulanan.

Penggunaan instrumen standar memastikan interoperabilitas data antar faskes dan integrasi dengan sistem informasi seperti e-Kohort atau SIMLOG KB, sehingga data dapat diverifikasi dan dimanfaatkan untuk analisis tren pemakaian KB.

### a. Kartu Peserta KB(K/I/KB)

Kartu Peserta KB (K/I/KB) diberikan kepada peserta sebagai bukti status kepesertaan KB, berisi data identitas, riwayat kontrasepsi, tanggal pemasangan, dan jadwal kunjungan ulang. Peserta menyimpan kartu ini untuk memudahkan akses layanan lanjutan, sementara salinan data dicatat di faskes untuk pemantauan kontinuitas. Instrumen ini mendukung pencegahan duplikasi pendaftaran dan pelacakan peserta berisiko drop-out, terutama pada metode jangka panjang seperti implan atau IUD.

### b. Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB)

Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB) merupakan rekam medis klinis yang disimpan di faskes, mencatat detail pemeriksaan pra-pemasangan, komplikasi, dan tindak lanjut. Kartu ini digunakan tenaga kesehatan untuk evaluasi klinis dan farmakovigilans, memastikan keselamatan peserta sesuai standar pelayanan KB. Data dari K/IV/KB menjadi dasar rekonsiliasi dengan kartu peserta dan register kohort, menghindari ketidaksesuaian informasi antar instrumen.

### c. Register Kohort KB

Register Kohort KB berfungsi sebagai alat pemantauan kunjungan ulang peserta untuk mencegah putus pakai (drop-out), dengan mencatat identitas, metode KB, jadwal follow-up, dan status kunjungan. Tenaga kesehatan wajib melacak peserta yang tidak datang tepat waktu melalui kader KB atau PLKB posyandu, menggunakan data kohort untuk kunjungan rumah atau pengingat

SMS. Instrumen ini krusial untuk metode berinterval seperti suntik dan pil, di mana kontinuitas bergantung pada kepatuhan peserta.

d. Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB)

Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB) mencatat mutasi stok alokon secara bulanan, termasuk penerimaan, distribusi, pemakaian, dan saldo akhir. Data ini mendukung perencanaan pengadaan dan pencegahan stockout/overstock, dengan kolom khusus untuk batch number dan tanggal kadaluwarsa. Pengisian register dilakukan harian oleh petugas farmasi atau logistik, dan direkap untuk pelaporan ke tingkat atas (BKKBN, 2020).

3. Alur Pelaporan Berjenjang

Pelaporan dilakukan setiap akhir bulan dengan alur berjenjang yang ketat untuk memastikan data mengalir dari level terbawah ke pusat secara akurat dan tepat waktu. Alur ini mendukung agregasi data nasional dan pemantauan real-time melalui platform digital. Keterlambatan pelaporan dapat mengganggu perencanaan distribusi alokon dan evaluasi program, sehingga sanksi administratif diterapkan bagi faskes yang tidak patuh.

Laporan disusun setiap bulan dengan alur sebagai berikut:

a. Pelaporan dari Jaringan Kebawah Puskesmas

Jaringan pelayanan seperti Pustu, Bidan Desa, atau Praktik Mandiri Bidan (PMB) mencatat harian menggunakan buku bantu, kemudian menyusun laporan bulanan dan menyerahkannya ke Puskesmas penanggung jawab wilayah paling lambat tanggal 5 setiap bulan. Laporan mencakup data peserta baru, aktif, drop-out, dan mutasi alokon dari jaringan tersebut.

Puskesmas melakukan rekapitulasi seluruh wilayah kerjanya, termasuk verifikasi data dari jaringan, sebelum melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke SKPD KB setempat.

b. Pelaporan dari Puskesmas ke Provinsi dan Pusat

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengompilasi laporan dari Puskesmas, kemudian melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat tanggal 10. Provinsi mereview dan meneruskan ke Kementerian Kesehatan serta Perwakilan BKKBN Provinsi untuk agregasi nasional. Laporan bulanan diformat standar (misalnya F/I/KB untuk rekap pelayanan), sementara pelaporan tahunan mencakup pemutakhiran data faskes KB baru melalui K/0/KB/13.

## **D. Manajemen Mutu Pelayanan**

Manajemen mutu pelayanan KB menjamin bahwa layanan kontrasepsi memenuhi standar profesi medis, hak klien, dan prinsip pelayanan berbasis bukti, sehingga meningkatkan kepuasan peserta dan efektivitas program. Mutu dinilai dari kesesuaian proses dan outcome dengan enam elemen standar, serta mekanisme pengawasan internal seperti kajian mandiri dan penyeliaan fasilitatif.

### **1. Konsep Mutu Pelayanan KB Berkualitas**

Mutu pelayanan KB didefinisikan sebagai tingkat pencapaian standar pelayanan yang aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada klien, sesuai dengan kerangka Judith Bruce (1990) yang diadopsi BKKBN. Enam elemen kunci ini menjadi dasar survei indeks kualitas pelayanan KB, memastikan pelayanan tidak hanya klinis tapi juga menghormati hak reproduksi.

Pedoman manajemen pelayanan KB menekankan integrasi mutu dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana faskes KB dievaluasi secara berkala untuk mencapai indeks mutu minimal 70%.

### **2. Standar Pelayanan KB Berkualitas**

Standar pelayanan KB berkualitas mencakup enam elemen esensial yang harus dipenuhi di setiap faskes, dari Puskesmas hingga rumah sakit, untuk mendukung pilihan sadar dan kontinuitas pemakaian kontrasepsi. Elemen-elemen ini dievaluasi melalui observasi, wawancara klien, dan audit rekam medis. Penerapan standar ini mendukung target RPJMN 2025–2029 dalam meningkatkan CPR dan menurunkan unmet need KB melalui pelayanan yang inklusif dan berbasis hak (Kemenkes, 2025).

Mutu pelayanan harus mencakup 6 elemen kunci:

#### **a. Pilihan Metode Kontrasepsi (Cafeteria System)**

Elemen pertama adalah penyediaan pilihan metode kontrasepsi secara bebas (cafeteria system), di mana klien diberi informasi lengkap tentang berbagai metode modern seperti pil, suntik, implan, IUD, kondom, dan sterilisasi tanpa paksaan. Faskes wajib menyediakan minimal enam jenis metode untuk memenuhi kebutuhan beragam klien, termasuk remaja dan pasca persalinan. Sistem ini meningkatkan penerimaan dan kepuasan klien, mengurangi drop-out akibat ketidaksesuaian metode.

#### **b. Informasi yang Memadai kepada Klien**

Klien berhak menerima informasi lengkap, jujur, dan mudah dipahami tentang efektivitas, efek samping, interaksi obat, dan alternatif metode, termasuk risiko kegagalan dan manfaat kesehatan. Konseling informasi dilakukan pra dan pasca pemasangan, dengan leaflet atau media visual sebagai pendukung.

Informasi memadai mengurangi ketakutan irasional dan meningkatkan kepatuhan, sesuai prinsip hak ber-KB berbasis bukti.

c. Kompetensi Teknis Petugas

Petugas KB harus memiliki sertifikasi kompetensi teknis untuk prosedur seperti pemasangan IUD, implan, dan suntik, dengan refreshment training minimal dua tahun sekali. Kompetensi dievaluasi melalui observasi prosedur aseptis, manajemen komplikasi, dan pemantauan pasca layanan. Kurangnya kompetensi teknis sering menjadi penyebab kegagalan metode dan ketidakpuasan klien.

d. Interaksi Interpersonal (Konseling)

Interaksi interpersonal melibatkan konseling yang empati, rahasia, dan non-diskriminatif, membangun kepercayaan antara petugas dan klien. Petugas dilatih keterampilan mendengar aktif, eksplorasi kebutuhan, dan penanganan pertanyaan sensitif. Hubungan baik ini meningkatkan retensi peserta dan efektivitas program KB.

e. Mekanisme Kelanjutan Pemakaian

Mekanisme ini mencakup register kohort, pengingat kunjungan ulang, dan pelacakan drop-out melalui kader KB atau telepon. Faskes menyusun rencana tindak lanjut untuk metode berinterval, memastikan kontinuitas. Kelanjutan pemakaian menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan.

f. Jaringan Pelayanan yang Memadai

Jaringan pelayanan mencakup rujukan antar jenjang faskes, ketersediaan alokon, dan integrasi dengan layanan kesehatan ibu anak. Setiap wilayah harus memiliki Puskesmas KB dan jaringan desa untuk akses merata. Jaringan kuat mengurangi disparitas akses di daerah terpencil (BKKBN, 2020).

3. Instrumen Pengawasan Mutu

Pengawasan mutu dilakukan melalui kajian mandiri internal dan penyeliaan fasilitatif eksternal untuk identifikasi gap dan perbaikan berkelanjutan. Instrumen ini berbasis 12 modul evaluasi, mencakup SDM, fasilitas, dan outcome layanan. Pendekatan ini berfokus pada sistem, bukan individu, sesuai Peraturan BKKBN No. 18/2020, yaitu:

a. Kajian Mandiri

Kajian mandiri adalah penilaian internal oleh tim faskes menggunakan checklist 12 modul, seperti fasilitas fisik, kompetensi SDM, dan tingkat kunjungan ulang. Dilakukan minimal empat kali setahun, hasilnya direncanakan perbaikan dan dilaporkan ke tim jaga mutu kabupaten. Proses ini membangun budaya mutu mandiri di faskes.

b. **Penyeliaan Fasilitatif**

Penyeliaan fasilitatif adalah monitoring berjenjang oleh tim atas (Dinkes atau BKKBN) yang mengutamakan bimbingan teknis dan perbaikan sistem melalui observasi dan umpan balik. Dilakukan minimal sekali setahun per jenjang, dengan instrumen sama seperti kajian mandiri plus analisis *root cause*. Fokus pada komunikasi aktif dan orientasi perbaikan meningkatkan kinerja keseluruhan.

**E. Keselamatan Klien dan Audit Medik**

Keselamatan klien menjadi prioritas tertinggi dalam manajemen pelayanan Keluarga Berencana (KB), memastikan setiap tindakan klinis melindungi hak, kesehatan, dan otonomi peserta sesuai standar etika medis dan pedoman nasional. Prinsip informed choice, informed consent, audit medik, dan pencegahan infeksi membentuk kerangka pengelolaan risiko yang sistematis, mendukung target penurunan komplikasi dan kegagalan metode KB.

1. **Prinsip Keselamatan Klien dalam Pelayanan KB**

Keselamatan klien mencakup pencegahan cedera yang dapat dihindari, manajemen risiko klinis, dan respons cepat terhadap komplikasi, sesuai dengan kerangka patient safety Kementerian Kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan KB (faskes KB) wajib menerapkan protokol standar untuk tindakan invasif seperti pemasangan IUD, implan, suntikan hormon, serta prosedur bedah minor seperti vasektomi dan tubektomi. Pendekatan no-blame culture dalam audit medik mendorong pelaporan terbuka tanpa sanksi individu, fokus pada perbaikan sistem untuk mengurangi *insiden advers* (BKKBN, 2020; Kemenkes RI, 2028).

2. **Informed Choice dan Informed Consent**

Informed choice memungkinkan klien memilih metode KB berdasarkan pengetahuan lengkap tentang manfaat, risiko, alternatif, dan konsekuensi, tanpa paksaan atau bias petugas. Proses ini dilakukan melalui konseling individual menggunakan leaflet informasi, model anatomi, dan diskusi dua arah untuk memastikan pemahaman klien.

Untuk tindakan berisiko tinggi seperti suntik depot medroksiprogesteron, pemasangan IUD/implannya, serta vasektomi/tubektomi, informed consent tertulis wajib diperoleh setelah klien menandatangani formulir standar yang menjelaskan prosedur, komplikasi potensial (perdarahan, infeksi, kegagalan), dan hak menolak. Dokumen ini disimpan sebagai bagian rekam medis permanen dan dicatat di register pelayanan.

### 3. Audit Medik Pelayanan KB (AMP-KB)

Audit Medik Pelayanan KB merupakan tinjauan sistematis terhadap kasus komplikasi berat (perforasi uterus, abses injeksi, pendarahan hebat), kegagalan metode (kehamilan dengan IUD), dan drop-out dini melalui analisis rekam medis, wawancara klien, dan data kohort. Prinsip utama AMP-KB adalah no blaming culture, di mana diskusi tim multidisiplin (dokter, bidan, farmasis) mengidentifikasi faktor sistemik seperti pelatihan kurang, stok alokon kedaluwarsa, atau protokol infeksi lemah, bukan kesalahan individu. Hasil audit menghasilkan rencana perbaikan (action plan) dengan indikator kinerja terukur, seperti penurunan insiden infeksi <1% per kuartal. Proses dilakukan bulanan di Puskesmas dan kuartalan di tingkat kabupaten, dengan laporan ke Dinas Kesehatan dan BKKBN untuk agregasi nasional (BKKBN, 2020).

### 4. Pencegahan Infeksi dan Kewaspadaan Standar

Manajemen fasilitas wajib menerapkan standard precaution secara universal untuk pencegahan kontaminasi silang pada setiap kontak dengan darah, cairan tubuh, atau mukosa klien. Cuci tangan dengan sabun antiseptik atau hand sanitizer alkohol 70% merupakan intervensi paling efektif, dilakukan sebelum kontak bersih, setelah kontak kotor, dan usai prosedur invasif. Penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap, sarung tangan steril untuk prosedur aseptik, sarung tangan pemeriksaan untuk konseling/vagina, masker bedah, dan pelindung wajah/splash guard untuk risiko percikan (wajib dipatuhi).

Pengelolaan limbah tajam (jarum suntik, skalpel IUD) dilakukan dalam wadah tahan tusuk berlabel "Bahaya Tajam", dibuang terpisah, dan dimusnahkan oleh layanan Dinas Lingkungan Hidup. Protokol ini mengurangi risiko infeksi nosokomial seperti HIV, hepatitis B/C pada petugas dan klien.

## F. Aktivitas 1 — *Knows How* (Orientasi & Analisis Kasus)

### 1. Skenario:

Sebuah Puskesmas di wilayah DTPK mengalami keterlambatan distribusi suntikan progestin karena kendala transportasi, sementara terdapat 40 akseptor terjadwal kunjungan ulang minggu depan.

### 2. Tugas Diskusi:

Mahasiswa mengidentifikasi risiko *drop-out*, menghitung kebutuhan darurat dengan rumus SCM (*Supply Chain Management*), dan merancang strategi eskalasi kepada dinas terkait untuk menghindari kegagalan program.

### Rubrik Analisis Soal Kasus Aktivitas 1 — Knows How

Rubrik ini dirancang untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam orientasi dan analisis kasus skenario Puskesmas dengan keterlambatan suntikan progestin, sesuai level Knows How pada OBE kebidanan. Penilaian fokus pada identifikasi risiko, perhitungan kebutuhan darurat menggunakan rumus SCM (Supply Chain Management), dan strategi eskalasi.

#### Kompetensi 1: Identifikasi Risiko Drop-Out

| Komponen yang Dinilai                                                                                      | Skor 3 (Lengkap)                                                                                       | Skor 2 (Cukup)                             | Skor 1 (Kurang)                 | Skor 0    | Skor                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| Mengidentifikasi risiko drop-out akseptor KB (misal: kehamilan tidak direncanakan, kegagalan program DTPK) | Semua risiko utama disebutkan dengan justifikasi data skenario (40 akseptor, keterlambatan distribusi) | 2-3 risiko disebutkan, justifikasi parsial | 1 risiko atau tanpa justifikasi | Tidak ada |                     |
| Menghubungkan dengan dampak program KB progestin depot                                                     | Dampak jangka pendek/panjang dijelaskan jelas                                                          | Dampak disebutkan umum                     | Dampak tidak spesifik           | Tidak ada |                     |
| <b>Skoring Kompetensi 1</b>                                                                                | 2 dari 2                                                                                               | 1-2 dari 2                                 | 1 dari 2                        | 0         | <b>Total: ___/6</b> |

#### Kompetensi 2: Perhitungan Kebutuhan Darurat dengan Rumus SCM (*Supply Chain Management*)

| Komponen yang Dinilai                                                                                                                                      | Skor 3 (Lengkap)                                                                  | Skor 2 (Cukup)                           | Skor 1 (Kurang)            | Skor 0    | Skor                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| Menghitung kebutuhan suntikan progestin darurat (misal: dosis minimal 40 akseptor × interval, stok cadangan SCM: Demand = Lead Time Demand + Safety Stock) | Rumus SCM diterapkan benar, hitungan akurat (contoh: 40 ampul + buffer transport) | Rumus disebutkan, hitungan parsial benar | Rumus salah/hitungan salah | Tidak ada |                     |
| Menjelaskan asumsi SCM (lead time transport, safety stock untuk drop-out)                                                                                  | Asumsi realistis berdasarkan skenario                                             | Asumsi umum                              | Asumsi tidak relevan       | Tidak ada |                     |
| <b>Skoring Kompetensi 2</b>                                                                                                                                | 2 dari 2                                                                          | 1-2 dari 2                               | 1 dari 2                   | 0         | <b>Total: ___/6</b> |

### Kompetensi 3: Strategi Eskalasi kepada Dinas Terkait

| Komponen yang Dinilai                                                                                   | Skor 3 (Lengkap)                                                                 | Skor 2 (Cukup)              | Skor 1 (Kurang)                     | Skor 0    | Skor                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| Merancang strategi eskalasi (misal: laporan darurat, alternatif distribusi, koordinasi dinas kesehatan) | Strategi lengkap, bertahap (internal-external), dengan timeline dan KIE akseptor | Strategi 2-3 langkah, logis | Strategi 1 langkah atau tidak jelas | Tidak ada |                     |
| Menghubungkan dengan pencegahan kegagalan program KB                                                    | Hubungan kausal jelas ke outcome program                                         | Hubungan umum               | Tidak dihubungkan                   | Tidak ada |                     |
| <b>Skoring Kompetensi 3</b>                                                                             | 2 dari 2                                                                         | 1-2 dari 2                  | 1 dari 2                            | 0         | <b>Total: ___/6</b> |

#### Total Skor dan Kriteria Kelulusan

Total Skor : \_\_\_ / 18

**Lulus ( $\geq 12$ )** : Analisis komprehensif, siap diskusi kelompok.

**Borderline (9-11)** : Dasar baik, perlu perbaikan detail.

**Remedial ( $<9$ )** : Kurang pemahaman konsep, ulang aktivitas.

**Catatan Penguji** : \_\_\_\_\_

**Tanggal & Tanda Tangan:** \_\_\_\_\_

### G. Aktivitas 2 — *Does* (Proyek Manajemen Layanan)

Proyek ini dirancang sebagai aktivitas autentik "*Does*" (level 4 Miller's Pyramid) dengan durasi 4 minggu (8 JP), kelompok 4-5 orang. Fokus pada 2 indikator penilaian dengan rubrik skala 1-4. Proyek mencakup desain alur layanan-logistik, pencatatan-pelaporan, dan audit dokumen, diakhiri presentasi. Tujuannya membuktikan kompetensi manajemen layanan KB yang aman, akurat, dan berorientasi pasien.

#### Latar Belakang Proyek

Mahasiswa mampu merancang sistem manajemen layanan KB Puskesmas (simulasi 100 klien/bulan) yang traceable, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan sesuai Permenkes No. 97/2021 tentang KB dan standar BKKBN.

## Komponen Proyek

Proyek dibagi menjadi 2 deliverables utama untuk memastikan kelengkapan dan operasionalisasi indikator.

### 1. Desain Alur Layanan & Logistik

Buat flowchart alur layanan logistik KB (FEFO: First Expiry First Out) dan SOP layanan satu atap.

- a. Langkah: Identifikasi stok (misal: 50 IUD Copper T batch no. A123 exp. 03/2027), alur distribusi, verifikasi batch saat layanan.
- b. Dokumen: Flowchart Visio/PowerPoint + SOP 5 halaman (termasuk checklist red flags: anemia berat, infeksi aktif).
- c. Penilaian Indikator 1: Skor 4 jika alur lengkap (penerimaan-stok-pelayanan-pelaporan), akurat (batch traceable), dan mendukung keputusan (alert stok minimum).

### 2. Pencatatan-Pelaporan

Rancang template Register Kohort KB digital (Excel/Google Sheets) dan laporan bulanan.

- a. Langkah: Isi simulasi 20 klien (data: nama, GPA, metode KB, batch alokon). Hitung akurasi: K/IV/KB sinkron 100%.
- b. Dokumen: Register Kohort (kolom: ID Klien, Batch IUD, Tanggal Pasang, Red Flags) + Laporan Bulanan (cakupan KB 85%, stok akhir).
- c. Penilaian Indikator 1: Skor 4 jika data sangat lengkap/konsisten, traceable via batch, dan laporan mendukung reorder stok.

## Instruksi Pelaksanaan

1. Minggu 1: Studi literatur (Permenkes KB, Standar Mutu BKBK) + kunjungi Puskesmas (observasi logistik).
2. Minggu 2-3: Desain dokumen + simulasi data 20 klien.
3. Minggu 4: Audit internal kelompok + presentasi 15 menit (PowerPoint 15 slide: Latar Belakang, Alur/Logistik, Pencatatan, Audit Findings, Rekomendasi)

Audit Dokumen: Setiap kelompok audit 2 kelompok lain (peer-review) menggunakan rubrik. Identifikasi gap (misal: batch hilang = skor 1) dan saran perbaikan.

Rubrik Penilaian Proyek (Skala 1-4 per Indikator)

| Indikator                                               | Deskripsi Rubrik                   | Skor 1 (Kurang)                     | Skor 2 (Cukup)               | Skor 3 (Baik)              | Skor 4 (Sangat Baik)                        | Bobot | Skor Kelompok |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Kelengkapan Desain Alur &amp; Akurasi Pencatatan</b> | Alur logistik dan register/laporan | Banyak data hilang; tidak traceable | Cukup lengkap, ada kesalahan | Lengkap, akurat, traceable | Sangat lengkap, konsisten; dukung keputusan | 100%  |               |

Bukti/ Hasil Produk : Proposal/proyek; hasil audit; slide presentasi

Proyek ini membangun kompetensi OBE: manajemen logistik akurat, pelaporan tepat waktu, mutu pasien-centered, dan audit berkelanjutan—siap diterapkan di lapangan KB nasional.

Asesmen dan Evaluasi (Piramida Miller)

| Level Miller     | Metode Asesmen                                          | Instrumen                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Knows How</b> | Orientasi & Analisis Kasus                              | Lembar Kasus & Rubrik Analisis                         |
| <b>Does</b>      | DOPS ( <i>Direct Observation of Procedural Skills</i> ) | Proyek manajemen layanan, presentasi dan audit dokumen |

## H. Ringkasan Materi

Manajemen pelayanan KB adalah sinergi antara ketepatan logistik, akuntabilitas data, dan standar mutu yang berpusat pada klien. Keberhasilan seorang bidan tidak hanya diukur dari keterampilan klinis, tetapi juga kemampuannya dalam mengelola sistem yang menjamin keselamatan setiap individu.

**Tabel 6.1**

**Checklist Refleksi Mahasiswa: Kompetensi Manajemen Pelayanan KB**

Checklist ini dirancang untuk refleksi diri mahasiswa pasca-proyek layanan logistik KB, membuktikan capaian pembelajaran OBE level "Does". Mahasiswa beri tanda centang (✓) pada kolom "Sudah" jika kompeten mandiri, beri catatan spesifik pada area yang masih perlu perbaikan.

| No                                   | Pernyataan Refleksi Kompetensi                                                                                                                                           | Sudah (✓)                | Belum                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Perencanaan Kebutuhan Alokasi</b> |                                                                                                                                                                          |                          |                          |
| 1                                    | Saya mampu menghitung kebutuhan tahunan alokasi dengan rumus yang tepat ( $\text{Cakupan} \times \text{Method Mix} \times \text{CPR} \times \text{Faktor Pemborosan}$ ). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manajemen Gudang</b>              |                                                                                                                                                                          |                          |                          |

|                                   |                                                                                                                 |                          |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2                                 | Saya memahami standar penyimpanan alokon untuk menjaga stabilitas hormon (Suhu 15-25°C, FEFO, kelembaban <60%). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pencatatan &amp; Pelaporan</b> |                                                                                                                 |                          |                          |
| 3                                 | Saya bisa membedakan fungsi K/I/KB, K/IV/KB, dan Register Kohort secara tepat.                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                                 | Saya berkomitmen mematuhi tenggat pelaporan bulanan (Tanggal 5 dan 10 setiap bulan).                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Budaya Keselamatan</b>         |                                                                                                                 |                          |                          |
| 5                                 | Saya memahami prinsip No Blaming Culture dalam AMP-KB yang melibatkan tim multidisiplin.                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manajemen Risiko</b>           |                                                                                                                 |                          |                          |
| 6                                 | Saya mampu melakukan eskalasi saat menemukan Red Flags pada klien                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Penilaian Refleksi

| Kriteria                   | Bobot       | Skor (0-4)             | Catatan Dosen |
|----------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Kelengkapan (6/6 item ✓)   | 40%         |                        |               |
| Kualitas Evidence Spesifik | 40%         |                        |               |
| Rencana Perbaikan Jelas    | 20%         |                        |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>100%</b> | <b>≥3.5 = Kompeten</b> |               |

### Refleksi Tambahan Mahasiswa (Wajib)

1. Kekuatan Pribadi: Apa yang sudah saya kuasai dengan baik dari proyek ini?
2. Area Perbaikan: Kompetensi mana yang masih perlu bimbingan tambahan?
3. Action Plan: Langkah konkret apa yang akan saya lakukan minggu depan?

### I. Referensi

- BKKBN. (2020). Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. (2023). Mekanisme Pelaporan Fasilitas Pelayanan KB. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. (2023). Standar Data Statistik Pelayanan KB. Jakarta: BKKBN.
- Buntoro, K., dkk. (2021). Manajemen logistik obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. *Jambi Accounting Review*, 2(1), 45–56.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Keselamatan Pasien.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Register Kohort Ibu Tahun 2020. Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

- Kementerian Kesehatan RI. (2025). Penguatan ketahanan kesehatan dalam implementasi RPJMN 2025–2029. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Neliti Media. (2022). Buku Ajar Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Neliti.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Bappenas.
- Pratiwi, D.A. (2020). Manfaat sistem logistik kontrasepsi yang terintegrasi terhadap jaminan ketersediaan kontrasepsi di Puskesmas. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Repository Binawan. (2023). Etika dan Keselamatan Pasien dalam Pelayanan KB. Jakarta: Universitas Binawan.
- STIKES Bina Cipta Mulia. (2022). Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana. Pekalongan: STIKES BCM.
- UNFPA Indonesia & BKKBN. (2020). Strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berbasis Hak di Indonesia. Jakarta: UNFPA.
- Universitas Diponegoro. (2022). Pedoman Manajemen Pelayanan KB: Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan. Semarang: Undip

# PROFIL PENULIS



**Nevia Zulfatunnisa, SSiT., M.Kes., M.Keb.,** Lahir di Sukoharjo, 29 November 1994. menyelesaikan Pendidikan DIV Bidan Pendidik di Universitas Ngudi Waluyo Tahun 2008, S2 Magister Kesehatan di Program Studi Kedokteran Keluarga Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2016. Kemudian di Tahun 2024 menyelesaikan studi S2 Kebidannann Di Stikes Gunna Bangsa Jogjakarta. Saat ini Penulis bekerja menjadi dosen di program studi profesi bidan di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta menngampu mata kuliah Asuhan Kehamilan, Asuhan Pranikah daa Prakonsepsi, Evidance based Practise, . Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku ajar diberbagai penerbit buku, aktif publikasi di jurnnl penelitian maupu pengabdian kepada masyarakat terakreditasi dan pernah mendpaatkan dana hibah penelitian maupun PKM DRTPM maupun Kemendiktisaintek. Selain itu juga aktif mengikuti seminnar nasional maupun international yang mendukung profesi Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [nevia.zulfa@umpku.ac.id](mailto:nevia.zulfa@umpku.ac.id)



**Bd. Nur Aliyah Rangkuti, S.Keb., M.KM.,** lahir pada tanggal 27 Agustus 1988 di Panyabungan-Mandailing Natal. Anak pertama dari Bapak Alm. H. Ali Hamzah, MM dan Ibu Hj. Mamnah, S.Pd. Penulis merupakan dosepe tetap Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga Fakultas Kesehatan Universitas Aupa Royhan Di Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2018. Selain menjadi dosen tetap penulis juga aktif dalam membuat buku sebagai sumbangsih untuk dunia pendidikan. Penulis juga merupakan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

# PROFIL PENULIS



**Widya Rahayu S.Tr.Keb.,M.Keb** Lahir di Bekasi, 12 Januari 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi kebidanan, Di STIKES Muhammadiyah Manado lulus di tahun 2016, DIV Bidan Pendidik di Universitas Muhammadiyah Gorontalo lulus di tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 bekerja selama 5 tahun di RS Tk III Robert Wolter Mongisidi Manado. Saat ini penulis bekerja di STIKES RSPAD Gatot Soebroto mengampu mata kuliah Evidence Based Dalam Praktik Kebidanan, Farmakologi, Konsep Herbal Kebidanan dan Komplementer Kehamilan. Penulis mempunyai beberapa publikasi yang terindex sinta 2 dan 4, kegemaran penulis dalam menulis buku ajar dan sudah mempunyai buku ajar yang telah publis. Semoga buku ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penulisan "Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [widya@stikesrspadgs.ac.id](mailto:widya@stikesrspadgs.ac.id) Motto: "*Mendampingi perempuan dengan ilmu, menguatkan mereka dengan empati di setiap fase kehidupan.*"



**Ana Lestari, S.ST., M.Kes.,** Lahir di Sumbawa pada tanggal 27 Agustus 1993, telah menyelesaikan studi DIV Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta tahun 2016 dan S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia tahun 2019. Kemudian mengajar di STIKES Griya Husada Sumbawa, dan sejak itu mendalami mengajar di Prodi D3 Kebidanan hingga sekarang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi artikel di berbagai jurnal ilmiah dan menulis buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [analestari674@gmail.com](mailto:analestari674@gmail.com). Motto: "Pendidikan adalah investasi terbaik"

# PROFIL PENULIS



**Agustina Maratus Sholichah, SST., M.Kes.,** Penulis yang lahir di Sukoharjo ini memiliki ketertarikan terhadap kebidanan sejak tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dengan memilih Jurusan DIII Kebidanan kemudian dilanjutkan ke D-IV Bidan Pendidik dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis memulai karir sebagai bidan di kota Surakarta sejak tahun 2014 hingga 2015, kemudian melanjutkan pendidikan ke S-2 Ilmu Kesehatan Reproduksi Universitas Airlangga Surabaya dan berhasil lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis juga aktif sebagai anggota di organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Surabaya. Beberapa penelitian telah dihasilkan oleh peneliti di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi. Selain itu penulis juga telah memiliki karya buku tentang kesehatan reproduksi. Email Penulis: [agustina@poltekkes-surabaya.ac.id](mailto:agustina@poltekkes-surabaya.ac.id)

## Sinopsis

Buku ajar “Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping” disusun sebagai sumber pembelajaran yang membahas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, sistematis, dan aplikatif. Buku ini menekankan pentingnya pelayanan KB yang berpusat pada klien, berbasis kebutuhan individu, menjunjung hak reproduksi, serta memperhatikan keamanan, efektivitas, dan mutu pelayanan.

Materi dalam buku ini menguraikan berbagai aspek penting dalam pelayanan kontrasepsi, dimulai dari kontrasepsi dalam rahim atau AKDR/IUD, meliputi seleksi klien, prosedur pelayanan, konseling sebelum dan sesudah pemasangan, serta upaya pencegahan komplikasi. Pembahasan dilanjutkan dengan kontrasepsi pascapersalinan dan pasca keguguran, termasuk waktu pemberian yang tepat, pertimbangan masa laktasi, pemilihan metode yang sesuai, serta tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan penggunaan kontrasepsi.

Buku ini juga membahas penanganan efek samping dan komplikasi KB, seperti perdarahan tidak teratur, nyeri, keluhan yang sering muncul, serta tanda bahaya yang membutuhkan penatalaksanaan atau rujukan segera. Selain itu, dibahas pula penggunaan kontrasepsi pada kondisi khusus, seperti remaja, perempuan perimenopause, klien dengan penyakit kronis, dan kelompok dengan risiko tinggi, sehingga pembaca mampu memahami pentingnya penilaian kelayakan metode berdasarkan kondisi kesehatan dan kebutuhan reproduksi masing-masing klien.

Aspek pencegahan infeksi menular seksual dan HIV dalam pelayanan KB turut menjadi bagian penting dalam buku ini. Pembaca diarahkan untuk memahami skrining risiko, edukasi pencegahan, penggunaan metode perlindungan ganda, serta mekanisme rujukan yang tepat. Tidak hanya membahas aspek klinis, buku ini juga memuat manajemen pelayanan KB, meliputi pengelolaan logistik, pencatatan dan pelaporan, peningkatan mutu, serta keselamatan klien dalam pelayanan.

Dengan penyajian materi yang runtut dan mudah dipahami, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan praktisi kebidanan dalam mempelajari serta menerapkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Buku ajar “Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping” disusun sebagai sumber pembelajaran yang membahas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, sistematis, dan aplikatif. Buku ini menekankan pentingnya pelayanan KB yang berpusat pada klien, berbasis kebutuhan individu, menjunjung hak reproduksi, serta memperhatikan keamanan, efektivitas, dan mutu pelayanan.

Materi dalam buku ini menguraikan berbagai aspek penting dalam pelayanan kontrasepsi, dimulai dari kontrasepsi dalam rahim atau AKDR/IUD, meliputi seleksi klien, prosedur pelayanan, konseling sebelum dan sesudah pemasangan, serta upaya pencegahan komplikasi. Pembahasan dilanjutkan dengan kontrasepsi pascapersalinan dan pasca keguguran, termasuk waktu pemberian yang tepat, pertimbangan masa laktasi, pemilihan metode yang sesuai, serta tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan penggunaan kontrasepsi.

Buku ini juga membahas penanganan efek samping dan komplikasi KB, seperti perdarahan tidak teratur, nyeri, keluhan yang sering muncul, serta tanda bahaya yang membutuhkan penatalaksanaan atau rujukan segera. Selain itu, dibahas pula penggunaan kontrasepsi pada kondisi khusus, seperti remaja, perempuan perimenopause, klien dengan penyakit kronis, dan kelompok dengan risiko tinggi, sehingga pembaca mampu memahami pentingnya penilaian kelayakan metode berdasarkan kondisi kesehatan dan kebutuhan reproduksi masing-masing klien.

Aspek pencegahan infeksi menular seksual dan HIV dalam pelayanan KB turut menjadi bagian penting dalam buku ini. Pembaca diarahkan untuk memahami skrining risiko, edukasi pencegahan, penggunaan metode perlindungan ganda, serta mekanisme rujukan yang tepat. Tidak hanya membahas aspek klinis, buku ini juga memuat manajemen pelayanan KB, meliputi pengelolaan logistik, pencatatan dan pelaporan, peningkatan mutu, serta keselamatan klien dalam pelayanan.

Dengan penyajian materi yang runtut dan mudah dipahami, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan praktisi kebidanan dalam mempelajari serta menerapkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerbit:

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-16-3 (PDF)



9

786347

927163

